

Buku Referensi

DETEKSI DINI DAN KOMPLIKASI DALAM KEBIDANAN

Pendekatan Pranikah dan Prakonsepsi

Bdn. Elis Fatmawati, SST., M.Tr.Keb., CHt.HBirth

Bdn. Nur Ummul Khairat, S.Tr.Keb., M.Keb.

Nur Fadjri Nilakesuma, Bd., M.Keb.

Anita Dewi Anggraini, S.Keb., Bd., M.Kes.

Evi Yanti, SKM., M.Kes.

Bayti Jannah, S.Tr.Keb. M.Keb.



Buku Referensi:

Deteksi Dini dan Komplikasi Dalam Kebidanan

Pendekatan Pranikah dan Prakonsepsi

Bdn. Elis Fatmawati, SST., M.Tr.Keb., CHt.HBirth

Bdn. Nur Ummul Khairat, S.Tr.Keb., M.Keb.

Nur Fadjri Nilakesuma, Bd., M.Keb.

Anita Dewi Anggraini, S.Keb., Bd., M.Kes.

Evi Yanti, SKM.,M.Kes.

Bayti Jannah, S.Tr.Keb. M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi:

Deteksi Dini dan Komplikasi Dalam Kebidanan Pendekatan Pranikah dan Prakonsepsi

Penulis: Bdn. Elis Fatmawati, SST., M.Tr.Keb., CHt.HBirth.
Bdn. Nur Ummul Khairat, S.Tr.Keb., M.Keb.
Nur Fadjri Nilakesuma, Bd., M.Keb.
Anita Dewi Anggraini, S.Keb., Bd., M.Kes.
Evi Yanti, SKM.,M.Kes.
Bayti Jannah, S.Tr.Keb. M.Keb.

ISBN : 978-634-7426-30-7
Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
*All Right Reserved***

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @bimbelukomoptimal
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan buku referensi “Deteksi Dini dan Patologis dalam Siklus Pranikah dan Prakonsepsi”. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkuat peran bidan dan tenaga kesehatan dalam mempersiapkan pasangan menuju kehamilan yang sehat dan berkualitas melalui deteksi dini, edukasi, serta intervensi komprehensif pada fase pranikah dan prakonsepsi.

Buku ini disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan promotif, preventif, dan deteksi dini berbasis *evidence-based practice*. Materi mencakup konsep asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, pemeriksaan status kesehatan umum dan penyakit kronis, deteksi dini anemia dan gangguan gizi, gangguan menstruasi dan kesuburan, masalah psikologis serta kesehatan mental, hingga dampak pernikahan dini terhadap kehamilan.

Kami berharap buku ini menjadi panduan ilmiah dan praktis bagi dosen, mahasiswa kebidanan, serta praktisi kesehatan dalam memberikan pelayanan pranikah dan prakonsepsi yang terintegrasi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan naskah ini.

Semoga buku ini memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan turut mendukung penurunan angka morbiditas serta mortalitas ibu dan bayi di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2025

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata	iv
Daftar Isi	v

BAB 1 Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi.....	1
A. Memahami Awal: Persiapan Sehat Sebelum Menikah dan Hamil.....	1
B. Edukasi dan Konseling Pranikah dan Prakonsepsi.....	2
C. Peran Konseling Dalam Deteksi Dini Komplikasi	6
D. Model dan Pendekatan Konseling Kesehatan Reproduksi.....	8
E. Penerapan Edukasi Berbasis Keluarga dan Komunitas	8
F. Penutup.....	10
Referensi.....	11
Glosarium	12

BAB 2 Deteksi Dini Status Kesehatan Umum dan Penyakit Kronis	15
A. Menjaga Kesehatan Sebelum Terlambat	15
B. Pemeriksaan Kesehatan	16
C. Deteksi Dini Penyakit	19
D. Skrining Penyakit.....	25
E. Penutup.....	30
Referensi.....	30
Glosarium	34

BAB 3 Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi.....	36
A. Pentingnya Deteksi Dini Anemia	36
B. Anemia Defisiensi Besi, Asam Folat, dan Vitamin B12	37
C. Deteksi Dini Obesitas dan Malnutrisi Prakonsepsi	40
D. Intervensi Gizi Seimbang dan Suplementasi Prakonsepsi	44
E. Penutup.....	51
Referensi.....	51
Glosarium	53

BAB 4 Deteksi Dini Gangguan Menstruasi dan Kesuburan	55
A. Mengenai Gangguan Menstruasi dan Kesuburan	55
B. Jenis -jenis Gangguan Menstruasi pada Wanita	57
C. Deteksi Dini Gangguan Cemas dan Perubahan Suasana Hati	62
D. Skrining Kesehatan Mental dan Edukasi <i>Coping Stress</i>	65
E. Penutup.....	68

Referensi.....	69
Glosarium	71

BAB 5 Deteksi Dini Masalah Psikologis dan Kesehatan Mental 73

A. Mengenal Masalah Psikologis dan Kesehatan Mental Prakonsepsi	73
B. Identifikasi Depresi.....	74
C. Identifikasi Kecemasan.....	75
D. Penyebab Stres Pranikah	77
E. Konseling Prakonsepsi.....	79
F. Deteksi Dini Risiko Gangguan <i>Mood</i> dan Intervensi Awal	80
Referensi.....	82
Glosarium	83

BAB 6 Deteksi Dini Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Kehamilan 86

A. Pernikahan Dini dan Kesehatan Ibu.....	86
B. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini	87
C. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehamilan.....	88
D. Upaya Mengatasi Pernikahan Dini	93
E. Strategi Pencegahan Pernikahan Dini	94
F. Intervensi Menekan Angka Pernikahan Dini.....	99
G. Penutup.....	100
Referensi.....	101
Glosarium	102

Profil Penulis 105

A background image showing a woman's hands holding a bouquet of white flowers, including roses and smaller blossoms, with greenery. The image is slightly faded to serve as a background for the text.

BAB 1

Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi

A. Memahami Awal: Persiapan Sehat Sebelum Menikah dan Hamil

Kesehatan reproduksi merupakan fondasi penting bagi perempuan usia subur dan pasangan yang merencanakan kehamilan. Periode pranikah dan prakonsepsi adalah jendela emas untuk membangun kesiapan biologis, psikologis, dan sosial. Tahap ini sering terlewatkan, padahal sangat menentukan kualitas kehamilan dan masa nifas. Pada fase ini, edukasi dan konseling kebidanan berperan sebagai strategi promotif dan preventif untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, dan mendorong partisipasi aktif pasangan dalam pengambilan keputusan kesehatan yang bertanggung jawab (Anggraini et al., 2023).

Ruang lingkup konseling pranikah dan prakonsepsi mencakup penilaian faktor risiko seperti riwayat penyakit kronis, riwayat obstetri, usia, indeks massa tubuh, tekanan darah, dan status gizi. Tindakan lain meliputi skrining infeksi menular seksual, penguatan imunisasi yang relevan, serta optimalisasi gaya hidup melalui pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, penghentian merokok, dan bebas alkohol atau NAPZA. Bidan juga menekankan suplementasi mikronutrien kunci seperti asam folat, perencanaan jarak kehamilan, kesiapan finansial, serta dukungan keluarga. Keterlibatan calon suami menjadi bagian integral untuk memastikan dukungan emosional dan praktik kesehatan yang konsisten di rumah.

Konseling yang efektif, didukung komunikasi empatik, pendekatan berpusat pada klien, dan sensitivitas budaya, memfasilitasi deteksi dini serta rujukan tepat waktu sehingga intervensi dapat diberikan lebih awal untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi.

Implementasinya dapat diintegrasikan di layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, di komunitas, maupun melalui kanal digital agar jangkauan lebih luas dan pemantauan berkelanjutan. Dengan demikian, kesiapan pasangan meningkat, risiko kehamilan dapat diminimalkan, dan perjalanan menuju peran orang tua berlangsung lebih aman dan bermakna (Anggraini et al., 2023).

B. Edukasi dan Konseling Pranikah dan Prakonsepsi

1. Pengertian Pranikah dan Prakonsepsi

Fase pranikah adalah periode penting dalam kehidupan individu sebelum memasuki pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Sementara itu, prakonsepsi merujuk pada masa sebelum terjadinya kehamilan yang merupakan kesempatan strategis untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi. Keduanya merupakan momen penting yang memungkinkan edukasi kesehatan dan konseling dilakukan secara optimal.

2. Tujuan Edukasi dan Konseling Pranikah & Prakonsepsi

- a. Meningkatkan pemahaman calon pasangan tentang kesehatan reproduksi, termasuk fungsi dan siklus reproduksi.
- b. Mencegah kehamilan berisiko tinggi melalui skrining awal terhadap faktor risiko medis.
- c. Menyaring penyakit menular seksual seperti HIV, Hepatitis B, dan sifilis.
- d. Membantu pasangan dalam membuat keputusan sadar dan bertanggung jawab terhadap perencanaan keluarga.

3. Materi Konseling Pranikah & Prakonsepsi

- a. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

1) Anatomi Sistem Reproduksi Wanita

Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi organ luar (eksternal) dan dalam (internal). (Ayudia & Putri, 2021)

a) Organ Eksternal (Vulva)

- (1) Mons pubis: Jaringan lemak di atas tulang kemaluan.
- (2) Labia majora dan labia minora: Lipatan kulit yang melindungi organ genital.
- (3) Klitoris: Organ kecil yang sangat sensitif, berperan dalam kenikmatan seksual.
- (4) Meatus uretra: Lubang tempat keluarnya urin.
- (5) Introitus vagina: Pintu masuk ke vagina.

b) Organ Internal

- (1) Vagina: Saluran otot elastis yang menghubungkan rahim dengan luar tubuh; tempat masuknya penis saat berhubungan seksual dan jalan lahir saat persalinan.
- (2) Serviks: Leher rahim, bagian sempit yang menghubungkan vagina dengan rahim.
- (3) Uterus (rahim): Organ berotot tempat berkembangnya janin. Terbagi menjadi fundus, korpus, dan serviks.
- (4) Tuba falopii (saluran telur): Menghubungkan ovarium dengan uterus; tempat terjadinya fertilisasi.
- (5) Ovarium (indung telur): Menghasilkan ovum (sel telur) dan hormon (estrogen dan progesteron).

2) Fisiologi Sistem Reproduksi Wanita

a) Siklus Menstruasi

Siklus ini berlangsung rata-rata 28 hari dan dibagi menjadi 3 fase:

- 1) Fase menstruasi (hari 1–5): Peluruhan dinding endometrium jika tidak terjadi pembuahan.
- 2) Fase proliferasif/folikular (hari 6–14): Pertumbuhan folikel di ovarium; peningkatan estrogen.
- 3) Fase luteal (hari 15–28): Setelah ovulasi, korpus luteum menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan endometrium menyambut implantasi.

b) Ovulasi

Terjadi sekitar hari ke-14; pelepasan ovum matang dari ovarium ke tuba falopii.

c) Fertilisasi dan Kehamilan

Jika sperma membuahi sel telur, zigot akan terbentuk dan bergerak ke uterus untuk implantasi dan perkembangan embrio.

b. Gaya Hidup Sehat: Nutrisi, Olahraga, dan Pengendalian Stres

- 1) Dalam hal pemenuhan nutrisi sangat penting dilakukan dalam rangka memastikan calon ibu telah mencapai status gizi yang baik sebelum menjalani masa kehamilan. Terlebih dahulu dilakukan pengukuran status gizi Wanita, selanjutnya bidan akan menghitung IMT yang akan dijadikan dasar dalam memberikan konseling nutrisi yang seimbang. Calon pengantin akan di edukasi mengenai pentingnya mengonsumsi asam folat dalam rangka mencegah kekurangan asam folat yang bisa mengakibatkan gangguan saat masa organogenesis.

- 2) Mempertahankan kebugaran fisik melalui olahraga secara rutin. Seorang Wanita yang akan menjalani proses kehamilan melakukan olahraga yang cukup selama periode kontrol. Aktivitas fisik yang dimaksud tidak harus dilaksanakan dengan durasi panjang hingga berjam-jam. Cukup dilakukan 3 kali sepekan selama 1/2 jam dan dengan teratur. Selain kesehatan, olahraga juga mencegah perkembangan obesitas. Wanita yang sehat secara fisik pada masa kehamilan dianjurkan memiliki status gizi normal.
- 3) Kesehatan mental yang baik sangat penting selama kehamilan. Perempuan sebaiknya mempertimbangkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau terapi perilaku kognitif untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental (Aprianti et al., 2025)

c. Imunisasi, Pemeriksaan Laboratorium, dan Status

1) Imunisasi

Imunisasi TT adalah program wajib bagi calon pengantin yang menjadi syarat pendaftaran pernikahan. Ini dilakukan sebagai usaha pencegahan kasus tetanus neonatorum.

Tabel 1.1 Imunisasi Tetanus

Status Imunisasi	Interval Minimal Pemberian	Masa perlindungan
T1	-	-
T2	4 minggu sesudah T1	3 tahun
T3	6 bulan sesudah T2	5 tahun
T4	1 tahun sesudah T3	10 tahun
T5	1 tahun sesudah T4	Lebih dari 25 tahun

Sumber: (Laily et al., 2025)

2) Pemeriksaan Laboratorium

- a) Hb, Trombosit Lekosit
- b) Golongan Darah dan Rhesus
- c) Gula Darah Sewaktu (GDS)
- d) Thalasemia
- e) Hepatitis B & C
- f) Torch
- g) Pemeriksaan Urin

d. Kesehatan Psikologis dan Kesiapan Emosional untuk Menjadi Orang Tua

Peran seorang ibu dalam masa kehamilan membutuhkan dukungan dari keluarga, sosial dan tenaga kesehatan. Asuhan yang terintegrasi baik fisik dan psikologis yaitu penerimaan perilakunya, partnership, dan konseling. Deteksi dini dengan asuhan yang terintegrasi dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku psikologis. Dalam pencapaian peran tersebut keterlibatan suami, keluarga dan lingkungannya sangat berpengaruh. Dukungan dari orang-orang terdekatnya membantu dalam proses adaptasi masa kehamilan (Tambunan et al., 2024)

Motivasi pasangan untuk merencanakan kehamilan dengan baik termasuk dalam periode prakonsepsi sangat menguntungkan dalam hal persiapan kesehatan suami istri baik fisik dan mental, ekonomi, serta pengendalian kelahiran dimasa depan (Jack and Culpepper, 1990). Keluarga merupakan pondasi penting masyarakat. Keluarga sebagai penerus generasi, pemberi kasih sayang dan pendidikan bagi anak-anak, sosialisasi dan internalisasi beragam nilai (sosial, religi, moral, pengetahuan, seni). Apabila keluarga menjalankan fungsi seperti yang diharapkan, keluarga akan melahirkan individu yang kuat untuk mengenal diri dan lingkungannya (Kostania et al., 2020)

4. Peran Bidan Dalam Konseling Pranikah

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi pranikah dan prakonsepsi melalui pendekatan empatik dan profesional. Bidan juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara individu, pasangan, dan fasilitas layanan Kesehatan (Kostania et al., 2020)

C. Peran Konseling Dalam Deteksi Dini Komplikasi

1. Pengertian Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan proses pengenalan gejala atau kondisi kesehatan yang berpotensi menjadi komplikasi secara lebih awal. Tujuannya adalah untuk memungkinkan intervensi segera sebelum kondisi menjadi berat (Wulandari, n.d.)

2. Komplikasi yang dapat Dideteksi Dini Melalui Konseling

Pernikahan adalah awal dari pembentukan keluarga, jadi sebelum calon pengantin melakukan pernikahan, perlu untuk mempersiapkan kondisi kesehatannya untuk melaksanakan tugas reproduksi dengan cara yang sehat dan aman mulai dari kehamilan yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi berikutnya yang sehat dan menciptakan keluarga yang sehat, keluarga yang makmur dan berkualitas.

Komplikasi yang dapat terjadi antara lain:

- a. Preeklamsia: Tekanan darah tinggi disertai proteinuria
- b. Anemia: Kekurangan zat besi yang mempengaruhi pertumbuhan janin.
- c. Infeksi TORCH: Infeksi seperti toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes.
- d. Diabetes Gestasional: Kadar gula darah tinggi selama kehamilan.

3. Teknik Konseling Untuk Deteksi Dini

a. Anamnesis

Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keluhan, penyakit yang diderita, riwayat penyakit, dan faktor risiko dalam calon pengantin. Deteksi dini masalah kesehatan mental dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO yang murah, mudah dan efektif untuk catin, yaitu Self Reporting Questionnaire (SRQ), di SRQ terdapat 20 pertanyaan terkait gejala masalah kesehatan mental yang harus dijawab klien dengan jawaban ya atau tidak (Anggraini et al., 2023).

b. Pemeriksaan Keadaan Fisik

Pemeriksaan kondisi fisik dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status kesehatan calon pengantin. Pemeriksaan fisik meliputi: penilaian tanda-tanda yang sangat diperlukan dan penilaian status gizi, terutama dilakukan untuk mengatasi masalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan penilaian status kekurangan zat besi (Intan et al., n.d.). Penilaian keadaan fisik dilakukan untuk mengenali dan membedakan status kesehatan

awal melalui penilaian tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh, dan penilaian fisik lengkap. Calon pengantin yang memiliki tanda-tanda vital bermasalah dapat mengindikasikan adanya masalah infeksi, akibat malaise (kelemahan), sakit kepala, sesak napas, nafsu makan menurun, hipertensi penyakit paru-paru (asma, TBC), dan jantung, yang jika tidak segera ditangani akan berisiko mengganggu kesehatannya (Anggraini et al., 2023).

Status gizi calon pengantin dapat ditentukan dengan pengukuran LILA (tidak kurang dari 23,5 cm), berat badan, tinggi badan, dan adanya tanda-tanda anemia. Indeks Massa Tubuh (BMI) perlu diketahui untuk menilai status gizi calon pengantin dalam kaitannya dengan persiapan kehamilan. (View of Optimalisasi Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Catin Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Prakonsepsi Ibu Dan Anak, n.d.) BMI adalah proporsi standar berat badan (BB) terhadap tinggi badan (TB). Jika calon pengantin dengan status gizi kurang tetapi ingin kehamilan harus ditunda terlebih dahulu dengan menggunakan kontrasepsi sementara intervensi meningkatkan status gizi sampai statusnya baik. (nurqalbi et al., 2023).

c. Edukasi Tentang Tanda Bahaya Kehamilan

Setiap kehamilan pada dasarnya memiliki risiko, namun pada kondisi tertentu risiko ibu hamil akan lebih tinggi. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu hamil, janin atau keduanya. kehamilan berisiko tinggi merupakan Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Beberapa kondisi kesehatan yang berpotensi menimbulkan risiko dalam kehamilan menurut (Anggraini et al., 2023) diantaranya:

- 1) Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, TBC
- 2) Penyakit autoimun seperti lupus atau tiroid
- 3) Penyakit mental seperti depresi atau kecemasan
- 4) Riwayat penyakit genetik atau kelainan kromosom
- 5) Penyakit infertilitas atau masalah kesuburan seperti endometriosis atau sindrom ovarium polistik
- 6) Terkena infeksi menular seksual

- 7) Penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat membahayakan kesehatan bayi
- 8) Paparan zat kimia berbahaya seperti merkuri atau pestisida
- 9) Kehamilan pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua
- 10) Status Gizi Ibu underweight atau overweight
- 11) Jarak antar kehamilan yang terlalu dekat
- 12) Memiliki riwayat keguguran, lahir mati, atau lahir premature
- 13) Merencanakan kehamilan dengan prosedur reproduksi seperti Fertilisasi in Vitro (IVF)

4. Dampak Positif

Melalui konseling yang efektif, ibu hamil akan lebih sadar terhadap kondisi kesehatannya, meningkatkan kepatuhan dalam kunjungan ANC, dan menurunkan angka kejadian komplikasi serius baik pada ibu maupun bayi. (Aprianti et al., 2025)

D. Model dan Pendekatan Konseling Kesehatan Reproduksi

1. Model Konseling Kesehatan Reproduksi

- a. Model GATHER: Memberikan struktur konseling yang ramah dan partisipatif
- b. Model REDI: Membangun hubungan, mengeksplorasi kebutuhan, mendiskusikan opsi, dan menyusun rencana.
- c. Model 5A: Penilaian, Pemberian Nasihat, Persetujuan Tindakan, Bantuan, dan Penjadwalan ulang.

2. Pendekatan Konseling

Pendekatan konseling dibedakan menjadi

- a. Pendekatan Individual: Berfokus pada kebutuhan pribadi klien.
- b. Pendekatan Kelompok: Mengedukasi dalam kelompok diskusi atau kelas.
- c. Pendekatan Keluarga: Melibatkan pasangan dan keluarga untuk mendukung keputusan klien.

3. Etika Dalam Konseling

Etika yang perlu dijunjung dalam konseling:

- a. Menjaga kerahasiaan informasi klien.
- b. Tidak menghakimi dan bersikap netral.
- c. Menghormati hak klien untuk membuat keputusan.
- d. Memberikan informasi yang jujur dan relevan.

E. Penerapan Edukasi Berbasis Keluarga dan Komunitas

1. Konsep Edukasi Berbasis Keluarga dan Komunitas

Edukasi berbasis keluarga dan komunitas menekankan pentingnya lingkungan sosial dan kultural dalam mendukung perubahan perilaku sehat. Hal ini menciptakan keberlanjutan informasi dan pembelajaran dalam jangka panjang (Anggraini et al., 2023).

2. Strategi Penerapan

- a. Pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam penyuluhan.
- b. Menyelenggarakan kelas ibu hamil dan parenting di Posyandu.
- c. Edukasi langsung melalui kunjungan rumah oleh kader atau bidan.
- d. Media edukatif lokal seperti pamflet, radio desa, dan grup WhatsApp keluarga

3. Peran Keluarga

Keluarga merupakan pondasi penting masyarakat. Keluarga sebagai penerus generasi, pemberi kasih sayang dan pendidikan bagi anak-anak, sosialisasi dan internalisasi beragam nilai (sosial, religi, moral, pengetahuan, seni). Apabila keluarga menjalankan fungsi seperti yang diharapkan, keluarga akan melahirkan individu yang kuat untuk mengenal diri dan lingkungannya (Tambunan et al., 2024)

Peran seorang ibu dalam masa kehamilan membutuhkan dukungan dari keluarga, sosial dan tenaga kesehatan. Asuhan yang terintegrasi baik fisik dan psikologis yaitu penerimaan perilakunya, partnership, dan konseling. Deteksi dini dengan asuhan yang terintegrasi dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku psikologis. (nurqalbi et al., 2023)

Dalam pencapaian peran tersebut keterlibatan suami, keluarga dan lingkungannya sangat berpengaruh. Dukungan dari orang-orang terdekatnya membantu dalam proses adaptasi masa kehamilan. Motivasi pasangan untuk merencanakan kehamilan dengan baik termasuk dalam periode prakonsepsi sangat menguntungkan dalam hal persiapan kesehatan suami istri baik fisik dan mental, ekonomi, serta pengendalian kelahiran dimasa depan (Anggraini et al., 2023)

F. Penutup

Konseling dan edukasi kesehatan reproduksi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan proses komunikasi dua arah yang menuntun individu dan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat. Sepanjang siklus kehidupan reproduksi mulai masa pranikah, prakonsepsi, kehamilan, hingga pascapersalinan diperlukan pendampingan yang berlandaskan pengetahuan, empati, dan kepekaan terhadap nilai budaya setempat.

Bab ini menegaskan beberapa pokok: pentingnya edukasi dan konseling pada fase pranikah serta prakonsepsi sebagai fondasi kesehatan reproduksi; peran strategis konseling untuk deteksi dini komplikasi kehamilan demi menurunkan morbiditas dan mortalitas; pemilihan model serta pendekatan konseling yang aplikatif dalam praktik kebidanan; dan penguatan edukasi berbasis keluarga serta komunitas sebagai wujud pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan konseling yang efektif, bidan diharapkan mampu memberikan layanan yang tidak hanya kuratif tetapi juga promotif dan preventif, sehingga ketahanan kesehatan perempuan dan keluarganya semakin kuat. Semoga bab ini menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pendidikan kebidanan dan praktik pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan individu dan komunitas.

Referensi

- Anggraini, D., Suyati, I., & Idayati, M., *et al.* (2023). *Asuhan prakonsepsi dan perencanaan keluarga* (Abdul Karim, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Aprianti, N. F., Faizaturrahmi, E., & History, A. (2025). Pengaruh e-booklet terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin tentang persiapan kehamilan sehat. *Jurnal Promotif Preventif*, 8(3). <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>
- Intan, K., Fifit, S., & Sofiyanti, I., *et al.* (2022). Pengaruh konseling gizi prakonsepsi terhadap pengetahuan dan sikap wanita pranikah. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo*, 1(2).
- Jurnal_Reading_Stase_Pranikah. (n.d.).
- Kostania, G., Ahmad, A. L., & Yunita, S. (2020). Pengembangan booklet pranikah sebagai media informasi dalam pelayanan kesehatan untuk calon pengantin. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(2), 1–7. <https://doi.org/10.36419/jkebin.v11i2.367>
- Laily, N. A., Farahdiba, I., & Gusriani, G. (2025). Pengetahuan calon pengantin wanita tentang persiapan prakonsepsi di Kota Tarakan Kalimantan Utara. *Sport Science and Health*, 7(2), 75–80. <https://doi.org/10.17977/um062v7i22025p75-80>
- Nurqalbi, L., Irma, A., & Ariescha, P., *et al.* (2023). *Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi* (Matias Sirait, Ed.; Edisi pertama). Yayasan Kita Menulis.
- Tambunan, H., Nurhidayati, N., & Saleha, S., *et al.* (2024). Penyuluhan pentingnya gizi pranikah untuk mempersiapkan kehamilan sehat di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(6), 2719–2727. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i6.14925>
- View of Optimalisasi Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Catin Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Prakonsepsi Ibu dan Anak. (n.d.).
- Wulandari, R. (n.d.). *Pelayanan kesehatan prakonsepsi untuk mencegah risiko stunting: A scoping review*. Volume 12, Nomor 2, Oktober 2022, 26. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>

Glosarium

ANC (Antenatal Care)	Layanan pemeriksaan dan pendampingan kehamilan di fasilitas kesehatan, mencakup edukasi, skrining, dan rujukan.
Anamnesis	Penggalan informasi tentang keluhan, riwayat penyakit, dan faktor risiko dari klien.
Asam folat	Mikronutrien kunci prakonsepsi untuk mencegah cacat tabung saraf.
Asuhan terintegrasi	Pelayanan komprehensif yang mencakup aspek fisik dan psikologis melalui kemitraan, penerimaan perilaku, dan konseling.
Bidan	Tenaga kesehatan yang memberi edukasi, konseling, deteksi dini, serta menjadi jembatan rujukan layanan kesehatan reproduksi.
BMI (IMT)	Indeks massa tubuh untuk menilai status gizi.
Calon pengantin (catin)	Individu atau pasangan pada periode pranikah sebagai sasaran edukasi dan konseling.
Deteksi dini	Pengenalan awal gejala atau kondisi berpotensi komplikasi agar intervensi dapat segera dilakukan.
Diabetes gestasional	Kenaikan kadar gula darah yang pertama kali terdeteksi saat kehamilan.
Empati	Kemampuan memahami perasaan dan perspektif klien untuk komunikasi efektif.
Fertilisasi	Pembuahan ovum oleh sperma yang membentuk zigot dan diikuti implantasi di endometrium.
GATHER	Model konseling yang menekankan sambutan, penggalan kebutuhan, pemberian informasi, bantuan pengambilan keputusan, penjelasan, dan tindak lanjut.
IMS (Infeksi Menular Seksual)	Infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, misalnya sifilis, HIV, hepatitis.
Infertilitas	Kesulitan mendapatkan kehamilan setelah hubungan teratur tanpa kontrasepsi dalam jangka waktu memadai.
IVF (Fertilisasi in vitro)	Pembuahan ovum dan sperma di luar tubuh sebagai prosedur reproduksi berbantu.
Jarak kehamilan	Interval antar kehamilan yang direncanakan untuk mengurangi risiko ibu dan bayi.
Jendela emas	Periode pranikah dan prakonsepsi yang optimal untuk intervensi kesehatan reproduksi.
Kader	Anggota masyarakat terlatih yang membantu edukasi dan layanan dasar kesehatan di komunitas.
KEK (Kekurangan Energi Kronis)	Kekurangan asupan energi jangka panjang yang meningkatkan risiko kehamilan.
Keluarga Berencana (KB)	Upaya merencanakan jumlah dan jarak kelahiran sesuai kemampuan keluarga.
Kesehatan reproduksi	Kesejahteraan fisik, mental, dan sosial terkait sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
Konseling	Proses komunikasi dua arah untuk membantu klien membuat keputusan kesehatan yang tepat.

Konseling berpusat pada klien	Pendekatan yang menempatkan kebutuhan, nilai, dan preferensi klien sebagai inti layanan.
LILA (Lingkar Lengan Atas)	Pengukuran antropometri untuk menilai risiko KEK. Patokan kewaspadaan umumnya di bawah 23,5 cm.
Morbiditas	Angka kejadian penyakit dalam populasi.
Mortalitas	Angka kematian dalam populasi.
NAPZA	Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang harus dihindari pada prakonsepsi dan kehamilan.
PCOS (Sindrom Ovarium Polikistik)	Gangguan hormonal yang memengaruhi ovulasi dan kesuburan.
Pemeriksaan laboratorium	Rangkaian tes seperti Hb, trombosit, leukosit, golongan darah dan rhesus, gula darah sewaktu, skrining thalassemia, hepatitis, TORCH, serta pemeriksaan urin.
Posyandu	Pos pelayanan terpadu di komunitas untuk layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak.
Preeklamsia	Hipertensi pada kehamilan disertai proteinuria dan gejala terkait.
Prakonsepsi	Masa sebelum terjadinya kehamilan untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi.
Pranikah	Periode sebelum pernikahan yang sah.
Promotif dan preventif	Upaya meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah penyakit.
Puskesmas	Fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah.
REDI	Model konseling yang meliputi membangun hubungan, mengeksplorasi kebutuhan, mendiskusikan opsi, dan menyusun rencana.
Risiko kehamilan tinggi	Kondisi dengan peningkatan risiko bagi ibu atau janin karena faktor medis atau sosial.
Rujukan	Pengalihan klien ke fasilitas atau tenaga yang lebih tepat untuk penanganan lanjutan.
Sensitivitas budaya	Kemampuan memahami dan menghormati nilai budaya klien dalam layanan.
Siklus menstruasi	Rangkaian perubahan rata-rata 28 hari meliputi fase menstruasi, proliferasi atau folikular, dan luteal, dengan ovulasi di sekitar pertengahan siklus.
SRQ (Self Reporting Questionnaire)	Kuesioner 20 item untuk skrining masalah kesehatan mental pada catin.
Status gizi	Kondisi pemenuhan zat gizi yang dinilai melalui antropometri dan indikator lain.
Suplementasi mikronutrien	Pemberian zat gizi penting seperti asam folat untuk mencegah defisiensi.
Tanda bahaya kehamilan	Gejala yang menandakan kondisi berisiko dan memerlukan penanganan segera.
Tanda vital	Parameter dasar kesehatan seperti tekanan darah, nadi, frekuensi napas, dan suhu.
TBC (Tuberkulosis)	Penyakit infeksi yang dapat memengaruhi kesehatan ibu hamil.

Thalassemia	Kelainan darah bawaan yang dapat dideteksi melalui skrining pra-nikah atau prakonsepsi.
TORCH	Kelompok infeksi penting pada kehamilan yang mencakup toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes simpleks.

BAB 2

Deteksi Dini Status Kesehatan Umum dan Penyakit Kronis

A. Menjaga Kesehatan Sebelum Terlambat

Tahap pranikah dan prakonsepsi memegang peran strategis dalam menjamin keberhasilan kehamilan serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak pada masa yang akan datang. Pada periode ini, penting dilakukan deteksi dan penanganan terhadap berbagai faktor risiko, termasuk kondisi kesehatan umum maupun penyakit kronis yang dapat berdampak negatif terhadap kehamilan (Khekade et al., 2023). *World Health Organization* (2013) menegaskan bahwa layanan prakonsepsi merupakan pendekatan preventif yang esensial dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah pada calon pengantin menjadi langkah preventif yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan sejak dini. Pemeriksaan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesiapan sebelum membentuk keluarga, tetapi juga memungkinkan pasangan untuk mengelola kondisi kesehatannya sebelum terjadinya kehamilan. Apabila ditemukan gangguan kesehatan, diperlukan intervensi medis untuk mengoptimalkan status kesehatan calon ibu. Kesehatan ibu yang kurang baik dapat berdampak langsung terhadap status kesehatan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, calon pengantin perlu berada dalam kondisi sehat secara fisik, psikologis, dan sosial guna mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera. Pemeriksaan pranikah, dalam konteks ini, menjadi strategi utama dalam pencegahan masalah kesehatan.

Dalam konteks asuhan kebidanan, bidan memiliki tanggung jawab profesional dalam melakukan skrining awal terhadap kondisi kesehatan calon ibu, termasuk identifikasi dini penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jantung, penyakit ginjal, serta disfungsi tiroid (Kemenkes, 2021).

B. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan merupakan proses evaluatif sistematis terhadap kondisi fisik individu dengan tujuan mendeteksi faktor risiko yang dapat memengaruhi kehamilan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, termasuk bidan, guna memastikan kesiapan reproduksi dan mencegah komplikasi pada ibu, janin, serta proses persalinan. Kesehatan optimal kedua calon mempelai menjadi salah satu determinan utama kebahagiaan rumah tangga, mengingat adanya masalah kesehatan pada salah satu pihak dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pranikah dianjurkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan sehat secara menyeluruh.

1. Tekanan Darah

Tekanan darah merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri akibat kontraksi jantung. Tekanan ini diklasifikasikan menjadi tekanan sistolik (ketika ventrikel berkontraksi) dan diastolik (saat ventrikel relaksasi dan menerima aliran darah dari atrium). Nilai tekanan darah bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung aktivitas harian individu, seperti saat tidur, bangun, berolahraga, atau mengalami stres. Pengukuran tekanan darah dilakukan menggunakan tensimeter (sfigmomanometer), dengan posisi pasien duduk atau berbaring telentang.

Hipertensi, yaitu kondisi peningkatan tekanan darah secara persisten, dikenal sebagai “pembunuh senyap” karena sering kali tidak menunjukkan gejala klinis yang nyata. WHO (2021) memperkirakan bahwa sekitar 21% orang dewasa di dunia menderita hipertensi. Wanita dengan riwayat hipertensi pra-kehamilan memiliki potensi untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan melalui pengelolaan gaya hidup seperti pola makan sehat, olahraga teratur, manajemen stres, dan penghentian kebiasaan merokok (Perdani & Berawi, 2021).

Secara fisiopatologis, hipertensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan resistensi perifer, dan kerusakan sel endotel. Kondisi ini memicu kebocoran cairan dan aktivasi mekanisme koagulasi, yang berujung pada maldistribusi aliran darah, iskemia jaringan, serta risiko nekrosis dan perdarahan organ. Aktivasi endotel juga memicu produksi oksida nitrat dan zat koagulan yang meningkatkan respons terhadap vasopresor, menjadikan hipertensi sebagai penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal.

Penelitian menunjukkan bahwa hipertensi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko gangguan kardiometabolik pada anak sejak usia dini. Meskipun manajemen hipertensi selama kehamilan banyak diteliti, intervensi pada periode pra-kehamilan masih kurang mendapat perhatian. Padahal, manajemen tekanan darah yang optimal sebelum kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti preeklamsia, berat lahir rendah, dan kerusakan organ baik pada ibu maupun janin (Lu et al., 2018).

2. Indeks Masa Tubuh (IMT)

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan indikator antropometrik yang digunakan secara luas untuk menilai status gizi orang dewasa, khususnya dalam mendeteksi risiko kekurangan atau kelebihan berat badan (Supariasa, 2016). IMT dihitung dengan membagi berat badan (kg) dengan kuadrat tinggi badan (m^2) (Irianto, 2017). Metode ini berlaku untuk individu berusia 18–70 tahun yang tidak sedang hamil, menyusui, atau memiliki kondisi fisik khusus seperti atlet.

Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan posisi tegak, tanpa alas kaki, dan pandangan lurus ke depan, sementara berat badan diukur dengan timbangan standar dalam posisi berdiri tegak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014), nilai IMT dikategorikan ke dalam beberapa rentang yang menunjukkan status gizi seseorang.

Tabel 2.1 Kategori IMT

Kategori	Keterangan	IMT
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	< 17,0
	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0 – <18,5
Normal	Berat badan normal	18,5 – 25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan	>25,0 – 27,0

Status gizi pra-kehamilan, yang direpresentasikan oleh IMT, merupakan indikator penting dalam menentukan kebutuhan penambahan berat badan selama kehamilan. Kurangnya kesadaran ibu terhadap pentingnya pemeriksaan gizi sebelum hamil dapat menyebabkan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan janin. IMT pra-kehamilan mencerminkan cadangan gizi ibu dan berkontribusi terhadap kesehatan kehamilan dan perkembangan janin secara keseluruhan (Achadi et al., 2020).

Pengukuran antropometrik seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkaran lengan atas merupakan metode penting untuk menilai status gizi perempuan pada masa prakonsepsi, yang berperan dalam mempersiapkan kehamilan secara optimal. Status gizi yang tidak sesuai sebelum konsepsi telah terbukti berkontribusi terhadap berbagai komplikasi kehamilan. Perempuan dengan indeks massa tubuh rendah (*underweight*) memiliki risiko 32% lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur, sedangkan perempuan dengan obesitas memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar mengalami preeklampsia dan diabetes gestasional (Dean et al., 2014). Selain itu, kekurangan gizi pada masa sebelum kehamilan juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko kelahiran bayi dengan kondisi stunting, yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak dalam jangka panjang (Achadi et al., 2020).

3. Pemeriksaan Gula Darah

Pemeriksaan kadar glukosa darah merupakan bagian dari tes kesehatan pranikah yang bertujuan untuk mendeteksi dini risiko diabetes mellitus. Tes ini memberikan informasi penting mengenai kondisi metabolik calon pengantin dan dapat mencegah komplikasi kesehatan di masa depan (Akbarjon, 2019).

Bagi perempuan dengan diabetes mellitus, kontrol gula darah sebelum kehamilan menjadi sangat penting. Salah satu parameter penting adalah kadar hemoglobin A1C, yang mencerminkan rata-rata kadar glukosa darah selama dua hingga tiga bulan terakhir. *American Diabetes Association* merekomendasikan target A1C sebesar 6,5% sebelum kehamilan. Hal ini dikarenakan organ vital janin seperti otak, sumsum tulang belakang, dan jantung mulai terbentuk sejak awal pembuahan, bahkan sebelum ibu menyadari kehamilannya. Apabila

kadar gula darah tidak terkontrol pada masa ini, risiko keguguran dan cacat lahir meningkat secara signifikan.

C. Deteksi Dini Penyakit

Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan langkah preventif yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan menurunkan risiko komplikasi kehamilan serta kelainan genetik pada anak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan calon pengantin, termasuk mendeteksi penyakit menular maupun kelainan genetik yang dapat berdampak pada proses kehamilan dan keturunan (WHO, 2013).

Salah satu manfaat utama dari pemeriksaan pranikah adalah mencegah penularan penyakit infeksius, seperti HIV, hepatitis B, dan infeksi menular seksual lainnya. Deteksi dini terhadap penyakit tersebut memungkinkan intervensi medis yang dapat mencegah transmisi antar pasangan atau dari ibu kepada janin selama kehamilan (CDC, 2021). Selain itu, pemeriksaan genetik penting dilakukan untuk mengidentifikasi kelainan hereditas seperti thalassemia dan anemia sel sabit, yang dapat diturunkan kepada anak (Delatycki & Castellani, 2019).

Selain aspek pencegahan, pemeriksaan ini juga mendukung perencanaan kehamilan yang lebih terarah dan aman. Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, pasangan dapat meminimalkan risiko terhadap komplikasi kehamilan, termasuk diabetes gestasional, hipertensi dalam kehamilan, atau penyakit kronis lainnya. Jika ditemukan kondisi medis tertentu, pengobatan dapat dilakukan lebih awal, sehingga kesehatan ibu dan janin dapat dijaga secara optimal sebelum konsepsi terjadi (Kemenkes, 2021) (Akbarjon, 2019).

1. Jenis-jenis Pemeriksaan dalam Layanan Pranikah

Pemeriksaan pranikah mencakup berbagai jenis skrining yang dirancang untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang status kesehatan calon pengantin.

- a. Penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, dan sifilis, serta anemia dan gangguan hemoglobin seperti thalassemia (Kemenkes RI, 2014).

Hasil penelitian merekomendasikan skrining HIV pada pasangan sebelum menikah terbukti menurunkan penularan HIV (Manakandan & Sutan, 2016). Selain itu, pemeriksaan golongan darah dan rhesus penting untuk mengantisipasi kemungkinan inkompatibilitas rhesus yang dapat mengakibatkan penyakit hemolitik pada janin.

Thalassemia merupakan kelainan genetik pada sel darah merah yang diturunkan secara autosomal resesif dari kedua orang tua kepada anak. Kondisi ini ditandai oleh gangguan produksi rantai globin, salah satu komponen utama hemoglobin (Hb), yang menyebabkan sel darah merah menjadi mudah rusak dan mengakibatkan anemia kronis (Kemenkes, 2023). Meskipun belum tersedia pengobatan yang bersifat kuratif, thalassemia dapat dicegah melalui strategi skrining terhadap calon pasangan sebelum menikah, khususnya dengan menghindari perkawinan antar sesama pembawa sifat thalassemia.

Data nasional menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam wilayah "sabuk thalassemia", dengan prevalensi pembawa sifat mencapai 3–10% dari total populasi. Menurut laporan Yayasan Thalassemia Indonesia (2021), jumlah kasus thalassemia mengalami peningkatan signifikan, dari 4.896 kasus pada 2012 menjadi 10.973 kasus hingga pertengahan 2021. Peningkatan ini mencerminkan perlunya penguatan program deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya skrining pranikah (Yayasan Thalassemia Indonesia, 2021).

Identifikasi pembawa sifat melalui pemeriksaan laboratorium sangat penting untuk mencegah kelahiran anak dengan thalassemia mayor. Strategi ini direkomendasikan terutama bagi pasangan yang memiliki risiko tinggi (Kemenkes, 2023). Bila dua individu pembawa sifat menikah, setiap kehamilan memiliki probabilitas 25% untuk melahirkan anak dengan thalassemia mayor. Sebaliknya, apabila penderita thalassemia

menikah dengan individu non-pembawa sifat, seluruh keturunan hanya akan menjadi pembawa tanpa gejala (IDAI, 2023).

Disamping itu, penting juga bagi calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan rhesus untuk mendeteksi dan mencegah kelainan pada bayi seperti hyperbilirubinemia dan hemolitik janin. Hal ini disebabkan oleh ketidak-sesuaian golongan darah antara ibu dan janin, seperti pada kasus ibu bergolongan darah O dengan janin bergolongan darah A, B, atau AB, dikenal sebagai inkompatibilitas ABO. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir, yang ditandai dengan munculnya jaundice atau kulit berwarna kuning akibat peningkatan kadar bilirubin (American Academy of Pediatrics, 2004).

Selain itu, inkompatibilitas rhesus terjadi ketika ibu memiliki rhesus negatif (Rh-) dan janin mewarisi rhesus positif (Rh+) dari ayah. Hal ini dapat memicu respon imun ibu terhadap sel darah janin dan mengarah pada kondisi serius seperti penyakit hemolitik janin dan janin mati dalam kandungan (*hemolytic disease of the fetus and newborn/HDFN*) (WHO, 2020).

Oleh karena itu, pemeriksaan golongan darah dan rhesus sebelum kehamilan sangat penting untuk mengantisipasi risiko tersebut melalui pemberian imunoglobulin anti-D atau tindakan medis lainnya sesuai indikasi (ACOG, 2017).

- b. Pemeriksaan TORCH (Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes Simplex Virus) dilakukan untuk mengidentifikasi infeksi yang berpotensi membahayakan janin selama kehamilan (Hobson et al., 2017).

Pemeriksaan TORCH merupakan bagian krusial dalam skrining kesehatan pranikah yang bertujuan untuk mempersiapkan calon ibu dalam menghadapi kehamilan secara sehat serta meminimalkan risiko gangguan pada janin. Skrining ini memungkinkan deteksi dini terhadap infeksi toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus (CMV), dan herpes simplex virus, yang berpotensi menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, serta kelainan bawaan seperti gangguan neurologis, kelainan mata dan telinga, serta disfungsi organ vital seperti otak (misalnya hidrosefalus dan makrosefali), paru-paru, dan limpa (Kemenkes, 2019). Selain berdampak pada janin, infeksi

TORCH juga dapat mempengaruhi kesuburan baik pada laki-laki maupun perempuan. Infeksi yang tidak terdiagnosis pada masa prakonsepsi dapat menimbulkan infertilitas akibat kerusakan sistem reproduksi atau respons imunologis terhadap infeksi kronis, sehingga mempersulit proses pembuahan secara alami (Kemenkes, 2019).

- c. Tes urine dilakukan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih, gangguan ginjal, dan indikasi diabetes mellitus. Sementara itu, pemeriksaan fisik mencakup evaluasi organ reproduksi, tekanan darah, dan tanda-tanda umum kesehatan. Tes kadar glukosa darah dilakukan untuk mendeteksi diabetes, yang merupakan salah satu faktor risiko komplikasi kehamilan apabila tidak dikontrol sejak awal (ADA, 2022). Selain itu, skrining lanjutan terhadap infeksi menular seksual lainnya juga direkomendasikan guna memastikan bahwa pasangan tidak membawa patogen yang dapat ditularkan secara seksual atau vertikal (CDC, 2021).

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Pranikah

Pemeriksaan kesehatan pranikah sebaiknya dilakukan setidaknya enam bulan sebelum rencana pernikahan. Rentang waktu ini memberikan cukup ruang bagi pasangan untuk melakukan pengobatan, menjalani konseling genetik, atau mengikuti tindakan medis lain yang diperlukan guna mengatasi masalah kesehatan yang ditemukan (WHO, 2013). Pemeriksaan ini dapat dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, maupun laboratorium kesehatan. Ketersediaan layanan yang luas memudahkan pasangan dalam mengakses pemeriksaan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan menuju kehamilan yang sehat dan keluarga yang berkualitas (Kemenkes RI, 2021).

3. Manfaat Deteksi Dini Penyakit dalam Pemeriksaan Pranikah

Deteksi dini terhadap penyakit melalui pemeriksaan pranikah memberikan kontribusi penting dalam:

- a. Mencegah penularan penyakit infeksius antara pasangan maupun kepada keturunannya. Pemeriksaan laboratorium seperti tes HIV, hepatitis B, dan infeksi menular seksual lainnya berfungsi untuk mengidentifikasi individu yang berisiko menjadi pembawa patogen yang dapat ditularkan secara seksual atau vertikal. Dengan intervensi sejak awal, penularan

kepada pasangan atau anak dapat dicegah secara efektif melalui terapi profilaksis atau pengelolaan klinis yang sesuai (CDC, 2021) (WHO, 2013).

- b. Mendeteksi potensi kelainan hereditas yang dapat diturunkan kepada keturunan. Penyakit genetik seperti thalassemia dan anemia sel sabit dapat diidentifikasi melalui skrining pembawa (carrier screening), yang memungkinkan pasangan memperoleh informasi risiko dan mempertimbangkan pilihan reproduktif secara bijak. Dengan demikian, risiko kelahiran anak dengan kelainan genetik berat dapat diminimalkan (Delatycki & Castellani, 2019) (March of Dimes, 2020).
 - c. Perencanaan kehamilan yang sehat dan rasional.
Dengan mengetahui status kesehatan masing-masing, pasangan dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan. Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan konseling yang berbasis risiko guna mencegah komplikasi pada ibu dan janin, serta memaksimalkan hasil kehamilan yang optimal (Kemenkes, 2021) (Akbarjon, 2019).
4. Deteksi dini Hipertensi pada masa pranikah dan prakonsepsi
Deteksi dini hipertensi pada masa prakonsepsi dan pranikah merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi. Hipertensi yang tidak teridentifikasi sebelum kehamilan dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan obstetri, seperti preeklampsia, eklampsia, solusio plasenta, kelahiran prematur, dan pertumbuhan janin terhambat (ACOG, 2019). Oleh karena itu, pengukuran tekanan darah secara rutin perlu dilakukan pada setiap pasangan yang merencanakan pernikahan dan kehamilan.

Hipertensi pada wanita usia reproduktif dapat dikategorikan sebagai hipertensi kronis bila ditemukan sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini dapat memperburuk prognosis ibu dan janin apabila tidak dikendalikan sejak dini. Dengan skrining tekanan darah dan riwayat medis pada masa pranikah, individu dengan tekanan darah tinggi dapat diberikan edukasi, intervensi gaya hidup, dan terapi farmakologis bila diperlukan, sehingga kehamilan dapat direncanakan dalam kondisi optimal (James et al., 2014).

5. Deteksi dini Diabetes melitus pada masa pranikah dan prakonsepsi
Deteksi dini diabetes melitus (DM) pada masa prakonsepsi dan pranikah sangat penting dilakukan guna mengantisipasi risiko komplikasi kehamilan, gangguan kesuburan, dan morbiditas pada ibu serta janin. Diabetes yang tidak terdiagnosis sebelum kehamilan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti keguguran, preeklampsia, makrosomia janin, persalinan prematur, dan kelainan kongenital (ADA, 2022). Oleh karena itu, pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu atau puasa menjadi bagian penting dalam skrining kesehatan pasangan yang merencanakan pernikahan dan kehamilan.

DM tipe 2 sering kali bersifat asimtomatik dan baru terdeteksi setelah terjadi komplikasi metabolik atau kehamilan yang tidak direncanakan. Wanita dengan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol sebelum kehamilan memiliki risiko empat kali lipat melahirkan bayi dengan cacat bawaan dibandingkan wanita non-diabetik (Metzger et al., 2008). Oleh sebab itu, edukasi pranikah mengenai gaya hidup sehat, diet seimbang, dan pengendalian berat badan perlu diberikan untuk mengurangi prevalensi DM pada usia reproduktif.

Deteksi dini DM juga penting pada laki-laki, karena hiperglikemia kronis dapat menurunkan kualitas sperma, memperburuk disfungsi ereksi, dan memengaruhi keberhasilan konsepsi (Krausz & Riera-Escamilla, 2018). Maka, pemeriksaan status metabolik pranikah hendaknya dilakukan pada kedua calon pasangan, khususnya bila memiliki riwayat keluarga DM, obesitas, atau gaya hidup sedentari. Implementasi deteksi dini DM dalam pelayanan prakonsepsi dan pranikah mendukung pendekatan preventif dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Integrasi skrining DM dengan konseling prakonsepsi di fasilitas kesehatan primer berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan keberhasilan program kesehatan reproduksi secara menyeluruh (Kemenkes, 2022).

6. Deteksi dini Penyakit Jantung pada masa pranikah dan prakonsepsi
Deteksi dini penyakit jantung pada masa prakonsepsi dan pranikah merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mencegah komplikasi serius selama kehamilan dan persalinan. Wanita dengan gangguan kardiovaskular yang tidak terdiagnosis

berisiko mengalami kegagalan jantung, aritmia, atau kematian maternal, terutama selama trimester ketiga dan proses persalinan yang meningkatkan beban kerja jantung secara signifikan (Regitz-Zagrosek et al., 2018). Oleh karena itu, skrining kesehatan jantung sebaiknya dilakukan terhadap seluruh calon pengantin, khususnya mereka dengan riwayat keluarga penyakit jantung, hipertensi, atau keluhan seperti nyeri dada, sesak napas, dan mudah lelah.

Gangguan kardiovaskular seperti penyakit jantung bawaan, penyakit jantung rematik, dan penyakit jantung iskemik dapat membahayakan baik ibu maupun janin. Perempuan dengan penyakit jantung memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi mengalami komplikasi obstetrik dan neonatal dibandingkan perempuan dengan jantung sehat (Siu et al., 2001). Pemeriksaan yang direkomendasikan dalam evaluasi pranikah meliputi anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik, elektrokardiogram (EKG), dan jika diperlukan, ekokardiografi.

Penyakit jantung juga berdampak pada kesuburan dan kapasitas kehamilan, karena keterbatasan aliran darah dapat mengganggu fungsi organ reproduksi dan pertumbuhan janin. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan penanganan medis yang tepat dan perencanaan kehamilan yang terkontrol. Deteksi dan intervensi dini terhadap penyakit jantung akan meningkatkan kualitas hidup calon ibu dan menurunkan angka morbiditas maternal (Warnes et al., 2008).

Integrasi pemeriksaan kardiovaskular dalam layanan prakonsepsi dan pranikah perlu menjadi bagian dari kebijakan pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam konteks upaya nasional menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Edukasi mengenai faktor risiko jantung seperti obesitas, kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, dan stres juga harus menjadi bagian dari konseling pranikah guna membentuk keluarga sehat sejak awal (Kemenkes, 2023).

D. Skrining Penyakit

Pelaksanaan skrining pranikah memungkinkan calon pasangan untuk segera mengidentifikasi dan menangani faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan mereka maupun keturunannya. Sayangnya,

masih banyak pasangan yang enggan menjalani skrining karena khawatir hasil pemeriksaan akan menghambat rencana pernikahan, terutama jika ditemukan masalah kesehatan tertentu.

Manfaat skrining pranikah bersifat multidimensional, mencakup aspek kesehatan individu, keturunan, dan ketahanan keluarga secara keseluruhan. Bagi calon suami, skrining berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab reproduktif, serta mendukung kesehatan pasangan dan keturunannya. Bagi calon istri, skrining memfasilitasi perencanaan kehamilan yang sehat serta mendorong adopsi gaya hidup preventif dan sehat. Bagi calon bayi, skrining ini berperan dalam mencegah kelahiran dengan cacat bawaan atau gangguan perkembangan yang dapat dikaitkan dengan kondisi prakonsepsi orang tua. Secara umum, skrining pranikah mendukung pembentukan keluarga sehat dan peningkatan kualitas generasi mendatang.

Prosedur skrining pranikah meliputi berbagai aspek penting, antara lain pemeriksaan fisik menyeluruh, penelusuran riwayat penyakit keturunan, pemeriksaan penyakit infeksi menular, evaluasi fungsi organ reproduksi, serta identifikasi potensi alergi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menyajikan profil kesehatan yang komprehensif sehingga calon pasangan dapat mengambil langkah medis atau preventif yang tepat sebelum menikah dan merencanakan kehamilan.

1. **Skrining Penyakit Ginjal kronik pada masa pranikah dan prakonsepsi**

Skrining penyakit ginjal kronis (PGK) pada masa pranikah dan prakonsepsi merupakan langkah preventif yang krusial dalam menjaga kesehatan reproduksi serta keberhasilan kehamilan. Deteksi dini gangguan fungsi ginjal memungkinkan intervensi medis sebelum terjadinya komplikasi serius, baik bagi calon ibu maupun janin (Rathi et al., 2020). Pada fase pranikah, evaluasi kesehatan menyeluruh, termasuk pemeriksaan fungsi ginjal, bertujuan untuk menilai kesiapan biologis calon pasangan. Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi gangguan ginjal yang bersifat laten, seperti PGK tahap awal yang belum menunjukkan gejala klinis. Deteksi dini memungkinkan pengendalian progresivitas penyakit dan mencegah dampak jangka panjang terhadap kesuburan dan kehamilan (Gaitonde et al., 2017). Selain itu, jika terdapat disfungsi ginjal, pasangan dapat merencanakan kehamilan secara lebih matang dengan dukungan terapi yang

sesuai guna menurunkan risiko komplikasi seperti preeklampsia, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat lahir rendah (Piccoli et al., 2015).

Pada fase prakonsepsi, skrining lebih difokuskan pada evaluasi fungsional ginjal melalui pemeriksaan laboratorium seperti kadar kreatinin serum, estimasi laju filtrasi glomerulus (eGFR), dan albuminuria. Identifikasi faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan PGK, diabetes mellitus, hipertensi, serta obesitas sangat penting untuk menilai potensi gangguan ginjal yang dapat memengaruhi jalannya kehamilan (Luyckx et al., 2018). Berdasarkan hasil tersebut, tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi berupa edukasi gaya hidup sehat, modifikasi diet, atau pengobatan farmakologis untuk mengoptimalkan kondisi metabolik dan tekanan darah.

Pelaksanaan skrining secara bersama, baik oleh calon suami maupun istri, menjadi komponen penting dalam perencanaan keluarga yang bertanggung jawab. Mengingat bahwa kondisi kesehatan salah satu pasangan dapat berdampak terhadap pasangan lainnya serta hasil reproduksi, skrining bersama mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional dan strategis terkait waktu, metode, dan kesiapan biologis dalam memulai kehamilan (Kemenkes, 2022).

Dengan demikian, pelaksanaan skrining ginjal pada masa pranikah dan prakonsepsi memiliki signifikansi tinggi dalam menjamin kesehatan ibu, janin, serta kualitas keluarga jangka panjang. Upaya ini tidak hanya mencegah komplikasi obstetrik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kehamilan sehat dan keberhasilan reproduksi secara menyeluruh.

2. **Skrining Penyakit tiroid pada masa pranikah dan prakonsepsi.**
Skrining fungsi tiroid pada masa pranikah dan prakonsepsi merupakan langkah preventif esensial dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi dan menurunkan risiko komplikasi kehamilan. Gangguan tiroid, baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme, terbukti berpengaruh terhadap fertilitas, kehamilan, dan perkembangan janin, sehingga deteksi dini sangat disarankan sebelum konsepsi terjadi (Verburg et al., 2020).

Pada fase pranikah, pemeriksaan fungsi tiroid bertujuan mengidentifikasi gangguan hormonal yang berpotensi mengganggu kesuburan. Hipotiroidisme dapat menyebabkan anovulasi, gangguan menstruasi, dan infertilitas pada perempuan, sedangkan hipertiroidisme dapat menurunkan kualitas sperma pada laki-laki (Nazarpour et al., 2019). Deteksi dini ini memungkinkan intervensi tepat seperti terapi levotiroksin sebelum pasangan merencanakan kehamilan.

Selama fase prakonsepsi, skrining tiroid menjadi semakin penting karena hormon tiroid berperan dalam perkembangan neurologis janin pada trimester pertama. Gangguan fungsi tiroid yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko preeklampsia, keguguran, dan berat badan lahir rendah (van den Boogaard et al., 2020). Oleh karena itu, evaluasi kadar TSH dan FT4 sebaiknya dilakukan pada perempuan dengan riwayat gangguan tiroid, infertilitas, atau riwayat keguguran berulang.

TSH merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior untuk mengatur fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3), yang esensial dalam mengatur metabolisme, siklus menstruasi, ovulasi, serta kesiapan endometrium untuk implantasi (Verburg et al., 2020). American Thyroid Association merekomendasikan kadar TSH <2,5 mIU/L bagi perempuan yang berencana hamil atau sedang berada dalam trimester pertama kehamilan (Alexander et al., 2017, diperbarui oleh Sharma et al., 2021).

Keseimbangan hormon TSH merupakan elemen kunci dalam keberhasilan konsepsi. Kadar TSH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu fungsi endokrin reproduksi, menyebabkan gangguan ovulasi, penurunan kualitas sperma, dan kegagalan implantasi. Gangguan TSH juga berpengaruh terhadap kesuburan pria. Hipotiroidisme dapat menurunkan produksi testosteron, volume semen, serta motilitas sperma, yang secara kolektif menurunkan potensi pembuahan (Poppe et al., 2021). Disfungsi tiroid pada pria pun dapat menyebabkan disfungsi seksual seperti penurunan libido dan disfungsi ereksi.

Skrining bersama antara calon suami dan istri dianjurkan untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya dalam kondisi optimal. Gangguan tiroid yang teridentifikasi pada satu pasangan dapat

berdampak pada keberhasilan konsepsi dan keberlangsungan kehamilan, sehingga penanganan holistik diperlukan. Pemeriksaan laboratorium sederhana seperti TSH dan antibodi anti-TPO dapat menjadi bagian dari pemeriksaan pranikah dan prakonsepsi yang terintegrasi (Poppe et al., 2021).

Dengan demikian, pelaksanaan skrining penyakit tiroid pada masa pranikah dan prakonsepsi merupakan langkah strategis dalam membentuk keluarga sehat dan mencegah komplikasi kehamilan. Deteksi dini gangguan tiroid dapat meningkatkan keberhasilan konsepsi serta menurunkan risiko morbiditas ibu dan bayi.

E. Penutup

Deteksi dini terhadap status kesehatan umum dan penyakit kronis merupakan elemen fundamental dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, khususnya pada periode pranikah dan prakonsepsi. Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum pernikahan tidak hanya berguna untuk mengidentifikasi risiko penyakit infeksi dan genetik, tetapi juga penting dalam mengantisipasi penyakit kronis tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit ginjal kronis, gangguan tiroid, serta penyakit jantung yang dapat mempengaruhi keberhasilan konsepsi dan kesehatan keturunan.

Referensi

- Achadi, E. L., Scott, S., Wirawan, F., & Somasetia, D. H. (2020). *Maternal nutrition and pregnancy outcomes: A review of the evidence in Indonesia*. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 51(6), 1068–1080.
- ACOG. (2017). Practice Bulletin No. 181: Prevention of Rh D alloimmunization. Obstetrics & Gynecology, 130(2), e57–e70. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002191>
- ACOG. (2019). Hypertension in pregnancy: Executive summary. Obstetrics & Gynecology, 133(1), e1–e25. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003022>
- ADA. (2022). Standards of medical care in diabetes—2022. Diabetes Care, 45(Supplement_1), S1–S264. <https://doi.org/10.2337/dc22-S001>
- Akbarjon, R. (2019). Premarital blood sugar testing and prevention of diabetes mellitus in pregnancy: An overview. Journal of Diabetes & Metabolism, 10(11), 1–5.
- Alexander, E. K., Pearce, E. N., Brent, G. A., Brown, R. S., Chen, H., Dosiou, C., ... & Sullivan, S. (2017). 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. Thyroid, 27(3), 315–389. <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457>
- American Academy of Pediatrics. (2004). Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics, 114(1), 297–316. <https://doi.org/10.1542/peds.114.1.297>
- CDC. (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report, 70(4), 1–187.
- Dean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception care: Nutritional risks and interventions. Reproductive Health, 11(Suppl 3), S3. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S3>

- Delatycki, M. B., & Castellani, C. (2019). Carrier screening for recessive conditions. *Current Opinion in Pediatrics*, 31(6), 701–706. <https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000817>
- Gaitonde, D. Y., Cook, D. L., & Rivera, I. M. (2017). Chronic kidney disease: Detection and evaluation. *American Family Physician*, 96(12), 776–783.
- IDAI. (2023). Pencegahan thalassemia melalui edukasi dan skrining dini. Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Irianto, K. (2017). *Panduan gizi dan kesehatan*. Bandung: Yrama Widya.
- James, J. L., Whitley, G. S., & Cartwright, J. E. (2014). Pre-eclampsia: Fitting together the placental, immune and cardiovascular pieces. *Journal of Pathology*, 232(4), 335–344. <https://doi.org/10.1002/path.4310>
- Kemenkes RI. (2014). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2021). *Buku Saku Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2022). *Pedoman Layanan Prakonsepsi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2023). *Skrining Thalassemia: Pencegahan sejak dini*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Khekade, S., Chandratre, G., Mahajan, A., & Agrawal, S. (2023). A study on effectiveness of preconception care interventions on maternal and child health outcomes. *Journal of Obstetrics and Gynecology of India*, 73(2), 147–153. <https://doi.org/10.1007/s13224-022-01680-w>
- Krausz, C., & Riera-Escamilla, A. (2018). Genetics of male infertility. *Nature Reviews Urology*, 15(6), 369–384. <https://doi.org/10.1038/s41585-018-0003-3>
- Lu, J., Yeung, E., & Zhang, C. (2018). Preconception blood pressure and risk of adverse pregnancy outcomes. *Hypertension*, 72(2), 439–446. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11060>
- Luyckx, V. A., Tonelli, M., & Stanifer, J. W. (2018). The global burden of kidney disease and the sustainable development goals. *Bulletin of the World Health Organization*, 96(6), 414–422D. <https://doi.org/10.2471/BLT.17.206441>
- Manakandan, S., & Sutan, R. (2016). Impact of premarital HIV screening on knowledge and behavior. *Journal of International AIDS Society*, 19(1), 1–5.
- March of Dimes. (2020). Genetic counseling and testing. Retrieved from <https://www.marchofdimes.org>
- Metzger, B. E., Lowe, L. P., Dyer, A. R., Trimble, E. R., Chaovarindr, U., Coustan, D. R., ... & HAPO Study Cooperative Research Group. (2008). Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. *New England Journal of Medicine*, 358(19), 1991–2002. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0707943>
- Nazarpour, S., Ramezani Tehrani, F., Simbar, M., & Azizi, F. (2019). Thyroid dysfunction and reproductive health in women: A review. *International Journal of*

Reproductive BioMedicine, 17(2), 89–102.
<https://doi.org/10.18502/ijrm.v17i2.3987>

- Perdani, R., & Berawi, K. N. (2021). Manajemen hipertensi dalam kehamilan: pendekatan pencegahan pada wanita usia subur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(1), 35–42.
- Piccoli, G. B., Cabiddu, G., Attini, R., Vigotti, F. N., Maxia, S., Lepori, N., ... & Versino, E. (2015). Risk of adverse pregnancy outcomes in women with CKD. *Journal of the American Society of Nephrology*, 26(8), 2011–2022. <https://doi.org/10.1681/ASN.2014070660>
- Poppe, K., Velkeniers, B., & Glinde, D. (2021). The role of thyroid autoimmunity in fertility and pregnancy. *Nature Reviews Endocrinology*, 17(5), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41574-021-00457-z>
- Rathi, M., Ramachandran, R., & Prasad, N. (2020). Chronic kidney disease in women. *Kidney International Reports*, 5(6), 837–848. <https://doi.org/10.1016/j.ekir.2020.03.021>
- Regitz-Zagrosek, V., Roos-Hesselink, J. W., Bauersachs, J., Blomström-Lundqvist, C., Cifková, R., De Bonis, M., ... & ESC Scientific Document Group. (2018). ESC guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. *European Heart Journal*, 39(34), 3165–3241. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy340>
- Sharma, C., Bennett, K. A., Maher, J. E., & Alexander, E. K. (2021). The American Thyroid Association's updated guidelines for thyroid disease in pregnancy. *Thyroid*, 31(10), 1472–1485. <https://doi.org/10.1089/thy.2021.0313>
- Siu, S. C., Sermer, M., Colman, J. M., Alvarez, A. N., Mercier, L. A., Morton, B. C., ... & Cardiac Disease in Pregnancy (CARPREG) Investigators. (2001). Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in women with heart disease. *Circulation*, 104(5), 515–521. <https://doi.org/10.1161/hc3001.093437>
- Supriasa, D. N. (2016). *Penilaian status gizi*. Jakarta: EGC.
- van den Boogaard, E., Vissenberg, R., Land, J. A., van Wely, M., van der Post, J. A., & Goddijn, M. (2020). Significance of (sub)clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: A systematic review. *Human Reproduction Update*, 26(4), 560–579. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa006>
- Verburg, B. O., Steegers, E. A., De Ridder, M. A., Snijders, R. J., Smith, E., Hofman, A., ... & Jaddoe, V. W. (2020). Thyroid function and early pregnancy loss. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 105(4), e1613–e1621. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgz136>
- Warnes, C. A., Williams, R. G., Bashore, T. M., Child, J. S., Connolly, H. M., Dearani, J. A., ... & Webb, G. D. (2008). ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 52(23), e143–e263.
- WHO. (2013). Meeting to develop a global consensus on preconception care to reduce maternal and childhood mortality and morbidity. Geneva: World Health Organization.

WHO. (2020). Rh incompatibility: Maternal and neonatal health. Retrieved from <https://www.who.int/>

Yayasan Thalassemia Indonesia. (2021). Data kasus thalassemia nasional. Jakarta: YTI.

Glosarium

American College of Obstetricians and Gynecologists	Organisasi profesi dokter kandungan dan kebidanan di Amerika Serikat yang menetapkan pedoman praktik klinis.
American Diabetes Association	Organisasi yang fokus pada penelitian, pencegahan, dan penanganan diabetes.
Acquired Immune Deficiency Syndrome	Penyakit akibat infeksi HIV yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh secara drastis.
Berat Badan	Ukuran massa tubuh seseorang, biasanya dalam kilogram.
Body Mass Index / Indeks Massa Tubuh	Rasio berat badan terhadap tinggi badan untuk menilai status gizi.
Chronic Kidney Disease / Penyakit Ginjal Kronis	Gangguan fungsi ginjal jangka panjang yang menyebabkan penurunan kemampuan ginjal.
Diabetes Mellitus	Penyakit metabolik kronis akibat gangguan produksi atau kerja insulin yang menyebabkan kadar gula darah tinggi.
European Society of Cardiology	Organisasi yang mengembangkan pedoman dan penelitian di bidang kardiologi (penyakit jantung).
Hemoglobin	Protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Human Immunodeficiency Virus	Virus penyebab AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
Hari Perkiraan Lahir	Perkiraan tanggal kelahiran bayi berdasarkan hari pertama haid terakhir.
Ikatan Dokter Anak Indonesia	Organisasi profesi dokter anak di Indonesia.
Indeks Massa Tubuh	Rasio berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk menentukan status gizi seseorang.
Jaminan Kesehatan Nasional	Program pemerintah Indonesia untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara.
Kurang Energi Kronis	Kondisi kekurangan asupan energi jangka panjang yang berdampak pada status gizi, terutama pada ibu hamil.
Kesehatan Ibu dan Anak	Upaya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.
Penyakit Ginjal Kronis	Gangguan fungsi ginjal yang bersifat menahun dan menyebabkan penurunan kemampuan tubuh mengeluarkan zat sisa metabolisme.
Rapid Diagnostic Test	Tes cepat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit atau infeksi tertentu.
Rhesus	Faktor dalam darah yang menunjukkan ada atau tidaknya antigen Rh pada sel darah merah.
Tuberkulosis	Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , terutama menyerang paru-paru.
Tinggi Badan	Ukuran tinggi tubuh seseorang yang digunakan bersama berat badan untuk menentukan status gizi.

Triiodotironin	Hormon tiroid aktif yang berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh.
Tiroksin	Hormon utama yang diproduksi kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan.
World Health Organization	Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB yang bertanggung jawab atas isu kesehatan global.

BAB 3

Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi

A. Pentingnya Deteksi Dini Anemia

Wanita Usia Subur (WUS) adalah perempuan yang berada pada tahap peralihan dari akhir masa remaja menuju awal dewasa. Ciri utama WUS ditandai oleh proses fisiologis seperti menstruasi serta tercapainya puncak kesuburan dengan organ reproduksi yang telah berkembang optimal. WUS dianggap sebagai wanita dewasa yang siap menjalani peran sebagai ibu. Pada fase ini, kebutuhan gizi berbeda dengan masa kanak-kanak, remaja, maupun lanjut usia, karena gizi yang cukup sangat penting untuk mempersiapkan kehamilan dan masa menyusui (Zaçe et al., 2022).

Istilah "pra" berarti sebelum, sedangkan "konsepsi" mengacu pada pertemuan antara sel sperma dan ovum yang menghasilkan pembuahan. Dengan demikian, prakonsepsi adalah periode sebelum terjadinya pembuahan atau sebelum kehamilan. Masa pranikah sering kali dikaitkan dengan prakonsepsi, karena setelah menikah umumnya wanita segera memasuki proses konsepsi. Periode prakonsepsi dapat didefinisikan dari perspektif biologis, individu, dan kesehatan masyarakat. Dari perspektif biologis, prakonsepsi adalah 14 minggu sebelum konsepsi. Dari perspektif individu, prakonsepsi adalah kapanpun dua individu memutuskan untuk memiliki bayi. Dari perspektif kesehatan masyarakat, prakonsepsi adalah kapan pun, sebelum kehamilan, ketika perilaku kesehatan terbentuk. Pemenuhan kebutuhan gizi pada tahap ini sangatlah penting, karena kondisi kesehatan ibu sejak sebelum hamil hingga selama kehamilan akan memengaruhi kualitas generasi berikutnya (Stephenson et al., 2018).

Terdapat beberapa alasan penting mengapa calon ibu harus menjaga asupan gizinya pada masa prakonsepsi. Gizi yang optimal berperan dalam mendukung kinerja organ reproduksi, seperti memperlancar pematangan sel telur, menghasilkan sel telur yang berkualitas, serta membantu kelancaran proses pembuahan. Selain itu, kecukupan gizi juga sangat diperlukan untuk membentuk cadangan nutrisi yang akan menunjang pertumbuhan serta perkembangan janin. Bagi calon ibu, terpenuhinya kebutuhan gizi secara seimbang tidak hanya berdampak pada kesehatan selama proses pembuahan, tetapi juga sepanjang kehamilan. Dengan demikian, pemenuhan gizi pada masa prakonsepsi menjadi sangat krusial.

B. Anemia Defisiensi Besi, Asam Folat, dan Vitamin B12

Anemia adalah masalah kesehatan masyarakat global yang memengaruhi anak-anak, remaja, wanita selama kehamilan dan setelah melahirkan. Dalam bahasa Yunani Kuno, Anemia berasal dari kata "anaimia", yang berarti "kekurangan darah". Penurunan hemoglobin (Hb), hematokrit (HCT), atau jumlah sel darah merah, dikenal sebagai anemia. Sel darah merah diproduksi di dalam sumsum tulang kemudian dilepaskan ke dalam peredaran darah. Setiap harinya, sekitar 1% sel darah merah dikeluarkan dari sirkulasi. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan dan penghancuran sel darah merah, kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya anemia (Turner et al., 2023).

Seseorang mengalami anemia dengan nilai hemoglobin kurang dari 13 g/dL untuk pria, dan kurang dari 12 g/dL untuk wanita yang tidak hamil atau periode prakonsepsi. Gejala anemia secara umum meliputi pucat mulai dari bibir, jari, kuku, dan telapak tangan; denyut nadi cepat, mudah lelah dan mengantuk, pusing; serta sakit dada (ACOG, 2021). Sedangkan, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) mendefinisikan anemia sebagai hemoglobin <11 g/dL pada trimester pertama dan ketiga, dan <10,5 g/dL pada trimester kedua. Rendahnya hemoglobin selama kehamilan disebabkan oleh hemodilusi.

Hemodilusi adalah keadaan meningkatnya volume darah ibu hamil akibat bertambahnya volume plasma.

Etiologi anemia bersifat multifaktorial dan penyebabnya yang sangat bervariasi. Anemia dapat terjadi akibat perdarahan berlebihan saat menstruasi, pola kebiasaan makan remaja (prakonsepsi) seperti membatasi asupan makanan dan makanan kesukaan masih berlanjut selama masa kehamilan, pola makan ibu hamil yang kurang bervariasi dan seimbang, dan sering kali lebih memilih minum kopi dan teh saat makan (Pasaribu et al., 2023). Anemia dalam kehamilan dapat meningkatkan risiko ibu dan janin (angka kematian ibu yang lebih tinggi, kematian perinatal, preeklamsia, dan kecil usia kehamilan. Anemia yang khususnya terjadi pada trimester pertama kehamilan dikaitkan dengan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (World Health Organization, 2005).

1. Defisiensi Zat Besi

Kekurangan zat besi menjadi faktor utama penyebab anemia secara global. Sebesar 50% dari semua kasus anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Anemia defisiensi besi adalah penurunan produksi sel darah merah akibat rendahnya simpanan zat besi dalam tubuh. Zat besi merupakan komponen utama dari Hemoglobin (Hb). Defisiensi zat besi dapat terjadi akibat asupan makanan yang tidak mencukupi, kegagalan proses penyerapan di duodenum dan jejunum meskipun asupan sudah cukup, infeksi mikroorganisme yang mengganggu penyerapan dan sirkulasi zat besi, serta peningkatan kebutuhan zat besi seperti pada kehamilan. Mekanisme terjadinya anemia besi diawali dengan rendahnya simpanan zat besi (ferritin) dan peningkatan penyerapan zat besi. Hal ini diketahui dari peningkatan kemampuan mengikat dari zat besi. Penipisan simpanan zat besi, penurunan jumlah protoporfirin yang diubah menjadi heme, dan penurunan kadar ferritin serum merupakan langkah selanjutnya (Halterman & Segel, 2023).

Kekurangan zat besi meningkatkan risiko lebih tinggi ibu hamil mengalami berbagai komplikasi meliputi kelahiran prematur, BBLR, gangguan perkembangan neurofisiologis bayi, disfungsi plasenta, dan menurunkan pengiriman oksigen ke janin yang sedang berkembang. Selain itu, Defisiensi zat besi dikaitkan dengan risiko komplikasi kardipulmoner pada ibu hamil, persalinan caesar, perdarahan perinatal, solusio plasenta, dan, dan kematian. Dalam mencegah dampak kesehatan yang buruk pada kehamilan di masa depan maka diperlukan perhatian proaktif untuk memastikan kecukupan simpanan zat besi pada wanita usia reproduksi (Burns et al., 2025).

Konsentrasi feritin serum merupakan indikator simpanan zat besi. Konsentrasi feritin serum digunakan untuk mendiagnosis defisiensi zat besi pada individu yang sehat. Defisiensi zat besi berat memiliki kadar feritin yang lebih rendah dari 20-30 g/L, sedangkan defisiensi zat besi ringan-sedang memiliki kadar feritin di bawah 70-100 g/L.

Pemeriksaan kadar feritin serum tidak dianjurkan dilakukan pada trimester terakhir yaitu antara minggu ke-20 dan ke-28 kehamilan. Hal ini disebabkan karena adanya hemodialisis plasma serum sehingga terjadi perubahan nilai ambang kadar feritin. Dengan demikian, pemeriksaan kadar feritin untuk mendiagnosis anemia defisiensi besi pada wanita hamil dianjurkan pada trimester pertama atau wanita periode prakonsepsi (World Health Organization, 2020).

2. Defisiensi Asam Folat

Asam folat (asam pteroilglutamat) merupakan nutrisi esensial dari kelompok vitamin B kompleks yang larut air. Asam folat berperan dalam sintesis dan perbaikan DNA, RNA, asam amino dan asam nukleat. Asam folat membantu dalam proses ovulasi, meliputi membantu dalam produksi dan pertumbuhan folikel ovarium, pematangan dan perkembangan sel telur, dan menjaga keseimbangan hormon reproduksi (estrogen, progesteron, hormon luteinisasi, dan hormon perangsang folikel) (Gaskins et al., 2012).

Dengan demikian, asam folat dapat meningkatkan keberhasilan ovulasi bagi wanita yang sedang merencanakan kehamilan. Defisiensi asam folat dikaitkan dengan perubahan metilasi DNA dan gangguan perkembangan otak janin. Suplementasi asam folat yang diberikan sebelum konsepsi dan awal kehamilan berperan dalam mencegah cacat tabung saraf atau Neural Tube Defect (NTD). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan suplementasi asam folat sebanyak 400 µg setiap hari. Asam Folat banyak ditemukan dalam bahan makanan meliputi hati sapi, sayuran berdaun hijau tua (seperti bayam dan sawi), buah-buahan, buncis, dan kacang-kacangan (seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah)

3. Defisiensi Vitamin B12

Defisiensi vitamin B12 (kobalamin) merupakan penyebab paling umum anemia megaloblastik. Vitamin B12 diperlukan untuk sistem saraf dan reproduksi, eritropoiesis, sintesis DNA, metabolisme asam amino dan lemak, serta metabolisme energi seluler. Selain itu, B12 berperan penting untuk multiplikasi sel dalam jaringan plasenta dan janin. Kadar normal kebutuhan vitamin B12 adalah 369-959 pmol/L, sedangkan kadar rendah B12 adalah < 200 pmol/L (Agbalalah et al., 2023). Gejala kekurangan vitamin B12 meliputi kelelahan, kelemahan, perubahan suasana hati, kesemutan di tangan dan kaki, siklus menstruasi tidak teratur, dan kualitas sperma buruk.

Defisiensi B12 berdampak signifikan pada kesehatan reproduksi pria dan wanita. Pada pria, defisiensi vitamin B12 dapat mengurangi produksi dan motilitas sperma. Sedangkan pada wanita, Kekurangan ini dapat menyebabkan anovulasi, mengganggu pembelahan sel, mengganggu perkembangan sel telur dan gangguan implantasi. Defisiensi vitamin B12 pada ibu hamil dapat menyebabkan rendahnya konsentrasi hemoglobin sehingga menurunkan oksigenasi janin dan luaran janin yang abnormal. Hal ini menyebabkan berbagai komplikasi meliputi preeklamsia, persalinan prematur, intrauterine growth restriction (IUGR), BBLR, prematur, aborsi, peningkatan morbiditas dan mortalitas perinatal (Agbalalah et al., 2023).

C. Deteksi Dini Obesitas dan Malnutrisi Prakonsepsi

Status gizi pada masa prakonsepsi sangat diperlukan untuk mempersiapkan kehamilan kelak. Masalah gizi terjadi akibat pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi terjadi tidak seimbang. Masalah gizi ada 2 meliputi obesitas dan malnutrisi. Asupan nutrisi yang berlebihan namun pengeluaran energi kurang akan menyebabkan obesitas. Sedangkan, malnutrisi disebut juga kekurangan gizi. Hal ini terjadi akibat asupan nutrisi yang kurang, ketidakmampuan tubuh untuk menyerap energi (malabsorpsi), peningkatan kehilangan nutrisi, dan perubahan kebutuhan metabolisme.

Asupan berlebihan pada obesitas mengakibatkan penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Lemak di dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu : lemak sentral dan lemak visceral. Lemak sentral merupakan

penumpukan lemak yang diakibatkan oleh jumlah jaringan lemak yang berlebih, baik di lemak subkutan atau di lemak intra-abdomen. Sedangkan, lemak visceral merupakan lemak yang berlokasi di sekitar viseral (di sekitar organ rongga dada dan rongga perut) dan di dalam peritoneum.

Penumpukan lemak terjadi akibat ketidakseimbangan energi antara pemasukan dan pemakaian energi. Obesitas sentral menyebabkan risiko yang lebih besar terhadap kesehatan dibandingkan dengan obesitas non-sentral. Risiko obesitas sentral meliputi hipertensi, dislipidemia, diabetes, sindrom metabolik, penyakit kardiovaskular, dan penyakit jantung koroner lebih mungkin terjadi akibat obesitas sentral. Obesitas sentral juga dihubungkan dengan sindrom ovarium polikistik, infertilitas, produksi hormon reproduksi yang tidak normal, masalah psikologis, dan berbagai jenis kanker.

Obesitas sebelum kehamilan dapat memengaruhi keseimbangan metabolisme dan hormonal sehingga berdampak pada sistem reproduksi. Hal ini disebabkan karena adipokin (adiponektin dan sitokin) yang diproduksi oleh sel lemak viseral, dapat mengganggu fungsi hormonal. Selain itu, obesitas juga menyebabkan perubahan pada berbagai regulasi hormon, termasuk insulin, androgen, serta globulin pengikat hormon seks. Perubahan tersebut dapat berdampak pada terjadinya anovulasi, infertilitas, hingga meningkatnya risiko keguguran. Pada Wanita Usia Subur (WUS), obesitas dapat menghambat kehamilan di masa mendatang melalui gangguan ovulasi dan disfungsi plasenta. Obesitas selama kehamilan memiliki risiko mengalami diabetes gestasional, gangguan hipertensi pada kehamilan termasuk preeklamsia, dan kelahiran prematur, serta kelahiran bayi makrosomia. Selain itu, obesitas dikaitkan dengan tingkat kelahiran sesar, trauma kelahiran yang lebih tinggi, dan dapat menjadi faktor risiko untuk obesitas anak dan masalah kesehatan terkait.

Disisi lain, malnutrisi pada masa prakonsepsi memiliki efek negatif pada hasil kehamilan. Gizi buruk pada perempuan berkontribusi terhadap 20% kematian ibu, dan merupakan faktor risiko signifikan untuk bayi lahir mati, pertumbuhan janin tidak sempurna, kelahiran prematur, kecil usia kehamilan, dan bayi berat lahir rendah (Dean et al., 2014). Pada wanita prakonsepsi yang memiliki LILA <23,5cm berisiko kekurangan energi kronik (KEK). Kekurangan energi kronis (KEK) pada kehamilan berisiko melemahnya kekuatan otot pendukung proses persalinan, sehingga dapat mengakibatkan

persalinan lama, perdarahan pasca melahirkan, bahkan kematian ibu dan janin.

Deteksi dini terhadap status gizi dapat dilakukan dengan pengukuran IMT (Indeks Massa Tubuh) dan LILA (Lingkar Lengan Atas). IMT merupakan metode sederhana yang digunakan untuk memantau status gizi, terutama yang berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan berat badan. Namun, IMT memiliki keterbatasan karena tidak dapat mengukur obesitas sentral. Hal ini disebabkan IMT tidak mampu menilai distribusi lemak dalam tubuh sehingga kurang akurat dalam menentukan obesitas sentral. Penghitungan IMT dilakukan dengan membandingkan berat badan (dalam kilogram) dengan tinggi badan (dalam meter) yang dikuadratkan (m^2). Berikut adalah klasifikasi ambang batas IMT (Antell & FAAFP, 2016) :

Tabel 3.1 Klasifikasi Ambang Batas IMT

Kategori	Keterangan	IMT (kg/m²)
Sangat kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	<17,0
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0- 18,4
Normal	Optimal	18,5- 22,9
Overweight	Kelebihan berat badan tingkat ringan	23,0- 24,9
Gemuk (Obesitas I)	Kelebihan berat badan tingkat sedang	25,0- 26,9
Sangat gemuk (Obesitas II)	Kelebihan berat badan tingkat berat	≥27,0

Pemeriksaan Lingkar Lengan Atas (LILA) dapat dijadikan alternatif pengukuran status gizi selain BMI. LILA mencerminkan cadangan lemak tubuh secara keseluruhan, di mana lingkar yang lebih besar menunjukkan cadangan lemak yang cukup, sedangkan lingkar yang kecil menandakan cadangan lemak yang rendah. Pengukuran LILA dilakukan menggunakan pita ukur pada lengan kiri atau lengan yang tidak dominan, tepat di titik tengah antara pangkal lengan atas (prosesus akromion) dan ujung siku (olekranon), dengan satuan sentimeter (cm). Kategori LILA menurut Bari et al adalah sebagai berikut: malnutrisi berat <19 cm, malnutrisi sedang ≥19–<22 cm, malnutrisi ringan ≥22–23 cm, normal >23–30 cm, dan obesitas >30 cm. Pada ibu hamil, nilai LILA <23,5 cm menunjukkan risiko kekurangan energi kronis (KEK). Namun, pengukuran ini tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam waktu singkat, sehingga perlu dilengkapi dengan metode antropometri lainnya untuk mengetahui perubahan status gizi secara lebih akurat (Bari et al., 2020)..

Selanjutnya, Penilaian lemak tubuh bagian sentral atau abdominal diukur pada bagian lingkar pinggang dan rasio lingkar pinggang terhadap panggul. Pengukuran lingkar pinggang dilakukan pada titik tengah di antara puncak tulang panggul dan tulang rusuk paling bawah, sedangkan lingkar panggul diukur pada bagian terluas dari panggul. Dengan membagi lingkar pinggang dengan lingkar pinggul, rasio pinggang-pinggul dapat ditentukan. Obesitas sentral dikategorikan pada laki-laki dengan lingkar pinggang lebih dari 90 cm dan pada perempuan dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm.

Sementara itu, rasio lingkaran pinggang-panggul dianggap berisiko apabila melebihi 0,90 pada laki-laki dan 0,85 pada perempuan.

D. Intervensi Gizi Seimbang dan Suplementasi Prakonsepsi

Pemenuhan status gizi yang seimbang pada masa prakonsepsi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan kesehatan reproduksi wanita. Selain menjaga kesehatan ibu, pola makan yang tepat pada masa ini memengaruhi kesiapan tubuh untuk ovulasi, pembuahan, dan kehamilan yang sehat. Pola makan seimbang harus mengandung cukup makronutrien (lemak, protein, dan karbohidrat) dan mikronutrien (vitamin dan mineral). Selain itu, unsur lain seperti serat juga berkontribusi pada pengaturan metabolisme, keseimbangan hormon, dan kesehatan reproduksi. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi optimal sejak prakonsepsi, risiko infertilitas, komplikasi kehamilan, dan masalah kesehatan janin dapat diminimalkan.

1. Karbohidrat

Karbohidrat berperan dalam memenuhi kebutuhan energi dalam proses metabolisme tubuh. Jumlah dan jenis karbohidrat sangat penting dalam diet perempuan usia subur yang berencana untuk hamil. Konsumsi karbohidrat berlebihan dapat memengaruhi ovulasi dan kesuburan wanita secara signifikan. Indeks glikemik pada karbohidrat berpotensi meningkatkan resistensi insulin, dislipidemia, dan stres oksidatif, yang berdampak negatif pada kesuburan dan fungsi ovarium. Insulin dapat memodulasi steroidogenesis ovarium serta hiperinsulinemia yang berkorelasi positif dengan hiperandrogenisme dan gangguan ovulasi. Dengan demikian, dapat mengganggu proses pematangan oosit. Kebutuhan energi pada laki-laki sebesar 2600-2750 kkal, sedangkan pada wanita 2100-2250 kkal. Sumber makanan karbohidrat meliputi beras, pasta, gandum, roti, dan sereal (Skoracka et al., 2021).

2. Protein

Pada masa prakonsepsi, kebutuhan protein berkisar antara 10-30% dari total kebutuhan energi harian. Protein berperan penting sebagai zat pembangun, pengatur, serta memperbaiki jaringan dan sel yang mengalami kerusakan. Meskipun bukan merupakan sumber energi utama, protein dapat digunakan sebagai energi dengan menyediakan 4 kkal per gram. Asupan protein dapat diperoleh dari berbagai makanan yang mengandung protein

hewani maupun nabati. Sumber protein hewani meliputi ikan, telur, daging, daging ayam, susu, sedangkan protein nabati meliputi kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Konsumsi tinggi protein hewani dikaitkan dengan risiko infertilitas yang lebih tinggi akibat kurangnya ovulasi. Sebaliknya, asupan protein nabati meningkatkan kesuburan pada wanita di atas usia 32 tahun. Perbedaan disebabkan oleh dampak protein nabati dan hewani terhadap sekresi insulin dan IGF-I. Respons insulin lebih rendah setelah konsumsi protein nabati dibandingkan setelah konsumsi protein hewani (Skoracka et al., 2021).

3. Lemak

Lemak merupakan sumber energi tertinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Setiap gram lemak akan menghasilkan energi sebesar 9 kkal. Asupan lemak harian yang direkomendasikan berkisar antara 20–30% dari total kebutuhan energi. Selain sebagai sumber energi, lemak juga berperan dalam membantu absorpsi vitamin A, D, E, dan K, serta komponen penting dalam makanan yang dapat memengaruhi kesuburan. Diet konsumsi tinggi lemak dapat dikaitkan dengan perubahan fungsi reproduksi meliputi panjang siklus menstruasi, konsentrasi hormon reproduksi (hormon luteinisasi (LH)), kualitas embrio dalam siklus ART, dan kematangan sperma pada pria. Makanan yang mengandung lemak terdapat pada daging merah, ayam, ikan, udang, susu, keju, dan minyak.

4. Serat

Serat merupakan komponen kunci dari pola makan sehat setiap individu. Serat pangan didefinisikan sebagai bagian tumbuhan yang dapat dimakan atau karbohidrat analog yang resisten terhadap pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia. Sumber makanan tinggi serat meliputi sayuran, kacang-kacangan/biji-bijian, buah-buahan, dan sereal. Asupan serat makanan yang lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa masalah kesehatan meliputi penyakit kardiovaskular (CVD), kanker, diabetes tipe 2, obesitas, kesulitan buang air besar (konstipasi/sembelit), dan wasir (hemoroid). Beberapa mekanisme potensial serat bekerja, meliputi : 1) pengurangan penyerapan glukosa dan kolesterol LDL ; 2) rasa kenyang dan efek kenyang, yang dapat meningkatkan penurunan berat badan; 3) produksi asam lemak rantai pendek yang diinduksi mikrobioma usus, yang memiliki sifat imunomodulator dan anti-inflamasi; 4) penangkapan asam empedu dan zat karsinogenik; dan 5) peningkatan asupan senyawa aktif biologis, seperti fitokimia dan

antioksidan (Veronese et al., 2018). Dalam sistem reproduksi, Asupan serat moderat (sekitar 25–30 g/hari) dapat meningkatkan kesehatan reproduksi, khususnya pada wanita dengan PCOS, sedangkan asupan serat yang terlalu tinggi (>35 g/hari) atau disertai defisit energi dapat meningkatkan risiko anovulasi akibat penurunan konsentrasi hormon estrogen. Mekanisme ini terjadi karena serat menyebabkan penurunan aktivitas β -glukuronidase dalam feses sehingga terjadi penurunan reabsorpsi estrogen di kolon. Selain itu, serat mengikat estrogen di usus sehingga meningkatkan ekskresi fesesnya (Gaskins et al., 2009).

5. Cairan

Cairan sangat penting bagi kelangsungan hidup. Air adalah komponen utama jaringan manusia, dan 83% darah terdiri dari air. Tiga sumber masukan air tersedia: air minum, air dari makanan dan air endogen. Empat cara keluaran air meliputi urin melalui sistem kemih, keringat melalui permukaan kulit, napas melalui sistem pernapasan, dan feses melalui sistem pencernaan. Asupan air yang tidak mencukupi dapat menyebabkan keadaan dehidrasi, mengurangi kemampuan aktivitas fisik, kemampuan kognitif, meningkatkan risiko penyakit sistem kemih (seperti batu ginjal, infeksi saluran kemih dan penyakit ginjal kronis), dan meningkatkan penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, menjaga status hidrasi yang optimal sangat penting bagi kesehatan manusia (Zhang et al., 2020).

Asupan cairan yang direkomendasikan adalah sekitar 1,5 hingga 2 liter cairan, atau delapan gelas air. Air putih merupakan minuman yang dianjurkan periode prakonsepsi daripada teh, kopi, alkohol, minuman berkarbonasi, dan sirup. Pemenuhan cairan mendukung fungsi keseluruhan sistem reproduksi. Studi yang sama mengungkapkan bahwa bagi wanita, hidrasi membantu mengurangi kekeringan vagina, dan mencegah infeksi jamur sedangkan pada pria dapat memengaruhi kualitas sperma. Selanjutnya, Konsumsi alkohol secara kronis dikaitkan dengan berkurangnya kesuburan dan risiko lebih tinggi terkena gangguan menstruasi. Alkohol berdampak langsung pada pematangan ovum, ovulasi, perkembangan blastokista awal, dan implantasi. Penting juga untuk menekankan bahwa konsumsi alkohol selama kehamilan dapat mengakibatkan efek buruk pada perkembangan keturunan, seperti gangguan spektrum alkohol janin (Skoracka et al., 2021b).

Rekomendasi suplementasi untuk intervensi gizi pada masa prakonsepsi sebagai berikut:

1. Asam Folat

Asam folat adalah kofaktor penting dalam metabolisme satu karbon yang bertanggung jawab untuk sintesis DNA dan RNA dan metilasi DNA. Asam folat berperan penting untuk kualitas dan pematangan oosit, implantasi, embriogenesis, plasentasi, pertumbuhan janin, dan perkembangan organ selama kehamilan. Asupan folat yang tidak memadai dikaitkan dengan perubahan metilasi DNA dan perkembangan otak janin yang terganggu. Suplementasi asam folat yang diberikan sebelum konsepsi dan awal kehamilan berperan dalam mencegah cacat tabung saraf atau Neural Tube Defect (NTD), retardasi pertumbuhan intrauterin, anensefali, spina bifida, peningkatan kelahiran prematur, dan keguguran. Asupan Gizi yang direkomendasikan pada periode prakonsepsi untuk pria dan wanita adalah 400 mcg folat per hari. Banyak makanan tinggi asam folat meliputi daging, buah-buahan, sayuran (terutama asparagus), kacang-kacangan, biji wijen, dan sereal (biji-bijian).

2. Zat Besi

Zat besi diperlukan tubuh untuk pembentukan hemoglobin dan mioglobin yang dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Kekurangan asupan zat besi dapat menyebabkan anemia dan gangguan ovulasi pada perempuan. Selama kehamilan, zat besi akan ditransfer transplasenta untuk membangun simpanan zat besi janin sebelum lahir sehingga kebutuhan zat besi akan meningkat. Simpanan zat besi yang cukup berperan penting bagi janin. Hal ini disebabkan karena ASI sebagai sumber makanan utama bagi bayi selama 6 bulan pertama kehidupan memiliki zat besi yang rendah. Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan zat besi sebelum konsepsi dan selama kehamilan (Burns et al., 2025). Kecukupan zat besi yang direkomendasikan pada pria sebesar 13-15 mg/hari, sedangkan pada wanita sebesar 26 mg/hari. Sumber makanan heme (hewani) memiliki lebih banyak kandungan zat besi dibandingkan makanan non-heme (nabati). Sumber makanan yang mengandung zat besi heme meliputi hati, daging merah, ikan, unggas, sedangkan zat besi non heme meliputi sayuran berdaun hijau (bayam), kacang-kacangan, rumput laut, kismis, dan kurma.

Salah satu strategi untuk menghindari anemia selama masa prakonsepsi adalah dengan mengonsumsi suplemen zat besi oral. Pemberian suplementasi harian sebagai perawatan rutin mengandung 30 mg Ferro sulfat. Namun, suplementasi zat besi menyebabkan efek samping berupa gangguan gastrointestinal seperti sembelit dan tinja berwarna hitam pekat. Hemoglobin biasanya akan kembali normal dalam 6-8 minggu, dengan peningkatan jumlah retikulosit hanya dalam 7-10 hari (Turner et al., 2023). Vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Pasien disarankan untuk menghindari konsumsi zat besi bersamaan dengan tanin, kalsium, dan fitat, karena dapat mengurangi penyerapan zat besi.

3. Vitamin D

Vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin D berperan dalam keseimbangan kalsium, meningkatkan produksi dan sekresi sitokin proinflamasi, serta metabolisme glukosa melalui stimulasi sintesis dan sekresi insulin. Vitamin D sebagai pengaturan metabolisme glukosa berperan penting dalam mencegah perkembangan PCOS (Melo et al., 2015). Selain itu, Vitamin D juga memiliki sifat anti-inflamasi dan imunomodulasi yang dapat dikaitkan dengan endometriosis sebagai penyebab infertilitas (Muscogiuri et al., 2017). Sumber vitamin D dapat diperoleh dari berbagai bahan makanan seperti hati, telur, dan ikan. Selain itu, makanan hewani maupun nabati yang mengandung provitamin D dapat diubah menjadi vitamin D ketika terpapar sinar matahari. Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013, kebutuhan vitamin D bagi pria dan wanita pada masa prakonsepsi adalah sebesar 15 mcg.

4. Vitamin A

Vitamin A memiliki peran penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, mendukung fungsi penglihatan, serta bertindak sebagai antioksidan. Sumber tinggi antioksidan berperan penting dalam kesuburan pria dan wanita. Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), kebutuhan vitamin A pada pria di masa prakonsepsi adalah 600 mcg, sedangkan pada wanita sebesar 500 mcg. Sumber vitamin A dapat diperoleh dari berbagai bahan makanan seperti daging, kuning telur, susu, mentega, wortel, tomat, kacang panjang, dan bayam.

5. Vitamin C

Asam askorbat (ascorbic acid) atau vitamin C berperan penting dalam mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh, membentuk kolagen, meningkatkan penyerapan zat besi. Dan

mendukung metabolisme asam folat. Selain itu, Vitamin C merupakan sumber tinggi antioksidan yang berperan penting dalam kesuburan sistem reproduksi. Vitamin C konsentrasi tinggi berperan dalam pertumbuhan folikel de graaf, ovulasi, dan fase luteal. Selain itu, vitamin C juga membantu memulihkan vitamin E dan glutathione yang teroksidasi. Kebutuhan vitamin C adalah 90 mg/hari pada pria dan 75 mg/hari pada wanita. Sumber makanan vitamin C berasal dari buah-buahan dan sayuran segar seperti jambu biji, kiwi, strawberry, nanas, jeruk, lemon, mangga, dan lain sebagainya.

6. Vitamin E

vitamin E sebagai sumber antioksidan yang berperan penting dalam kesuburan. Vitamin E dapat meningkatkan pertumbuhan epitel di pembuluh darah dan endometrium, menurunkan konsentrasi hormon seks, meningkatkan sensitivitas insulin jaringan, memengaruhi ovulasi, sintesis prostaglandin, serta steroidogenesis. Vitamin E yang dikombinasikan dengan suplemen lain seperti seng, selenium, zat besi, dan L-arginin dapat meningkatkan ovulasi dan tingkat kehamilan. Selain sifat antioksidannya, ia juga memiliki efek anti-inflamasi dalam mengurangi produksi prostaglandin. Sumber utama vitamin E adalah minyak nabati (seperti minyak jagung, minyak bunga matahari, dan minyak zaitun), kacang-kacangan dan biji-bijian (seperti biji bunga matahari, kacang kenari, kacang almond), buah kiwi dan alpukat. Angka Kecukupan Gizi (AKG) vitamin E pria dan wanita pada masa prakonsepsi adalah 15 mg/hari (Vašková et al., 2023).

7. Selenium

Selenium memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta bertindak sebagai antioksidan. Vitamin E yang dikombinasikan dengan suplemen lain seperti seng, selenium, zat besi, dan L-arginin dapat meningkatkan kualitas sperma dan ovulasi sehingga meningkatkan kehamilan. Menurut AKG, kebutuhan selenium bagi pria dan wanita pada masa prakonsepsi adalah 30 mcg per hari. Sumber nutrisi ini banyak terdapat dalam daging, ikan, susu, telur, sayuran silangan, sayuran liliaceus, kacang-kacangan, bawang putih, bawang merah

8. Seng (Zinc)

Seng (Zinc) berperan dalam mendukung fungsi kekebalan, aktivitas antioksidan, dan kesehatan reproduksi pria dan wanita. Defisiensi zinc selama kehamilan meningkatkan risiko hasil yang merugikan yang meliputi keguguran, retardasi pertumbuhan

janin, gangguan perkembangan saraf, dan disfungsi plasenta. Sumber seng dapat diperoleh dari ikan, kerang, daging, kacang-kacangan, ayam, tahu padat, labu dan biji labu, dan yogurt rendah lemak. Berdasarkan AKG, kebutuhan seng pada pria di masa prakonsepsi adalah 13–17 mg per hari, sedangkan pada wanita sebesar 10 mg per hari.

E. Penutup

Kebutuhan zat gizi pada masa prakonsepsi sangat perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena wanita usia pra konsepsi merupakan kelompok wanita yang akan mempersiapkan kehamilan di masa depan. Anemia, malnutrisi, dan obesitas merupakan masalah kesehatan yang dapat meningkatkan risiko ibu dan janin meliputi preeklamsia, BBLR, IUGR, keguguran, cacat bawaan, masalah kesuburan, dan sebagainya. Dalam mencegah dampak kesehatan yang buruk pada kehamilan di masa depan maka diperlukan deteksi dini sebagai langkah awal untuk mengetahui masalah gizi dan pemenuhan nutrisi seimbang serta dan suplementasi selama prakonsepsi.

Referensi

- ACOG. (2021). *Anemia in Pregnancy*. Obstet Gynecol.
- Agbalalah, T., Robert, F. O., & Amabebe, E. (2023). Impact of vitamin B12 on the reproductive health of women with sickle cell disease: a narrative review. *Reproduction & Fertility*, 4(3), e230015. <https://doi.org/10.1530/RAF-23-0015>
- Antell, K., & FAAFP. (2016). Preconception Nutrition. *Delaware Journal of Public Health*, 2(3), 20. <https://doi.org/10.32481/DJPH.2016.06.010>
- Bari, A., Sultana, N., Mehreen, S., Sadaqat, N., Imran, I., & Javed, R. (2020). Patterns of maternal nutritional status based on mid upper arm circumference. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 36(3), 382. <https://doi.org/10.12669/PJMS.36.3.1331>
- Burns, J. L., Miller, C. H., Fontaine-Bisson, B., & Connor, K. L. (2025). Iron deficiency and iron deficiency anaemia in women of reproductive age: Sex- and gender-based risk factors and inequities. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, 90, 127684. <https://doi.org/10.1016/J.JTEMB.2025.127684>
- Dean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception care: Nutritional risks and interventions. *Reproductive Health*, 11(3), 1–15. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S3/FIGURES/8>
- Gaskins, A. J., Mumford, S. L., Chavarro, J. E., Zhang, C., Pollack, A. Z., Wactawski-Wende, J., Perkins, N. J., & Schisterman, E. F. (2012). The Impact of Dietary Folate Intake on Reproductive Function in Premenopausal Women: A Prospective Cohort Study. *PLOS ONE*, 7(9), e46276. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0046276>
- Gaskins, A. J., Mumford, S. L., Zhang, C., Wactawski-Wende, J., Hovey, K. M., Whitcomb, B. W., Howards, P. P., Perkins, N. J., Yeung, E., & Schisterman, E. F. (2009). Effect of daily fiber intake on reproductive function: the BioCycle Study1. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 90(4), 1061. <https://doi.org/10.3945/AJCN.2009.27990>

- Halterman, J. S., & Segel, G. B. (2023). Iron Deficiency Anemia. *Pediatric Clinical Advisor*, 31–31. <https://doi.org/10.1016/B978-032303506-4.10019-7>
- Melo, A. S., Ferriani, R. A., & Navarro, P. A. (2015). Treatment of infertility in women with polycystic ovary syndrome: Approach to clinical practice. *Clinics*, 70(11), 765–769. [https://doi.org/10.6061/clinics/2015\(11\)09](https://doi.org/10.6061/clinics/2015(11)09)
- Muscogiuri, G., Altieri, B., de Angelis, C., Palomba, S., Pivonello, R., Colao, A., & Orio, F. (2017). Shedding new light on female fertility: The role of vitamin D. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 18(3), 273–283. <https://doi.org/10.1007/S11154-017-9407-2>,
- Pasaribu, R. D., Arintonang, E., Sudaryati, E., & Zuska, F. (2023). Anemia in Pregnancy: Study Phenomenology. *Portuguese Journal of Public Health*, 42(1), 6. <https://doi.org/10.1159/000534708>
- Skoracka, K., Ratajczak, A. E., Rychter, A. M., Dobrowolska, A., & Krela-Kaźmierczak, I. (2021a). Female Fertility and the Nutritional Approach: The Most Essential Aspects. *Advances in Nutrition*, 12(6), 2372. <https://doi.org/10.1093/ADVANCES/NMAB068>
- Skoracka, K., Ratajczak, A. E., Rychter, A. M., Dobrowolska, A., & Krela-Kaźmierczak, I. (2021b). Female Fertility and the Nutritional Approach: The Most Essential Aspects. *Advances in Nutrition*, 12(6), 2372. <https://doi.org/10.1093/ADVANCES/NMAB068>
- Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D. A. J. M., Hutchinson, J., Cade, J. E., Poston, L., Barrett, G., Crozier, S. R., Barker, M., Kumaran, K., Yajnik, C. S., Baird, J., & Mishra, G. D. (2018). Before the beginning: nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. *The Lancet*, 391(10132), 1830–1841. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30311-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30311-8)
- Turner, J., Parsi, M., & Badireddy, M. (2023). Anemia. *Comprehensive Pharmacology, Seven Volume Set*, 4, V4:570-V4:596. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00143-2>
- Vašková, J., Klepcová, Z., Špaková, I., Urdzík, P., Štofilová, J., Bertková, I., Kl'oc, M., & Rabajdová, M. (2023). The Importance of Natural Antioxidants in Female Reproduction. *Antioxidants*, 12(4), 907. <https://doi.org/10.3390/ANTIOX12040907>
- Veronese, N., Solmi, M., Caruso, M. G., Giannelli, G., Osella, A. R., Evangelou, E., Maggi, S., Fontana, L., Stubbs, B., & Tzoulaki, I. (2018). Dietary fiber and health outcomes: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 107(3), 436–444. <https://doi.org/10.1093/AJCN/NQX082>
- World Health Organization. (2005). *Atlas: child and adolescent mental health resources: global concerns: implications for the future*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *Guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations*. World Health Organization.
- Zaçe, D., Orfino, A., Viteritti, A. M., Versace, V., Ricciardi, W., & Di Pietro, M. L. (2022). A comprehensive assessment of preconception health needs and interventions regarding women of childbearing age: a systematic review. *Journal of Preventive*

Glosarium

Anemia	Kondisi berkurangnya kadar hemoglobin (Hb), hematokrit (HCT), atau jumlah sel darah merah dalam darah, sehingga mengurangi kemampuan darah membawa oksigen ke jaringan tubuh.
Anemia Defisiensi Besi	Jenis anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin menurun. Ditandai kadar feritin serum rendah.
Anemia Megaloblastik	Jenis anemia akibat defisiensi vitamin B12 atau asam folat, ditandai dengan pembesaran sel darah merah (eritrosit).
Asam Folat	Vitamin B9, berperan dalam sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, dan mencegah cacat tabung saraf (Neural Tube Defect) pada janin.
BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)	Kondisi bayi lahir dengan berat badan di bawah 2500 gram.
BMI (Body Mass Index / IMT)	Indeks yang digunakan untuk menilai status gizi dengan membandingkan berat badan (kg) dengan tinggi badan (m^2).
Cacat Tabung Saraf (Neural Tube Defect / NTD)	Kelainan kongenital akibat gangguan penutupan tabung saraf pada janin, sering dikaitkan dengan kekurangan asam folat.
CDC (Centers for Disease Control and Prevention)	Lembaga kesehatan Amerika Serikat yang menetapkan pedoman kesehatan, termasuk definisi anemia dan gizi.
Defisiensi Vitamin B12 (Kobalamin)	Kekurangan vitamin B12 yang menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan sistem saraf.
Duodenum dan Jejunum	Bagian usus halus tempat utama penyerapan zat besi dan nutrisi penting lainnya.
Feritin	Protein penyimpan zat besi dalam tubuh. Kadar feritin serum digunakan untuk menilai simpanan zat besi.
Hemoglobin (Hb)	Protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.
Hemodilusi	Kondisi pengenceran darah akibat peningkatan volume plasma selama kehamilan, menyebabkan kadar Hb tampak menurun.
IMT (Indeks Massa Tubuh)	Rasio berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk menilai status gizi. IMT normal pada wanita dewasa 18,5–22,9 kg/m^2 .
Infertilitas	Ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh kehamilan setelah satu tahun melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi.
IUGR (Intrauterine Growth Restriction)	Gangguan pertumbuhan janin di dalam rahim yang menyebabkan bayi berukuran kecil dibanding usia kehamilan.

Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Kondisi gizi kurang pada wanita dengan LILA <23,5 cm, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.
LILA (Lingkar Lengan Atas)	Ukuran antropometri untuk menilai cadangan lemak tubuh dan status gizi wanita usia subur dan ibu hamil.
Makronutrien	Zat gizi utama yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
Malnutrisi	Kondisi kekurangan atau kelebihan zat gizi yang menyebabkan gangguan fungsi tubuh.
Mikronutrien	Zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral.
Obesitas	Kondisi kelebihan lemak tubuh akibat ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi.
Obesitas Sentral	Penumpukan lemak di daerah perut (viseral) yang meningkatkan risiko penyakit metabolik dan gangguan reproduksi.
Ovulasi	Proses pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba falopi, biasanya sekitar hari ke-14 siklus menstruasi.
Pasien Prakonsepsi	Wanita usia subur yang sedang mempersiapkan kehamilan dan membutuhkan pemenuhan gizi optimal.
Plasenta	Organ sementara selama kehamilan yang menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin.
Prakonsepsi	Masa sebelum terjadinya pembuahan, yaitu periode persiapan fisik dan gizi untuk kehamilan.
Preeklamsia	Komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan protein dalam urin, sering dikaitkan dengan anemia dan defisiensi nutrisi.
Suplementasi Prakonsepsi	Pemberian tambahan vitamin dan mineral sebelum kehamilan untuk mencegah defisiensi dan komplikasi kehamilan.
Wanita Usia Subur (WUS)	Perempuan berusia 15–49 tahun yang secara fisiologis mampu hamil dan melahirkan.
Zat Besi (Fe)	Mineral utama pembentuk hemoglobin dan mioglobin. Kebutuhan wanita prakonsepsi ± 26 mg/hari.
Zinc (Seng)	Mineral penting untuk pertumbuhan jaringan, sistem imun, dan reproduksi pria maupun wanita.

BAB 4

Deteksi Dini Gangguan Menstruasi dan Kesuburan

A. Mengenal Gangguan Menstruasi dan Kesuburan

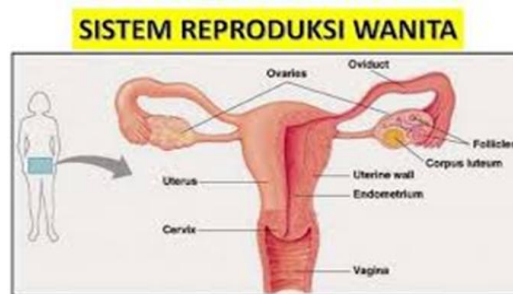
Wanita dalam masa reproduksi biasanya mengalami perubahan fisiologis yang menopause yang ditandai dengan tidak adanya menstruasi. Haid pertama disebut menarche, setelah itu wanita biasa mengalami haid secara berkala secara teratur setiap bulannya. Banyak wanita yang mengalami gangguan haid seperti dismenore dan nyeri haid, padahal haid adalah peristiwa yang wajar dan alami (Ekawati, 2019). Beberapa gejala gangguan haid yang sering dikeluhkan adalah dismenore. Premenstruasi sindrom (PMS), haid yang tidak teratur dan haid yang banyak dan lama (Daramatasia et al., 2022).

Pada umumnya para ibu menganggap menstruasi sebagai hal sepele yang tidak perlu diperhatikan. Padahal, menstruasi dapat mewakili kesehatan reproduksi dan harus selalu diperhatikan. Selain itu, tidak ada perhatian serius yang diberikan pada program kesehatan yang berkaitan dengan menopause. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan agar ibu-ibu dapat mendeteksi gangguan haid maupun permasalahan dalam menopause lebih dini, sehingga bisa melakukan penatalaksanaan awal secara mandiri. Diharapkan ibu-ibu juga dapat mengetahui waktu pemeriksaan ke RS untuk mencegah dampak yang merugikan pada kesehatan reproduksi.

Gangguan menstruasi adalah kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi. Ada beragam gangguan menstruasi yang bisa dialami wanita, mulai dari darah haid yang terlalu sedikit atau banyak, nyeri haid, hingga depresi menjelang menstruasi atau *premenstrual dysphoric disorder* dan berbagai penyebab lainnya yang bisa menyebabkan gangguan menstruasi.

Normal siklus menstruasi yang normal terjadi setiap 21–35 hari dengan lama menstruasi sekitar 4–7 hari. Namun terkadang, siklus menstruasi ini bisa terganggu dan menstruasi bisa berupa perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi tidak teratur, menstruasi terjadi lebih dari 7 hari, tidak menstruasi lebih dari 3 bulan, atau bahkan tidak pernah haid sama sekali.

Gangguan menstruasi sering menimbulkan dampak jangka panjang berupa gangguan dalam kehidupan suami istri, hambatan dalam pekerjaan maupun hubungan sosial, gangguan kesehatan secara umum dan infertilitas. Penyebab ketidakaturan haid antara lain ketidakseimbangan hormon, efek samping obat, tumor di ovarium, tumor di rahim dan polikistik ovarium sindrom (PCOS) serta ketidakseimbangan hormon dan PCOS berkaitan dengan stress dan gaya hidup yang tidak sehat. Obesitas, pola makan yang tidak sehat dan kurangnya olahraga menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan haid yang bersifat hormonal (Rahayu, 2017)



Gambar 4.1 Gambar Reproduksi pada Wanita

B. Jenis-jenis Gangguan Menstruasi pada Wanita

Pendeteksian dini gangguan menstruasi dan kesuburan pada wanita penting untuk menjaga kesehatan reproduksi. Beberapa gejala yang perlu diperhatikan termasuk nyeri saat haid, siklus haid tidak teratur, keputihan yang tidak normal, dan perdarahan di luar siklus haid. Pemeriksaan rutin seperti USG, histeroskopi, dan pap smear dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini.

1. Amenore

Kondisi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi. Terdapat dua jenis amenore, yaitu amenore primer (tidak pernah menstruasi pada usia 15 tahun atau lebih) dan amenore sekunder (tidak menstruasi selama 3 bulan atau lebih pada wanita yang sebelumnya memiliki siklus menstruasi). Penyebab amenore sangat beragam, mulai dari faktor alami seperti kehamilan dan menyusui, hingga masalah kesehatan yang lebih serius.

Amenore terjadi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi di luar kondisi dan masa-masa tersebut. Amenore bisa menjadi tanda dari suatu penyakit, mulai dari PCOS (*polycystic ovarian syndrome*) yang umum terjadi, hingga tumor kelenjar pituitary.

Penyebab amenore yang paling umum adalah gangguan hormonal. Hormon dibutuhkan untuk menghasilkan sel telur (ovulasi) yang kemudian akan memicu menstruasi. Oleh karena itu, ketidakseimbangan hormon dapat mengganggu siklus menstruasi, termasuk amenore, bisa di tandai dengan kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan kadar hormon dalam tubuh antara lain:

- a. Polycystic ovary syndrome (PCOS)
- b. Primary ovarian insufficiency (POI), yaitu kondisi ketika indung telur tidak bekerja sebelum usia 40 tahun
- c. Penyakit tiroid, seperti hipertiroidisme atau hipotiroidisme
- d. Tumor kelenjar pituitary
- e. Kelebihan hormon prolaktin hiperprolaktinemia)
- f. Tumor atau kanker ovarium
- g. Penggunaan obat-obatan tertentu, seperti antipsikotik, antidepresan, atau obat hipertensi

Gejala utama amenore adalah tidak terjadinya menstruasi. Pada kondisi normal, haid dimulai saat seorang wanita memasuki masa pubertas, yaitu antara 11–14 tahun, dan akan berhenti ketika masuk masa menopause.

Menstruasi sendiri terjadi dalam siklus atau berulang, idealnya setiap 21–35 hari. Biasanya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 2–7 hari, Amenore terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- Amenore primer, yaitu jika haid pertama (menarche) belum terjadi pada anak perempuan yang sudah berusia 15 tahun atau sudah mengalami tanda- tanda pubertas yang lain
- Amenore sekunder, yaitu jika haid tidak terjadi selama ≥ 3 siklus berturut-turut pada wanita yang sudah pernah haid dan tidak sedang hamil

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya amenore sebagai berikut:

- a. Berolahraga secara rutin, tetapi tidak berlebihan
- b. Mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang
- c. Menjaga berat badan agar tetap ideal
- d. Beristirahat yang cukup
- e. Selalu mencatat siklus menstruasi
- f. Menjalani pemeriksaan panggul atau pap–smear secara rutin
- g. Mengelola stres dengan baik

2. Oligomenorea

Oligomenorea berasal dari bahasa Yunani, "oligo" berarti sedikit, dan "menorrhea" berarti menstruasi. Secara harfiah, oligomenorea berarti menstruasi yang jarang terjadi. Dalam praktiknya, oligomenorea merujuk pada siklus menstruasi yang lebih panjang dari 35 hari. Normalnya, siklus menstruasi terjadi setiap 21-35 hari. Jika seorang wanita mengalami menstruasi kurang dari 6-8 kali dalam setahun, atau siklusnya lebih dari 35 hari secara konsisten, maka ia dapat dikatakan mengalami oligomenorea.

Penyebab Oligomenorea, Oligomenorea dapat disebabkan oleh kondisi atau masalah kesehatan tertentu, antara lain:

- a. Sindrom polikistik ovarium (PCOS)
- b. Kelebihan hormon tiroid (hipertiroidisme)
- c. Tumor jinak yang tumbuh di kelenjar pituitari (prolaktinoma)
- d. Radang panggul
- e. Perlengketan rahim (sindroma asherman)
- f. Gangguan makan, misalnya bulimia, anoreksia nervosa, dan *binge eating disorder*, hiperplasia adrenal.
- g. Kelainan genetik, misalnya gangguan fungsi indung telur (*primary ovarian syndrome*)

Gejala Oligomenorea, gejala utama oligomenorea adalah siklus menstruasi yang lebih jarang atau tidak teratur, dengan jeda lebih dari 35 hari, atau volume darah yang lebih sedikit dari biasanya (hipomenorea). Keluhan lain yang umum terjadi akibat oligomenorea meliputi:

1. Sakit kepala dan menstruasi tidak lebih 9 kali dalam 1 tahun
2. Masalah kulit, seperti jerawat yang muncul tiba-tiba
3. Sensasi panas (*hot flashes*)
4. Sakit perut
5. keputihan

Ada beberapa Langkah untuk memastikan atau mempertegas diagnose awal, seperti anjuran pemeriksaan penunjang yang biasa di lakukan, sebagai berikut:

- TES DARAH, untuk mengetahui kadar hormon, seperti thyroid stimulating hormone (TSH), follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), prolactin, human chorionic gonadotropin (HCG) dan 17-hydroxy-progesterone (17-OHP), serta memeriksa kadar gula darah

- TES URINE, untuk mendeteksi kehamilan, infeksi, atau penyakit menular seksual
- USG kandungan, untuk mendeteksi tanda-tanda peradangan dan PCOS
- USG tiroid, untuk mendeteksi pembesaran atau tumor pada kelenjar tiroid
- CT-SAN panggul, untuk melihat kondisi organ reproduksi lebih jelas

Pengobatan oligomenorea tergantung pada penyebab yang mendasarinya dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Jika oligomenorea disebabkan oleh pola hidup tidak sehat, dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani perbaikan pola hidup, seperti:

- 1) Berolahraga rutin
- 2) Menjaga berat badan ideal
- 3) Mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang
- 4) Mengelola stress
- 5) Beristirahat dan tidur dengan cukup
- 6) Berhenti merokok dan minum alcohol

3. Dismenore dan Menopause

Dismenore adalah nyeri saat menstruasi, sedangkan menopause adalah berhentinya menstruasi secara permanen pada wanita. Ahli mendefinisikan dismenore sebagai nyeri perut bagian bawah yang bisa menjalar ke paha dan punggung, dan menopause sebagai akhir dari siklus menstruasi karena ovarium berhenti memproduksi hormon reproduksi.

Menopause adalah akhir alami dari siklus menstruasi wanita, ditandai dengan tidak adanya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Menopause terjadi karena ovarium berhenti memproduksi hormon reproduksi, terutama estrogen, yang mengendalikan siklus menstruasi.

Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45–55 tahun. Seorang wanita bisa dikatakan sudah menopause bila tidak lagi mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut dan mengalami penurunan kekuatan masa otot tubuh.

Tabel 4.1 Perbedaan antara Dismenore dan Menopause

	Dismenore	Menopause
Definisi	Nyeri saat menstruasi	Berhentinya menstruasi secara permanen
Penyebab	Kram menstruasi alami (primer) atau gangguan organ reproduksi (sekunder)	Penurunan produksi hormon reproduksi (estrogen)
Durasi	Terbatas pada siklus menstruasi	Berlangsung seumur hidup setelah menopause
Tanda dan gejala	Nyeri perut bagian bawah, kram, bisa disertai sakit kepala, dll.	Gejala fisik dan psikologis akibat penurunan hormon, seperti <i>hot flashes</i> gangguan tidur, perubahan suasana hati, dll.

Gejala menopause dimulai ketika wanita memasuki masa perimenopause yang dialami oleh wanita dewasa dalam 12 bulan secara berturut-turut dan tidak ada menstruasi sama sekali sebelum menstruasi berhenti.

Biasanya durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul bisa berbeda-beda pada tiap wanita yang dipengaruhi gaya hidup sehari-hari, dapat dilihat gejala yang muncul sebagai berikut:

a. Perubahan siklus menstruasi

Wanita pada masa perimenopause akan mulai mengalami perubahan siklus menstruasi, seperti: Menstruasi menjadi tidak teratur, kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya disebut oligomenarhe serta darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak

b. Perubahan penampilan fisik

Perubahan penampilan fisik yang umum dialami wanita perimenopause adalah

- 1) Kulit kering serta rambut rontok
- 2) Payudara kendur
- 3) Sendi terasa nyeri dan kaku
- 4) Massa otot dan tulang berkurang
- 5) Berat badan bertambah

c. Perubahan psikologis

Perubahan psikologis yang terjadi pada wanita perimenopause dapat berupa:

- 1) Suasana hati berubah-ubah atau mood

- 2) Sulit berkonsentrasi
 - 3) Mudah lelah
 - 4) Sulit tidur atau insomonia
 - 5) Depresi dan cemas berlebihan
- d. Perubahan seksual
- Wanita perimenopause juga dapat mengalami perubahan seksual, seperti:
- 1) Vagina menjadi kering
 - 2) Penurunan libido atau gairah seksual



Gambar 4.2 Gejala Menopause

Biasanya wanita yang mengalami masalah tersebut akan diberikan pengganti hormon yang biasa digunakan adalah

- a. Terapi pengganti hormon estrogen, yaitu terapi yang diberikan pada wanita yang sudah menjalani operasi pengangkatan Rahim
- b. Terapi kombinasi (estrogen dan progesterone), yaitu terapi yang diberikan pada wanita yang mengalami menopause secara alami.

C. Deteksi Dini Gangguan Cemas dan Perubahan Suasana Hati

Deteksi dini gangguan kecemasan dan perubahan suasana hati penting untuk intervensi awal. Beberapa gejala yang perlu diperhatikan meliputi perubahan suasana hati yang drastis, ketakutan berlebihan, penarikan diri dari lingkungan sosial, gangguan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi, ada beberapa hal yang penting di perhatikan terkait deteksi dini gangguan kecemasan dan perubahan suasana hati:

1. Perubahan Suasana Hati yang Drastis

Perubahan suasana hati yang ekstrem, dari sangat sedih menjadi sangat bahagia, atau sebaliknya, bisa menjadi tanda gangguan mood seperti depresi atau bipolar. Perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai, dan mudah lelah juga merupakan gejala depresi.

2. Gangguan Kecemasan

Kecemasan berlebihan dan ketakutan yang tidak wajar terhadap situasi tertentu (fobia) bisa menjadi tanda gangguan kecemasan. Serangan panik yang ditandai dengan jantung berdebar, keringat dingin, dan sesak napas juga perlu diwaspadai.

3. Perubahan Perilaku

Penarikan diri dari lingkungan sosial, menghindari interaksi dengan orang lain, dan kesulitan bersosialisasi adalah tanda-tanda gangguan mental. Perubahan pola makan dan tidur, seperti insomnia atau makan berlebihan, juga bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan mental. Perilaku agresif, mudah marah, dan menyakiti diri sendiri juga perlu diperhatikan.

4. Kesulitan Berpikir dan Berkonsentrasi

Kesulitan berkonsentrasi, kehilangan fokus, dan mudah lupa bisa menjadi gejala gangguan mental dan pikiran yang kacau dan sulit mengambil keputusan juga perlu dipikirkan secara waspada yang disebabkan dari tidak konsentrasi dalam memutuskan sesuatu.

5. Mencari Bantuan Profesional

Jika Anda atau orang terdekat menunjukkan beberapa gejala di atas, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater.

Deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat membantu mencegah perburukan gangguan dan meningkatkan kualitas hidup serta upaya memperhatikan gejala-gejala ini bisa bervariasi pada setiap individu. Deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mengatasi gangguan kecemasan dan perubahan suasana hati.

Ada beberapa gejala gangguan kecemasan yang dapat kita dilihat sebagai berikut

1. Kekhawatiran yaitu rasa berlebihan. merasa cemas atau khawatir tentang berbagai hal secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.
2. Mudah Tersinggung yang terlihat ada rasa Lebih mudah marah atau jengkel dari biasanya.
3. Sulit Tidur: Mengalami kesulitan untuk tidur atau sering terbangun di malam hari.
4. Perubahan Suasana Hati, seperti sering mengalami perubahan suasana hati yang drastis, misalnya dari senang menjadi sedih atau marah dalam waktu singkat.
5. Menarik Diri, seperti menjauhi orang lain dan kegiatan sosial yang biasanya dinikmati.
6. Perubahan Pola Makan atau Tidur, seperti sering makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau mengalami perubahan pola tidur.
7. Gejala Fisik yang sering terlihat rasa gemetar, keringat dingin, sakit kepala, detak jantung cepat, sesak napas, dan lain-lain.

Jenis Gangguan Kesehatan Mental yang Umum di alami oleh Wanita yang sering mengalami gangguan kecemasan pada masa tersebut, seperti berikut:

1. Depresi: Perasaan sedih yang terus-menerus dan kehilangan minat.
2. Gangguan Kecemasan: Kecemasan dan ketakutan yang berlebihan.
3. Gangguan Bipolar: Perubahan suasana hati yang ekstrem antara mania dan depresi.
4. Skizofrenia: Gangguan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan jernih.
5. Gangguan Obsesif Kompulsif (OCD): Pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang berulang.
6. Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD): Kondisi yang berkembang setelah mengalami peristiwa traumatis.

Ada berbagai upaya dan pengobatan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat rasa cemas yang berlebihan dan cara penanganan gangguan kesehatan mental yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pengidap, yaitu:

1. Psikoterapi

Terapi psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit kesehatan mental.

Contohnya *cognitive behavioral therapy*, *exposure therapy*, *dialectical behavior therapy*, dan sebagainya.

2. Obat

Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit kesehatan jiwa umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia pada otak. Beberapa obat tersebut berupa golongan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI), Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRIs), dan anti-depresan trisiklik.

3. Perawatan intensif di rumah sakit

Bidan atau tenaga medis yang berkompeten akan melakukan berbagai terapi untuk mencegah upaya bunuh diri yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berada pada fase ini agar penderita gejala tersebut dapat Kembali melakukan aktifitas sehari-harinya dengan perasaan aman dan semangat.

4. *Supporting group*

Support group atau kelompok khusus yang beranggotakan memiliki pengidap penyakit kesehatan mental yang sejenis atau mereka yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan pada saat melakukan sesi kelompok mereka akan berkumpul sesuai waktu yang telah disepakati Bersama untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan yang lebih tepat, cepat, dan optimal.

5. Stimulasi pada otak

Berbagai cara untuk menstimulasi otak untuk menekan rasa gangguan kesehatan jiwa lainnya adalah stimulasi pada otak. Dan tujuan terapi ini berupa elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang bernama stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus.

6. Rehabilitasi

Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat atau rehabilitasi memiliki tujuan utama untuk membantu menangani pengidap gangguan kesehatan mental yang terjadi karena ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang.

7. Perawatan mandiri

Selain penanganan medis dengan bantuan psikolog atau psikiater, pengidap juga bisa melakukan perawatan mandiri dengan melibatkan anggota keluarga untuk mengatasi gangguan kesehatan mental yang akan mengakibatkan penderita berada pada zona nyaman yang salah.

D. Skrining Kesehatan Mental dan Edukasi *Coping Stress*

Skrining kesehatan mental dan edukasi coping stress menurut ahli adalah dua hal yang saling berkaitan. Skrining kesehatan mental membantu mengidentifikasi individu yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental, termasuk stres, dan edukasi coping stress memberikan strategi yang dapat digunakan individu untuk mengatasi stres tersebut. Ahli psikologi seperti Lazarus dan Folkman yang dikembangkan dengan teori dan model tentang coping stress yang dapat digunakan dalam edukasi ini.

Mengembangkan teori transaksional stres, yang menekankan bahwa stres adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, serta bagaimana individu menilai situasi tersebut. Mereka juga mengembangkan model coping stress yang membedakan antara *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping*. (Lazarus dan Folkman). Skrining Kesehatan Mental dilakukan untuk mengetahui proses mengidentifikasi individu yang mungkin memiliki masalah kesehatan mental, termasuk stres, depresi, kecemasan, dan lainnya. dengan tujuannya adalah untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental sehingga intervensi dapat diberikan dalam bentuk wawancara, atau observasi.

Penerapan dalam Skrining dan Edukasi, dilakukan untuk membantu menekan angka depresi atau bipolar meningkat, dengan upaya sebagai berikut:

1. Skrining kesehatan mental dapat membantu mengidentifikasi individu yang membutuhkan edukasi coping stress.
2. Edukasi coping stress dapat diberikan secara individual atau kelompok, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Contoh edukasi coping stress yang dapat diberikan adalah:
 - a. Mengidentifikasi sumber stres.
 - b. Memahami mekanisme coping yang efektif.
 - c. Mengembangkan strategi coping yang sehat.
 - d. Meningkatkan kesadaran diri tentang emosi dan perilaku.
 - e. Membangun dukungan sosial.
 - f. Menggunakan teknik relaksasi.
 - g. Meningkatkan aktivitas fisi

Menurut Lazarus (1976) berpendapat Stress terjadi jika seseorang mengalami tuntutan yang melampaui sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan penyesuaian diri, hal ini berarti bahwa kondisi stres terjadi jika terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan antara

tuntutan dan kemampuan. Tuntutan adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi individu.

Lazarus (1976) mengatakan bahwa *Coping Stress* memiliki kesamaan dengan *adjustment* (penyesuaian diri), hanya saja konsep mengenai *adjustment* lebih luas dan mengarah pada seluruh reaksi individu terhadap lingkungan dan tuntutan internal. *Coping Stress* merupakan suatu konsep yang lebih mengarah pada apa yang dilakukan individu untuk mengatasi situasi stres atau tuntutan yang membebani secara emosional

Strategi yang berpusat pada emosi tidak mengubah secara langsung makna situasi itu seperti halnya *cognitive reappraisal*. Pada beberapa situasi, makna dapat tetap sama walaupun beberapa aspek telah dihilangkan atau pemikiran mengenai situasi dihilangkan untuk sementara. Beberapa bentuk *emotional focus coping* yaitu:

1. *Seeking social support* merupakan strategi dimana individu berusaha mencari dukungan dari pihak-pihak diluar dirinya yang berupa dukungan emosional ataupun informasi.
2. *Distancing* merupakan strategi dimana individu berusaha melepaskan diri sejenak dan mengambil jarak dari masalah yang dihadapi.
3. *Avoidance*, strategi dimana individu berusaha menghindari atau melarikan diri dari permasalahannya dengan cara menyangkal.
4. *Positive appraisal*, strategi dimana individu akan berusaha untuk menciptakan makna positif yang lebih ditujukan untuk pengembangan pribadi untuk meningkatkan kreatifitas diri.
5. *Self control*, merupakan strategi dimana individu akan berusaha untuk meregulasi perasaan maupun tindakan yang akan diambil.
6. *Accepting responsibility*, strategi dimana individu sadar akan perannya dalam permasalahan yang dihadapinya dan mencoba memperjelas masalahnya secara objektif.

Pentingnya Skrining dan Edukasi *Coping Stress* dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya:

1. Kombinasi skrining dan edukasi *coping stress* sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, Skrining dan edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan cara menjaga kesejahteraan psikologis.
2. Mencegah masalah lebih serius
Dengan skrining, masalah kesehatan mental dapat terdeteksi sejak dini, sehingga dapat dicegah dari menjadi lebih parah.
3. Meningkatkan kemampuan mengatasi stres

Edukasi coping stress membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi stres, sehingga dapat mengurangi dampak negatif stres pada kesehatan mental dan fisik.

4. Meningkatkan kualitas hidup

Dengan kesehatan mental yang baik dan kemampuan mengatasi stres yang efektif, individu dapat menjalani hidup dengan lebih baik.

Ada beberapa tips untuk melatih *Coping Mechanism*, sebagai berikut

1. Belajar menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta orang lain.
2. Menanamkan pikiran yang positif, misalnya dengan melakukan positive self-talk.
3. Berusaha berpikir jernih dalam menghadapi berbagai masalah.
4. Belajar dari pengalaman, dengan menjadikan kesalahan atau kegagalan yang pernah dilakukan sebagai bahan evaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.
5. Menjalin hubungan yang baik dengan orang lain.
6. Mencari bantuan dari orang lain untuk memecahkan masalah tertentu.
7. Melakukan konseling dengan psikolog atau psikiater.
8. Berani dalam memutuskan hubungan dengan seseorang atau sesuatu yang dianggap toksik dan dapat memicu stres.

E. Penutup

Konseling pranikah termasuk persiapan penting sebelum menikah yang perlu diikuti seluruh calon pengantin. Konseling pranikah ialah pemberian bimbingan oleh seorang konselor sebagai bekal bagi pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan dimana harapannya dengan mengikuti konseling pranikah dapat membantu pasangan memiliki hubungan pranikah yang kuat, sehat dan sejahtera, yang dibahas dalam konseling pranikah ialah komunikasi, perencanaan keuangan, kesehatan reproduksi, hubungan keluarga, keintiman dan hubungan emosional, pemahaman dinamika keluarga dan tujuan serta harapan individu, pendidikan serta pengasuhan anak kurang lebih seperti itu.

Untuk pelayanan kesehatan pranikah bisa didapatkan di pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan tujuan memberi serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah tujuannya untuk mencegah penyakit menurun pada

keturunan, sehingga pasangan bisa hidup sehat bersama keluarga. Pemeriksaan yang mungkin dilakukan ialah pemeriksaan golongan darah dan rhesus, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan TORCH mungkin seperti itu kurang lebih untuk mengetahui pastinya anda bisa tanyakan kepada tempat anda akan melakukan konseling dan tempat untuk melakukan pemeriksaan.

Berbagai perubahan dalam hidup, baik positif maupun negatif, bisa menyebabkan stress misalnya kehilangan pekerjaan, putus cinta, memiliki anak, perceraian, atau kematian orang terdekat. Nah, semua perubahan ini menuntut seseorang untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi.

Sangat dibutuhkan mekanisme coping yang kuat untuk tetap produktif di usia lanjut, coping mechanism yang tepat, perubahan yang terlalu banyak dan dalam waktu singkat bisa memicu masalah mental, seperti gangguan kecemasan dan depresi atau bipolar yang jarang terdeteksi oleh keluarga atau orang yang terdekat, muncul masalah kesehatan fisik yang bahkan bisa menjadi lebih buruk akibat stres.

Referensi

- Better Up. (2023). *Coping mechanisms: Definition and how they function*. <https://www.betterup.com>
- Bracy, K. (2020). *How menopause is diagnosed*. Verywell Health. <https://www.verywellhealth.com>
- Bracy, K. (2021). *Symptoms of menopause*. Verywell Health. <https://www.verywellhealth.com>
- Chisholm, A. (2021). *An overview of menopause*. Verywell Health. <https://www.verywellhealth.com>
- Chisholm, A. (2021). *How menopause is treated*. Verywell Health. <https://www.verywellhealth.com>
- Cleveland Clinic. (2023). *Stress: Coping with life's stressors*. <https://my.clevelandclinic.org>
- Cleveland Clinic. (2024). *Mental health disorders*. <https://my.clevelandclinic.org>
- GoodTherapy.org. (2023). *Coping mechanisms*. <https://www.goodtherapy.org>
- Healthline. (2020). Huizen, J. *Everything you should know about menopause*. <https://www.healthline.com>
- Mayo Clinic. (2024). *Mental illness*. <https://www.mayoclinic.org>

- Mental Health Center.org. (2023). *12 healthy coping mechanisms: Unlocking inner strength*. <https://www.mentalhealthcenter.org>
- Mind UK. (2024). *Mental health problems – An introduction*. <https://www.mind.org.uk>
- Positive Psychology. (2023). *10 most common unhealthy coping mechanisms: A list*. <https://positivepsychology.com>
- Verywell Health. (2023). *Coping mechanisms: Everything you need to know*. <https://www.verywellhealth.com>

Glosarium

Amenore	Kondisi tidak terjadinya menstruasi pada wanita usia reproduktif. Terbagi menjadi amenore primer (belum pernah haid hingga usia ≥ 15 tahun) dan amenore sekunder (tidak haid ≥ 3 bulan pada wanita yang sebelumnya haid).
Anoreksia nervosa	Gangguan makan yang ditandai dengan pembatasan asupan makanan secara ekstrem untuk menurunkan berat badan.
Asherman Syndrome	Perlengketan pada dinding rahim yang dapat menyebabkan gangguan menstruasi atau infertilitas.
Coping Stress	Upaya individu untuk mengatasi tekanan psikologis melalui strategi pengendalian emosi dan pemecahan masalah.
CT-scan Panggul	Pemeriksaan pencitraan dengan sinar-X untuk melihat kondisi organ reproduksi wanita secara rinci.
Depresi	Gangguan suasana hati yang ditandai dengan kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat, dan penurunan energi.
Dismenore	Nyeri pada perut bagian bawah saat menstruasi. Dapat bersifat primer (alami) atau sekunder (karena kelainan organ).
Edukasi Coping Stress	Proses pembelajaran untuk membekali individu dengan keterampilan mengelola stres secara sehat.
Estrogen	Hormon utama wanita yang mengatur siklus menstruasi dan fungsi reproduksi.
FSH (Follicle Stimulating Hormone)	Hormon yang berperan dalam pematangan folikel di ovarium selama siklus menstruasi.
Hiperprolaktinemia	Peningkatan kadar hormon prolaktin secara abnormal yang dapat mengganggu siklus menstruasi dan kesuburan.
Histeroskopi	Prosedur pemeriksaan bagian dalam rahim menggunakan alat optik kecil melalui vagina.
Infertilitas	Ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh kehamilan setelah satu tahun hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi.
Insomnia	Gangguan tidur berupa kesulitan tidur atau sering terbangun di malam hari.
Menarche	Menstruasi pertama kali yang menandai awal masa reproduksi wanita.
Menopause	Berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium, umumnya pada usia 45–55 tahun.
Oligomenorea	Gangguan menstruasi dengan siklus lebih panjang dari 35 hari atau haid yang jarang (kurang dari 8 kali per tahun).
Ovulasi	Pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba falopi yang terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi.
Pap Smear	Tes untuk mendeteksi kelainan sel leher rahim (serviks) dan kanker serviks secara dini.
PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)	Gangguan hormonal yang menyebabkan siklus haid tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih, jerawat, dan kemandulan.

Perimenopause	Masa transisi menjelang menopause yang ditandai perubahan siklus haid, gangguan tidur, dan perubahan mood.
Pituitary Gland (Kelenjar Pituitari)	Kelenjar di otak yang mengatur produksi berbagai hormon termasuk hormon reproduksi.
PMS (Premenstrual Syndrome)	Gejala fisik dan emosional yang muncul menjelang menstruasi, seperti nyeri, mudah marah, dan perubahan mood.
Prolaktinoma	Tumor jinak pada kelenjar pituitari yang meningkatkan hormon prolaktin dan mengganggu siklus haid.
Psikoterapi	Terapi percakapan untuk membantu individu mengatasi stres, depresi, atau kecemasan.
Rehabilitasi	Proses pemulihan kondisi fisik dan mental, termasuk akibat penyalahgunaan zat.
Siklus Menstruasi	Rangkaian perubahan fisiologis bulanan pada wanita (21–35 hari) meliputi fase menstruasi, proliferasi, dan luteal.
Sindrom Ovarium Polikistik	Lihat PCOS — gangguan hormonal dengan banyak kista kecil pada ovarium.
Stres	Respons tubuh dan pikiran terhadap tekanan atau tuntutan yang melebihi kemampuan individu.
Terapi Pengganti Hormon (HRT)	Pemberian hormon estrogen atau kombinasi estrogen-progesteron untuk mengurangi gejala menopause.
USG (Ultrasonografi)	Pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk menilai kondisi rahim, ovarium, dan organ reproduksi lainnya.

BAB 5

Deteksi Dini Masalah Psikologis dan Kesehatan Mental

A. Mengenal Masalah Psikologis dan Kesehatan Mental Prakonsepsi

Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Kesehatan yang baik tidak hanya berarti tubuh yang bugar dan bebas penyakit, tetapi juga pikiran yang tenang, emosi yang stabil, dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mental yang terganggu dapat memengaruhi sistem imun, pola tidur, nafsu makan, serta kemampuan seseorang dalam menjaga keseimbangan hidup sehari-hari.

Kesehatan mental mencerminkan kondisi kesejahteraan seseorang secara utuh. Individu dengan mental yang sehat mampu mengenali potensi diri, mengelola stres, berpikir positif, dan berperan aktif dalam lingkungan sosialnya. Ia juga dapat bekerja dengan produktif dan menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental sering kali membuat seseorang kehilangan semangat, mudah cemas, atau menarik diri dari lingkungan sosialnya.

Dalam konteks kehidupan modern yang penuh tekanan, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting. Gaya hidup cepat, tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, serta perubahan teknologi dapat menjadi sumber stres yang memengaruhi keseimbangan psikologis. Oleh karena itu, memahami dan merawat kesehatan mental bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

B. Identifikasi Depresi

Depresi merupakan suatu bentuk gangguan mood yang ditandai oleh perasaan sedih yang menetap, hilangnya ketertarikan terhadap berbagai aktivitas, serta penurunan kemampuan dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari. Proses identifikasi kondisi ini dilakukan melalui pengamatan terhadap gejala-gejala fisik dan psikologis yang muncul secara konsisten selama minimal dua minggu.

1. Gejala Depresi

a. Perubahan suasana hati

Mengalami perasaan duka mendalam, kehampaan emosional, keputusasaan, atau kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya memberikan kesenangan.

b. Perubahan perilaku

Menjauhi interaksi sosial, kehilangan ketertarikan terhadap kegiatan yang sebelumnya diminati, mengalami gangguan pola tidur seperti insomnia atau tidur berlebihan, perubahan dalam kebiasaan makan berupa penurunan atau peningkatan nafsu makan, serta menghadapi hambatan dalam mempertahankan konsentrasi.

c. Perubahan fisik

Rasa lelah yang berlangsung secara terus-menerus, disertai keluhan seperti nyeri kepala, gangguan pada sistem pencernaan, atau fluktuasi berat badan yang mencolok.

d. Perubahan pikiran

Munculnya perasaan rendah diri, rasa bersalah yang berlebihan, keputusasaan mendalam, hingga timbulnya dorongan untuk menyakiti diri atau keinginan mengakhiri hidup. Gejala tambahan yang sering menyertai meliputi iritabilitas, kecemasan, kegelisahan, serta kesulitan dalam mengambil keputusan. Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian serius dan tidak boleh diabaikan. Gejala depresi bisa bervariasi pada setiap individu. Beberapa orang mungkin mengalami gejala fisik, sementara yang lain lebih dominan mengalami gejala psikologis. Apabila gejala-gejala tersebut menetap selama lebih dari dua minggu, sangat disarankan untuk segera mengakses layanan profesional. Tenaga medis atau ahli kesehatan mental memiliki kapasitas untuk melakukan evaluasi menyeluruh melalui pemeriksaan fisik, wawancara klinis, serta penggunaan instrumen skrining guna menegakkan diagnosis depresi secara akurat.

2. Diagnosis dan Penanganan Dini

Depresi yang tidak ditangani dapat menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan hubungan sosial, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Penanganan depresi dapat melibatkan terapi bicara (psikoterapi), obat-obatan (antidepresan), atau kombinasi keduanya.

C. Identifikasi Kecemasan

Kecemasan dapat diidentifikasi melalui berbagai gejala fisik, emosional, dan perilaku. Secara fisik, kecemasan bisa ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan detak jantung, ketegangan otot, sakit kepala, gangguan pencernaan, serta kesulitan tidur. Secara emosional, individu yang cemas mungkin mengalami ketakutan atau kekhawatiran berlebihan yang sulit dikendalikan, perubahan suasana hati, dan mudah tersinggung. Perilaku yang terkait dengan kecemasan meliputi menghindari situasi tertentu, perilaku melekat, dan perilaku terguncang.

1. Gejala Fisik Kecemasan

- a. Peningkatan tekanan darah dan detak jantung: Jantung berdebar kencang dan tekanan darah meningkat
- b. Ketegangan otot, otot terasa kaku, terutama di kepala dan leher.
- c. Sakit kepala atau pusing, sakit kepala ringan atau berat, bahkan vertigo.
- d. Gangguan pencernaan seperti mual, diare, atau sembelit.
- e. Berkeringat dingin, tangan berkeringat atau tubuh terasa dingin dan basah.
- f. Mulut kering, merasa mulut kering dan sulit menelan.
- g. Nyeri perut atau dada, yaitu nyeri pada perut atau dada yang tidak spesifik.
- h. Sesak napas, sulit bernapas atau napas pendek-pendek.
- i. Gemetar, tangan atau anggota tubuh lainnya bergetar.
- j. Rasa lelah, merasa lelah dan lemas secara berlebihan.
- k. Kesemutan, sensasi baal atau kesemutan pada anggota tubuh.

2. Gejala Emosional Kecemasan

Berikut merupakan tanda dan gejala kecemasan:

- a. Ketakutan atau kekhawatiran berlebihan: Merasa takut atau khawatir yang tidak wajar dan sulit dikendalikan.
- b. Perubahan suasana hati: Mudah marah, tersinggung, atau merasa cemas secara konstan.
- c. Sulit berkonsentrasi: Sulit fokus pada tugas atau pekerjaan.
- d. Perasaan tidak tenang: Sulit merasa rileks atau santai.
- e. Perasaan terancam: Merasa bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi.

3. Gejala Perilaku Kecemasan

- a. Perilaku menghindar, menghindari situasi atau tempat yang memicu kecemasan.
- b. Perilaku melekat sangat bergantung pada orang lain untuk merasa aman.
- c. Perilaku terguncang, merasa waspada berlebihan dan melihat ancaman di sekitarnya.

Setiap individu dapat mengalami manifestasi gejala kecemasan yang beragam. Apabila gejala tersebut mulai mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Meskipun kecemasan merupakan respons emosional yang wajar, intensitas yang berlebihan dan sulit dikendalikan dapat mengindikasikan adanya gangguan kecemasan yang memerlukan penanganan khusus.

D. Penyebab Stres Pranikah

Stress pranikah adalah suatu kondisi normal yang dialami oleh banyak pasangan yang akan menikah, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut, bisa memicu masalah yang lebih serius seperti depresi atau konflik dalam hubungan. Tekanan psikologis tersebut dapat timbul akibat berbagai pemicu, seperti kompleksitas dalam perencanaan pernikahan, kendala finansial, tuntutan atau harapan yang berlebihan, serta munculnya keraguan terhadap pasangan hidup.

1. Penyebab Stres Pranikah

- a. **Persiapan Pernikahan yang Rumit**
Mencari vendor, catering, fotografer, souvenir, gaun pengantin, dan lain-lain bisa sangat melelahkan.
- b. **Keterlibatan Keluarga yang Berlebihan**
Terkadang keluarga ikut campur terlalu dalam perencanaan, yang bisa memicu ketegangan.
- c. **Masalah Keuangan**
Biaya pernikahan yang besar dan melebihi anggaran bisa menjadi sumber stres.
- d. **Ekspektasi yang Tinggi**
Berharap pernikahan akan sempurna dan menjadi pusat perhatian bisa menimbulkan kekecewaan.
- e. **Keraguan pada Pasangan**
Ketidakpastian atau berkurangnya kepercayaan terhadap pasangan dapat berkontribusi sebagai salah satu faktor pemicu stres psikologis.
- f. **Kecemasan Menjelang Hari Pernikahan**
Kekhawatiran tentang segala sesuatunya berjalan lancar dan sempurna bisa membuat cemas.

2. Cara Mengatasi Stres Pranikah

- a. **Komunikasi**
Bicarakan perasaan dan kekhawatiran dengan pasangan. Komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk mengatasi masalah.
- b. **Koordinasi dengan Vendor:**
Perkuat komunikasi dengan wedding organizer atau vendor lain untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.
- c. **Prioritaskan Diri Sendiri**
Luangkan waktu untuk diri sendiri, misalnya dengan melakukan hobi atau relaksasi.
- d. **Meditasi atau Olahraga**

Latihan relaksasi seperti meditasi atau olahraga bisa membantu mengurangi stres.

- e. Cari Bantuan Profesional:
Jika stres terasa sangat berat, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor pernikahan.
- f. Rencanakan Pernikahan dengan Detail:
Susun rencana pernikahan dengan matang dan prioritaskan hal-hal yang penting.
- g. Hindari Perfeksionisme
Ingatlah bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna. Terima bahwa akan ada kesalahan dan belajar untuk mengatasinya bersama-sama.

Dengan mengenali penyebab stres pranikah dan menerapkan cara-cara mengatasinya, diharapkan para calon pengantin bisa melewati masa-masa ini dengan lebih tenang dan Bahagia

3. **Konseling dan edukasi pengelolaan stres prakonsepsi**
Layanan konseling dan pendidikan mengenai manajemen stres pada masa prakonsepsi bertujuan untuk menyediakan informasi serta dukungan psikologis bagi pasangan yang merencanakan kehamilan, khususnya dalam mengan-tisipasi dan menghadapi potensi stres yang dapat muncul selama proses tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kualitas hidup pasangan, serta mempersiapkan mereka untuk kehamilan yang sehat.

E. Konseling Prakonsepsi

1. **Definisi**
Konseling pada masa prakonsepsi merupakan suatu bentuk intervensi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta menyediakan dukungan kepada pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengiden-tifikasi dan mengelola faktor risiko yang mungkin memengaruhi kehamilan, serta meningkatkan peluang kehamilan yang sehat.
2. **Tujuan**
 - a. Meningkatkan kesehatan reproduksi pasangan.
 - b. Mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.
 - c. Mempersiapkan pasangan untuk kehamilan yang sehat.
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan tentang kehamilan.
3. **Manfaat**
 - a. Mengurangi stres dan kecemasan terkait kehamilan.
 - b. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental pasangan untuk kehamilan.
 - c. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman antara pasangan.
 - d. Meningkatkan peluang kehamilan yang sehat.
4. **Ruang Lingkup**
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan riwayat medis.
 - b. Pendidikan tentang gizi, gaya hidup sehat, dan manajemen stres.
 - c. Konseling tentang kesuburan dan perencanaan keluarga.
 - d. Skrining untuk penyakit menular seksual dan penyakit kronis.
5. **Edukasi Pengelolaan Stres**

Pentingnya pengelolaan stres. Ketidakmampuan dalam mengelola stres secara efektif dapat menimbulkan konsekuensi merugikan terhadap kesehatan reproduksi, yang meliputi gangguan pada siklus menstruasi, proses ovulasi, serta penurunan kualitas sperma.

6. Teknik Manajemen Stres

- a. Relaksasi: Meditasi, yoga, pernapasan dalam, dan terapi relaksasi lainnya.
- b. Aktivitas Fisik: Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kondisi emosional atau suasana hati.
- c. Pola Makan Sehat: Nutrisi yang baik dapat membantu tubuh mengatasi stres.
- d. Istirahat Cukup: Kecukupan waktu tidur berperan penting dalam menurunkan tingkat stres serta mendukung pemeliharaan kesehatan mental secara optimal.
- e. Dukungan Sosial: Berbicara dengan pasangan, keluarga, atau teman dapat membantu mengurangi stres.
- f. Konseling: Konseling profesional dapat membantu individu belajar mengidentifikasi dan mengatasi sumber stres.

7. Peran Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan, seperti bidan, dokter, dan konselor, dapat memberikan edukasi dan dukungan dalam pengelolaan stres prakonsepsi.

Konseling dan edukasi pengelolaan stres prakonsepsi merupakan investasi penting untuk kesehatan reproduksi dan kehamilan yang sehat. Penyediaan informasi yang akurat dan dukungan yang memadai memungkinkan pasangan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang dalam menjalani peran sebagai orang tua, sekaligus mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis.

F. Deteksi Dini Risiko Gangguan *Mood* dan Intervensi Awal

Identifikasi dini terhadap potensi gangguan suasana hati serta pelaksanaan intervensi secara cepat merupakan langkah krusial dalam mencegah konsekuensi negatif yang bersifat jangka panjang. Skrining kesehatan jiwa, yang dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi seperti SATUSEHAT Mobile, membantu mengidentifikasi individu

yang berisiko dan memungkinkan intervensi dini yang lebih cepat dan tepat.

1. Pentingnya Deteksi Dini

a. Mencegah perkembangan gangguan:

Deteksi dini dapat mencegah masalah kesehatan mental berkembang menjadi gangguan yang lebih serius atau menyebabkan dampak jangka panjang.

b. Intervensi lebih efektif

Semakin cepat masalah terdeteksi, semakin efektif pula penanganan yang diberikan oleh profesional kesehatan mental.

c. Meningkatkan kualitas hidup

Pelaksanaan intervensi pada tahap awal berperan penting dalam mendukung individu untuk mengelola kondisi yang dialaminya secara lebih efektif, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

2. Skrining

Skrining rutin sebaiknya dilakukan secara berkala, terutama bagi mereka yang berisiko, seperti individu dengan penyakit kronis atau riwayat keluarga dengan gangguan mental. Saat muncul gejala perubahan perilaku, perubahan suasana hati (mood), kesulitan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, segera lakukan skrining. Skrining kesehatan jiwa pada ibu hamil dan nifas sangat penting untuk mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin muncul.

3. Tenaga kesehatan yang dapat melakukan skrining

a. Dokter umum, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas atau fasilitas kesehatan primer dapat melakukan skrining dan memberikan intervensi awal.

b. Guru dan konselor sekolah

Guru bimbingan konseling dan wali kelas dapat berperan dalam deteksi dini dan memberikan intervensi awal bagi siswa.

c. Psikolog dan psikiater

Apabila dibutuhkan, individu yang mengalami permasalahan terkait kesehatan mental dapat diarahkan kepada tenaga profesional, seperti psikolog atau psikiater, guna memperoleh penanganan yang lebih komprehensif.

4. Intervensi awal yang dilakukan

a. Edukasi

Memberikan informasi tentang kesehatan mental dan cara mengelola masalah yang muncul.

b. Manajemen stres:

- Mengajarkan teknik pengelolaan stres untuk membantu individu mengatasi tekanan.
- c. **Konseling**
Menyediakan bantuan emosional sekaligus memfasilitasi individu dalam mengenali serta mengelola permasalahan yang mereka hadapi secara konstruktif.
- d. **Rujukan**
Merujuk individu ke fasilitas kesehatan yang lebih spesialis jika diperlukan.
- 5. **Dukungan keluarga dan masyarakat**
Peran serta keluarga dan komunitas memiliki signifikansi yang tinggi dalam mendukung proses pemulihan individu yang mengalami gangguan suasana hati. Kehadiran lingkungan yang responsif, suportif, dan penuh pemahaman dapat meningkatkan rasa aman serta kenyamanan individu dalam mengakses bantuan profesional. Melalui pelaksanaan deteksi dini dan intervensi awal yang tepat sasaran, permasalahan kesehatan mental dapat ditangani secara optimal, sehingga memungkinkan individu untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna.

Referensi

- Achadi. (2013). *Gizi dan kesehatan masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2005). Kesehatan dalam perspektif ilmu sosial-budaya. Dalam *Masalah kesehatan dalam kajian ilmu sosial-budaya*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Almatsier, S., Soetarjo, S., & Soekarti, M. (2011). *Gizi seimbang dalam daur kehidupan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Nutrition during pregnancy*. <https://www.acog.org/womenshealth/faqs/nutrition-during-pregnancy>
- Anggraini, D. D., et al. (2022). *Asuhan kebidanan pada pranikah*. Global Eksekutif Teknologi.
- Annisa, & Ike. (2010). Tradisi kepercayaan masyarakat pesisir mengenai kesehatan ibu di Desa Tanjung Limau Muara Badak Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 42–50.
- Arisman. (2009). *Gizi dalam daur kehidupan* (Edisi ke-2). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Bloom, M., Fischer, J., & Orme, J. G. (1999). *Evaluating practice: Guidelines for the accountable professional*. Allyn & Bacon.

- Fernandez-Hermida, Y., *et al.* (2022). Light microscopy and proteomic patterns of ovulation in cervical mucus. *Life*, 12(11), 1–15. <https://doi.org/10.3390/life12111815>
- Fitriana, D. (2021). *Panduan persiapan lingkungan rumah untuk ibu hamil*. Jakarta: Penerbit Buku Kita.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Panduan pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021a). *Buku saku merencanakan kehamilan sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kurniawan, A. (2020). *Merancang lingkungan yang sehat untuk ibu dan bayi*. Surabaya: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nugroho, T., & Bobby, I. U. (2014). *Masalah kesehatan reproduksi wanita*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nuraini. (2011). *Fertilitas penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Nurhayati, N. (2017). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infertilitas. [Data tidak lengkap].
- Wulandari, P., Fihastutik, P., & Arifianto, A. (2019). Pengalaman psikologis kehamilan pranikah pada usia remaja di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen. *Journal of Holistic Nursing Science*, 6(2), 64–73. <https://doi.org/10.31603/nursing.v6i2.2649>
- Yulivantina, E. V., Suryantara, D. B., *et al.* (2020). *Asuhan pranikah dan prakonsepsi*. Yogyakarta: Program Studi Kebidanan Pendidikan Profesi Bidan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.

Glosarium

Adaptasi psikologis	Kemampuan menyesuaikan pikiran dan emosi terhadap tuntutan atau perubahan kehidupan.
Anhedonia	Kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan.
Antidepresan	Obat untuk mengurangi gejala depresi, digunakan sesuai evaluasi tenaga kesehatan.
Ansietas (Kecemasan)	Rasa khawatir atau takut berlebihan yang mengganggu fungsi sehari-hari.
Depresi	Gangguan suasana hati dengan sedih menetap, kehilangan minat, dan penurunan fungsi minimal 2 minggu.

Deteksi dini	Upaya mengenali gejala awal masalah psikologis agar intervensi bisa segera dilakukan.
Diagnosis klinis	Penetapan kondisi oleh profesional melalui wawancara, pemeriksaan, dan alat skrining.
Dukungan sosial	Bantuan emosional, informasi, atau praktis dari pasangan, keluarga, dan teman.
Edukasi kesehatan mental	Pemberian informasi untuk memahami, mencegah, dan mengelola masalah psikologis.
Emosi (regulasi emosi)	Proses mengenali, menerima, dan mengelola emosi agar respons tetap adaptif.
Gangguan mood	Kelompok gangguan dengan perubahan suasana hati yang bermakna, seperti depresi.
Gejala emosional kecemasan	Ketakutan berlebihan, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, merasa tidak tenang.
Gejala fisik kecemasan	Jantung berdebar, tegang otot, sakit kepala, gangguan pencernaan, keringat dingin, gemetar.
Gejala perilaku kecemasan	Menghindari situasi pemicu, sangat bergantung pada orang lain, waspada berlebihan.
Guru BK	Pendidik bimbingan konseling yang dapat melakukan deteksi dini dan intervensi awal di sekolah.
Insomnia	Kesulitan memulai atau mempertahankan tidur yang berdampak pada fungsi siang hari.
Intervensi awal	Tindakan cepat seperti edukasi, manajemen stres, konseling, atau rujukan.
Istirahat cukup	Durasi dan kualitas tidur yang memadai untuk pemulihan fisik dan mental.
Kecemasan	Lihat ansietas. Respons kewaspadaan yang menjadi masalah bila berlebihan atau sulit dikendalikan.
Kesehatan mental	Kondisi kesejahteraan yang memungkinkan individu produktif, berelasi baik, dan mengatasi stres.
Kesejahteraan psikologis	Keadaan nyaman secara emosional, berfungsi sosial baik, dan merasa hidup bermakna.
Konseling pernikahan	Layanan profesional untuk pasangan terkait komunikasi, konflik, dan kesiapan menikah.
Konseling prakonsepsi	Edukasi dan dukungan sebelum kehamilan untuk mengelola faktor risiko, termasuk stres.
Kualitas hidup	Persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan terkait kesehatan, tujuan, dan konteks sosial.
Meditasi	Latihan perhatian terarah untuk menenangkan pikiran dan menurunkan stres.
Nafsu makan (perubahan)	Peningkatan atau penurunan selera makan, sering menyertai depresi atau kecemasan.
Perfeksionisme	Standar sangat tinggi yang kaku sehingga memicu stres pranikah dan kekecewaan.
Psikiater	Dokter spesialis kesehatan jiwa yang dapat mendiagnosis dan memberikan terapi, termasuk obat.
Psikolog	Tenaga profesional yang memberikan asesmen dan psikoterapi tanpa pemberian obat.

Psikoterapi (terapi bicara)	Pendekatan berbasis percakapan untuk mengubah pikiran, emosi, dan perilaku yang bermasalah.
Puskesmas	Fasilitas layanan primer tempat skrining dan intervensi awal kesehatan mental dapat dilakukan.
Relaksasi pernapasan	Teknik napas dalam dan terstruktur untuk menurunkan aktivasi fisiologis saat cemas.
Resiliensi psikologis	Ketahanan untuk bangkit kembali setelah tekanan atau kesulitan.
Rujukan	Mengarahkan klien ke layanan yang lebih spesialis seperti psikolog atau psikiater.
SATUSEHAT Mobile	Aplikasi yang dapat digunakan untuk skrining kesehatan jiwa secara mandiri.
Skrining kesehatan mental	Penapisan gejala dengan kuesioner atau aplikasi untuk menentukan perlu tidaknya evaluasi lanjutan.
Stres	Respons fisik dan psikologis terhadap tuntutan yang dirasa melebihi sumber daya diri.
Stres pranikah	Tekanan emosional terkait persiapan, ekspektasi, dan keputusan menjelang pernikahan.
Suicidal ideation (ide bunuh diri)	Pikiran untuk mengakhiri hidup. Kondisi darurat yang memerlukan bantuan profesional segera.
Teknik manajemen stres	Strategi seperti relaksasi, aktivitas fisik, pola makan sehat, tidur cukup, dan dukungan sosial.
Terapi bicara	Lihat psikoterapi.
Vendor pernikahan	Penyedia jasa pernikahan yang perlu dikelola agar persiapan tidak menambah stres.
Wali kelas	Pendidik yang dapat mengamati perubahan perilaku siswa dan merujuk bila perlu.
Wedding organizer (WO)	Pihak yang membantu koordinasi acara, dapat mengurangi beban teknis yang memicu stres.
Wawancara klinis	Percakapan terstruktur antara profesional dan klien untuk mengevaluasi gejala dan konteks.
Yoga	Latihan tubuh dan napas yang membantu fleksibilitas, relaksasi, dan pengelolaan stres.

BAB 6

Deteksi Dini Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Kehamilan

A. Pernikahan Dini dan Kesehatan Ibu

Pernikahan dini, atau yang sering disebut juga pernikahan anak, merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai usia dewasa secara fisik maupun mental. Umumnya, pernikahan dini terjadi pada perempuan berusia di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah 25 tahun. Menurut pedoman Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal untuk menikah adalah antara 20 hingga 35 tahun bagi perempuan dan 25 hingga 40 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap sebagai masa paling matang dari segi biologis, psikologis, dan sosial untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sayangnya, praktik pernikahan dini masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan serta kesejahteraan rendah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah pernikahan dini mencapai 1.220.900 kasus, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi besar terhadap kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan.

Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, perempuan yang menikah dan hamil pada usia terlalu muda cenderung belum memiliki organ reproduksi yang berkembang sempurna. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklampsia, kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, hingga kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga sering kali menghambat akses pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi

perempuan, yang pada akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan dan ketimpangan gender di masyarakat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor individu, yang meliputi: perkembangan fisik, mental, dan sosial. Semakin cepat perkembangan seseorang, semakin besar kecenderungan pernikahan dini; tingkat pendidikan remaja semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah kecenderungan pernikahan dini; sikap dan hubungan dengan orang tua, semakin patuh orang tua yang menginginkan anak-anaknya menikah cepat
2. Faktor lingkungan di lokasi remaja, jika masyarakat di suatu daerah memiliki tradisi pernikahan dini, remaja tersebut akan mengikuti tradisi tersebut dengan menikah di usia dini
3. Faktor tradisi keluarga, orang tua berperan penting dalam menentukan pernikahan anak-anaknya, meliputi: status sosial ekonomi, karena beban yang dialami keluarga, mereka ingin menikahkan anak perempuan mereka di usia dini. Jika anak perempuan menikah dini, ia akan diuntungkan, artinya tanggung jawabnya sebagai seorang ibu menjadi tanggung jawab suaminya atau keluarga suami anak perempuan tersebut, dan akan ada lebih banyak pekerjaan dalam keluarga, artinya kerabat dengan sukarela membantu keluarga istri. Tingkat pendidikan keluarga, artinya semakin rendah tingkat pendidikan, semakin umum terjadi pernikahan dini.
4. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat istiadat keluarga sangat menentukan terjadinya pernikahan dini, dan anak-anak dipaksa untuk menuruti keinginan orang tua mereka. Orang tua menikahkan anak-anak mereka untuk meningkatkan status sosial keluarga, memperkuat hubungan keluarga, dan/atau mempertahankan garis keluarga.
5. Kecelakaan (Pernikahan yang tidak disengaja). Faktor-faktor yang menimbulkan masalah bagi anak-anak, artinya jika seorang anak perempuan berzina, solusinya adalah dia menikah untuk menghadapi rasa malu dan bersalah. Kehamilan di luar nikah dapat terjadi ketika anak-anak berada dalam hubungan yang tidak normatif dan dipaksa menikah dini untuk memperjelas status mereka. Akibatnya, pernikahan dini ini memaksa mereka untuk memainkan peran sebagai suami dan istri, serta ibu dan ayah. Hal

ini dapat mengakibatkan penuaan dini, karena keadaan mereka yang menikah muda.

C. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehamilan

Dampak Pada Ibu

1. Anemia

Dampak anemia pada kehamilan berkisar dari gejala ringan hingga komplikasi kehamilan seperti keguguran, persalinan lama, perdarahan, gangguan pascapersalinan, melemahnya sistem kekebalan tubuh, gangguan produksi ASI, dan gangguan janin seperti keguguran, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kematian perinatal. Anemia pada kehamilan dapat didefinisikan sebagai defisiensi zat besi dalam darah ibu hamil, suatu kondisi yang ditandai dengan adanya sel darah merah atau kadar hemoglobin yang rendah, atau dengan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen oleh organ ibu dan janin. Angka kematian ibu yang tinggi berkaitan erat dengan anemia, baik selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Pada ibu hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Risiko kematian ibu, prematuritas, berat badan lahir rendah, dan kematian perinatal meningkat. Kelahiran prematur pada ibu dengan anemia defisiensi besi dikaitkan dengan masalah baru, seperti berat badan lahir rendah, gangguan respons imun, dan kecenderungan untuk mengalami masalah psikologis dan pertumbuhan. Di Indonesia, insidensi ibu hamil dengan anemia dan malnutrisi energi protein masih tinggi. Frekuensi ibu hamil dengan anemia adalah 63,5%.

2. Keguguran

Penyebab utama keguguran di Indonesia adalah usia ibu saat hamil. Salah satu faktor yang terkait dengan keguguran adalah pernikahan dini. Keguguran merupakan masalah kesehatan yang dapat memengaruhi morbiditas dan mortalitas ibu. Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, komplikasi dari aborsi. Keguguran, suatu bentuk perdarahan pada awal kehamilan, merupakan penyebab kematian neonatal dan maternal. Angka keguguran dapat meningkat sebesar 12% pada wanita di bawah usia 20 tahun dan 26% pada wanita di atas usia 40 tahun. Keguguran yang terjadi pada usia dini disebabkan oleh kondisi organ reproduksi ibu, seperti otot rahim yang belum berkembang, kekuatan dan kontraksinya, serta sistem hormonal yang tidak terkoordinasi. Selain itu, kondisi psikologis ibu dianggap

menakutkan, merasa tidak siap untuk kehamilan dan merasa tertekan karena kehamilan yang tidak diinginkan.

3. Perdarahan Postpartum

Perdarahan pascapersalinan, atau perdarahan pascapersalinan, adalah kehilangan darah melalui jalan lahir segera setelah melahirkan. Perdarahan pascapersalinan didefinisikan sebagai kehilangan lebih dari 500 ml setelah persalinan pervaginam dan lebih dari 1.000 ml setelah persalinan perabdominal, sebelum 6 minggu setelah melahirkan. Perdarahan pascapersalinan tetap menjadi penyebab utama kematian ibu, mencakup 25 hingga 30% dari seluruh kematian ibu di negara berkembang. Sebagian besar kematian ibu akibat perdarahan pascapersalinan terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan akibat kehilangan darah yang berlebihan. Perdarahan pascapersalinan didefinisikan sebagai kehilangan lebih dari 500 ml setelah persalinan pervaginam dan lebih dari 1.000 ml setelah persalinan perabdominal, sebelum 6 minggu setelah melahirkan. Perdarahan pascapersalinan tetap menjadi penyebab utama kematian ibu, mencakup 25 hingga 30% dari seluruh kematian ibu di negara berkembang. Sebagian besar kematian ibu akibat perdarahan postpartum terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan akibat kehilangan darah yang berlebihan. Perdarahan postpartum juga disebabkan oleh beberapa faktor risiko, antara lain usia, paritas, jarak kelahiran, riwayat kehamilan sebelumnya, lama persalinan, pelepasan plasenta yang tertunda, anemia, pengetahuan ibu, perilaku ibu, kunjungan antenatal, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Jika ibu berusia di bawah 20 tahun, sistem reproduksinya belum sepenuhnya berkembang, sehingga tidak siap untuk hamil dan melahirkan. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan antepartum atau postpartum.

4. Preeklamsia

Ibu di bawah usia 20 tahun dianggap terlalu muda, dengan rahim yang kurang matang untuk melahirkan, sehingga rentan terhadap preeklamsia. Sementara itu, ibu di atas usia 35 tahun dianggap terlalu tua untuk melahirkan, terutama primipara (ibu yang lebih tua), dan berisiko tinggi mengalami preeklamsia. Banyak kondisi medis yang berkontribusi terhadap kelahiran pada usia berisiko tinggi. Namun, insiden kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan pada masa reproduksi sehat, yaitu antara usia 20 dan 30 tahun. Hal ini disebabkan oleh belum matangnya organ reproduksi untuk kehamilan. Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi 160/110 mmHg atau lebih, disertai

proteinuria dan/atau edema, yang terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan. Rahim perempuan di bawah usia 20 tahun tidak mendukung kehamilan dan persalinan yang sehat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Perempuan di bawah usia 20 tahun lebih rentan terhadap preeklamsia dan eklamsia. Mereka juga lebih mungkin melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau malnutrisi.

Dampak Pada Bayi

1. BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, 14,61% remaja Indonesia di bawah usia 20 tahun melahirkan bayi BBLR. Angka ini lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan di atas usia 20 tahun yang melahirkan bayi BBLR (12,43%). SUSENAS 2019 menunjukkan bahwa 14,93% remaja di bawah usia 20 tahun melahirkan bayi BBLR. Lebih lanjut, berdasarkan hasil SUSENAS 2020, persentase remaja di bawah usia 20 tahun yang melahirkan bayi BBLR meningkat menjadi 15,74%. Perempuan yang melahirkan pertama kali sebelum usia 20 tahun erat kaitannya dengan pernikahan remaja. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita, seseorang masih dapat menikah di bawah usia 19 tahun dengan mengajukan sidang batas usia pernikahan atau pengabaian batas usia pernikahan ke pengadilan. Meskipun pengabaian usia perkawinan atau pengabaian usia perkawinan adalah sah, hal itu dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi, salah satunya adalah risiko BBLR. BBLR adalah suatu kondisi di mana bayi memiliki berat lahir kurang dari 2.500 gram.

Penyebab BBLR adalah karena beberapa faktor, termasuk demografi ibu, yaitu ras, tingkat pendidikan, kebiasaan merokok ibu, konsumsi alkohol, status pekerjaan (bekerja atau tidak bekerja), pengetahuan ibu tentang kehamilan, status ekonomi, dan kondisi stres selama kehamilan. Faktor-faktor ibu yang berhubungan dengan kejadian BBLR adalah usia ibu saat hamil (35 tahun), paritas atau jumlah anak yang dilahirkan (ibu dengan paritas >4 kali risiko melahirkan BBLR), dan jarak kehamilan. Selain risiko kematian, bayi BBLR juga berisiko terhadap penyakit seperti asfiksia, hipotermia, infeksi, penyakit kuning, gangguan menyusui, dan dwarfisme. Masalah kesehatan yang muncul di masa dewasa, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan tingginya angka kematian

bayi pada ibu yang melahirkan di usia muda, kemungkinan besar berkaitan dengan faktor biologis yang menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Jarak kelahiran yang panjang (di atas 4 tahun) memiliki risiko kematian yang lebih rendah (21 per 1.000) dibandingkan dengan jarak kelahiran yang pendek (2 tahun), yaitu 68 per 1.000 kelahiran. Berat lahir bayi merupakan faktor krusial dalam kelangsungan hidupnya. Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang lahir dengan berat badan lahir sangat rendah memiliki risiko kematian lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan lahir rata-rata atau tinggi.

2. Prematuritas

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan bayi, terutama kelahiran prematur, yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau sebelum hari perkiraan lahir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim menyebabkan serviks terbuka, sehingga memungkinkan janin memasuki jalan lahir. Data menunjukkan bahwa jumlah anak yang lahir melebihi jumlah anak yang sebenarnya lahir. Jumlah kematian tersebut adalah empat pada bayi baru lahir, dua pada anak di bawah usia 24 bulan, tiga pada balita, dan satu pada anak berusia sembilan tahun. Salah satu faktor risiko yang berkontribusi terhadap kematian neonatal adalah kondisi ibu sebelum pembuahan dan selama kehamilan. Salah satu faktornya adalah usia ibu saat kehamilan pertama. Sebagian besar perempuan Baduy menikah antara usia 14 dan 16 tahun. Ibu-ibu muda ini, yang dianggap remaja, sedang memasuki kehamilan pertama mereka. Pada usia ini, rahim dan panggul ibu belum sepenuhnya berkembang, sehingga mereka perlu mewaspadaai kemungkinan kelahiran yang sulit, kelahiran prematur, atau komplikasi lain karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu.

Dampak Psikologis

Dampak Psikologis Pernikahan Dini yaitu keharmonisan keluarga tercipta ketika semua anggota merasa bahagia, damai, saling mencintai, dan berkomunikasi dengan baik. Konflik jarang terjadi, atau jika terjadi, keluarga berhasil menyelesaikannya secara efektif. Namun, tidak semua pasangan mencapai keharmonisan ini. Salah satu alasan utamanya adalah usia pernikahan yang masih muda. Teori menunjukkan bahwa pernikahan dini cenderung membawa masalah yang tidak

diinginkan karena ketidakdewasaan psikologis. Pasangan yang menikah terlalu muda seringkali berakhir dengan rumah tangga yang berantakan. Pernikahan dini dapat menjadi faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga. Pasangan yang menikah muda seringkali belum matang secara sosial dan ekonomi. Mereka seringkali tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kesulitan keuangan dapat memicu konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan psikologis mereka.

Dampak psikologis pernikahan dini dapat mencakup kecemasan, stres, depresi, dan bahkan perceraian. Pasangan remaja seringkali tidak sepenuhnya memahami ikatan suci pernikahan dan seringkali menikah hanya karena cinta atau tekanan dari orang tua perempuan muda, yang ingin menghindari stigma dicap "perawan tua". Setelah pasangan muda ini menikah, hamil, dan memiliki anak, peran baru sebagai orang tua, terutama bagi ibu, dapat membatasi kebebasan sosial mereka dan membebankan tanggung jawab yang mengurangi kesempatan bersosialisasi dan bersantai dengan teman. Karena harus menangani segudang tanggung jawab dan pekerjaan rumah tangga, belum lagi beban lain yang menyita waktu, beberapa pasangan muda merasa putus asa dan mulai menyalahkan pernikahan dini mereka atas kesulitan yang mereka hadapi. Situasi ini seringkali memicu pertengkaran dalam keluarga, dan terkadang suami mengancam akan menceraikan istrinya. Ketika ancaman ini dilakukan, istri menjadi semakin khawatir, cemas, dan depresi, yang pada akhirnya membuatnya sangat tertekan.

Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat penting untuk mencegah pasangan muda, yang belum sepenuhnya matang secara fisik dan emosional, merasa diabaikan. Ketidakstabilan emosi dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pernikahan. Mereka membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang tua dan anggota keluarga dekat untuk membantu mereka beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan keluarga. Dengan bimbingan yang tepat, keluarga muda yang mereka bangun dapat bertahan lama, bahkan hingga generasi kakek-nenek. Dukungan ini juga membantu mereka menghindari perceraian, yang dapat terjadi akibat keputusan impulsif yang dipicu oleh emosi remaja.

Dampak Psikososial

Kehamilan remaja tidak hanya berdampak pada masalah psikologis, tetapi juga masalah sosial yang muncul, termasuk gangguan sosialisasi dan isolasi sosial. Hal ini disebabkan oleh masalah yang dihadapi remaja di rumah yang diperparah oleh interaksi antara tuntutan lingkungan sosial dan kewajiban mengasuh anak. Pada masa remaja, kebutuhan sosialisasi masih tinggi, sehingga pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dapat terasa seperti beban di dunia remaja. Oleh karena itu, masalah psikososial yang dihadapi remaja membutuhkan dukungan dari keluarga, orang tua, dan tenaga kesehatan untuk memberikan pengetahuan tentang kehamilan remaja dan peran sebagai ibu. Gangguan psikososial juga terjadi akibat kurangnya dukungan dan pengetahuan keluarga tentang kehamilan remaja. Dalam hal ini, remaja juga membutuhkan dukungan dan pendidikan orang tua yang memadai dari orang-orang terdekat yaitu orang tua yang dapat memahami dan mengerti kondisi anak perempuannya.

D. Upaya Mengatasi Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga merupakan penyebab stunting, karena seringkali diikuti oleh kehamilan yang tidak direncanakan, yang dapat mengganggu pertumbuhan janin. Program "GenRe Action" bertujuan untuk mempromosikan dan mencegah pernikahan dini, dengan harapan dapat membantu remaja, masyarakat, dan pemerintah membesarkan remaja yang sehat dan terdidik dengan baik serta mencapai "remaja tangguh". "Remaja tangguh" mengacu pada remaja yang menerapkan perilaku sehat, menghindari risiko Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (ARR), menunda pernikahan, dan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berbagai kegiatan dalam program ini mencakup inisiatif untuk menyediakan pendidikan pernikahan dini, penjangkauan kesehatan reproduksi, dan program dukungan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan membantu remaja membuat keputusan yang tepat tentang pernikahan. Program-program tersebut meliputi:

1. GenRe Mengajar

Program ini melibatkan penjangkauan dan edukasi di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan program GenRe dan memberikan wawasan tentang pernikahan dini dan isu-isu kesehatan reproduksi remaja. Melalui GenRe Mengajar, remaja diharapkan dapat lebih memahami isu-isu kesehatan reproduksi dan menghindari risiko pernikahan dini. Tujuan program ini adalah membantu remaja mempersiapkan kehidupan keluarga ideal—keluarga kecil, bahagia,

dan sejahtera. Program ini juga bertujuan untuk memberikan informasi, sikap, dan keterampilan yang mendukung gaya hidup sehat, serta menanamkan kebiasaan sehat untuk meningkatkan kesehatan generasi muda.

2. GenRe Embracing

Program ini meliputi sesi berbagi dan konseling, serta pembinaan dan bimbingan bagi remaja mengenai bakat dan minat mereka. Sesi berbagi dan konseling ini dipandu secara langsung oleh para pendidik dan kelompok sebaya, yang membantu remaja mengatasi masalah terkait pernikahan dini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membimbing dan membimbing remaja dalam mengembangkan bakat dan minat mereka serta mempromosikan program GenRe di kalangan remaja lainnya.

3. GenRe Media

Program ini meliputi promosi kegiatan dan informasi GenRe terkait pernikahan dini, kesehatan reproduksi, serta kesehatan ibu dan anak melalui platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lainnya. Program ini bertujuan untuk membantu remaja tidak hanya mempelajari GenRe tetapi juga menjadi TEGAR Remaja, yang dapat menemukan, mengenali, dan mengembangkan potensi mereka untuk menjadi remaja Indonesia yang mandiri, berprinsip, memiliki etos kerja yang kuat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Lebih lanjut, program ini bertujuan untuk menyediakan layanan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan keterampilan hidup bagi remaja. Program ini juga mendorong pengembangan kegiatan lain yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan remaja. Dengan Aksi GenRe sebagai upaya promosi dan pencegahan terhadap risiko Triad Kesehatan Reproduksi Remaja, diharapkan remaja dapat memahami dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menerapkan perilaku sehat, dan mengembangkan nilai-nilai moral yang baik.

E. Strategi Pencegahan Pernikahan Dini

1. *Peer Support*

Konselor kelompok menciptakan jaringan dukungan bagi keluarga rentan, mereka yang menganut dan berpartisipasi dalam budaya pernikahan paksa, agar anggota masyarakat dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan saling belajar tentang dampak pernikahan dini. Jaringan ini terdiri dari anak-anak yang orang

tuanya menganut budaya pernikahan paksa, pasangan yang telah menikah dini, pasangan yang belum menikah dini, dan remaja lainnya. Dalam jaringan ini, konselor menawarkan layanan konseling kelompok untuk menciptakan dinamika yang dapat membantu mengatasi masalah pernikahan dini. Masalah pernikahan dini dibahas secara menyeluruh, dengan setiap peserta mengungkapkan pendapat dan pengalaman mereka. Hal ini memungkinkan anak-anak yang berisiko menikah dini dan orang tua mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kehidupan mereka yang menikah dini dan mereka yang menikah pada usia yang tepat. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan dini dan membuat keputusan yang tepat tentang kehidupan mereka sendiri. Orang tua yang memaksa anak-anak mereka untuk menikah dini harus mempertimbangkan dengan saksama dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap anak-anak mereka.

2. Psikoedukasi

Konselor dapat menerapkan psikoedukasi melalui berbagai layanan konseling untuk meningkatkan pemahaman tentang pernikahan dini di masyarakat. Perilaku positif yang terstruktur dapat dicapai melalui layanan konseling yang tepat dan profesional untuk mengatasi masalah pernikahan dini, yaitu dengan mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan dini menjadi persepsi yang menolaknya, dengan justifikasi yang logis dan rasional.

3. Materi Ajar untuk Layanan Konseling Khusus

Mengembangkan materi ajar tambahan atau materi khusus untuk layanan konseling kelas tentang dampak negatif pernikahan dini, yang diberikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, dengan konten yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan anak, serta usia mereka. Semakin dini materi ini diberikan, semakin besar kemungkinan anak akan menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang positif dan kemudian menolaknya.

4. Melakukan Kampanye Dampak Pernikahan Dini

Menyebarkan informasi tentang dampak pernikahan dini melalui berbagai media, seperti kampanye langsung, poster, leaflet, spanduk, video, dan lainnya. Konten ini mencakup informasi terkait dampak fisik dan psikologis pernikahan anak, menekankan pentingnya pendidikan, hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan topik terkait lainnya. Bersamaan dengan kampanye ini, undang-

undang tentang pernikahan anak, sanksi dalam kasus pemerkosaan, dan penjelasan tentang skenario terburuk yang dapat timbul dari pernikahan anak juga disebarluaskan di masyarakat. Mengintensifkan intervensi untuk melindungi anak perempuan berusia 15 hingga 17 tahun, dengan fokus utama pada penyelesaian pendidikan menengah.

5. Memberdayakan anak dengan menyediakan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Program pelatihan ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan anak, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jaringan pendukung yang kuat. Pelatihan keterampilan hidup di bidang kesehatan, gizi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan keterampilan lainnya juga disediakan. Tujuannya agar anak memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri dan mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, serta menghindari dampak pernikahan dini.
6. Membimbing, mendidik, dan memobilisasi orang tua, anggota masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk memahami dampak pernikahan dini, karena mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk mencegahnya. Membimbing anak-anak untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal. Anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial di sekolah, sehingga mengubah norma-norma terkait pernikahan dini dan mencegahnya. Oleh karena itu, penting untuk membantu mereka mempersiapkan, melatih, dan mendukung anak perempuan untuk bersekolah. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan untuk anak perempuan berkorelasi kuat dengan penundaan usia pernikahan.
7. Memberikan dukungan keuangan dan insentif kepada anak-anak dan keluarga mereka serta mempromosikan program-program pengelolaan pernikahan dini yang disesuaikan dengan budaya kolektif Indonesia. Program intervensi ini diharapkan dapat mencegah pernikahan dini dengan mempertimbangkan faktor yang paling berpengaruh, yaitu budaya kolektif masyarakat. Hal ini ditegaskan karena masih banyak norma budaya di negara ini yang mendorong pernikahan dini. Semoga hal ini dapat membantu mencegah pernikahan dini.

8. Layanan Bimbingan Konseling untuk Mencegah Pernikahan Dini
Konseling Klasik (BK) dapat didefinisikan sebagai layanan bimbingan berbasis kelas, yaitu kepada sejumlah peserta tertentu per kelas, atau sebagai layanan bimbingan yang diberikan oleh seorang guru/konselor bimbingan kepada sejumlah peserta/konseli dalam satu kelas. Layanan KB, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54(6) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, meliputi pemberian perhatian, bimbingan, supervisi, dan supervisi kepada peserta didik.

Layanan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk layanan tatap muka terjadwal di kelas, layanan individual, dan/atau layanan kelompok bagi yang dianggap perlu. Pelaksanaan KB berdasarkan kurikulum 2013 selama ini terdiri dari guru/konselor bimbingan (guru BK/konselor) yang memberikan informasi kepada peserta didik yang membutuhkan untuk mengembangkan potensinya. Materi layanan yang digunakan meliputi modul dan buku teks dengan bahan ajar yang sama dengan yang diberikan oleh guru mata pelajaran, dan pendekatan layanannya menggunakan pendekatan pembelajaran dengan metode pengajaran tunggal. Layanan konseling kelas merupakan layanan preventif yang bertujuan mencegah masalah yang secara spesifik ditargetkan melalui proses proaktif.

Berdasarkan model ASCA (American School Counselors Association), konseling kelas merupakan salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam komponen layanan inti atau kurikulum bimbingan, yang bersifat perkembangan, sistematis, dan terstruktur bagi seluruh siswa. Layanan ini juga merupakan salah satu layanan bimbingan inti, yang dirancang oleh konselor untuk siswa, dilaksanakan dalam suasana kelas terjadwal, dan mengharuskan konselor untuk melakukan kontak langsung dengan siswa/peserta layanan. Kegiatan konseling kelas ini dapat berupa diskusi kelas atau curah pendapat. Layanan ini juga berfungsi sebagai pencegahan, pemahaman, dan pemeliharaan perkembangan serta merupakan proses proaktif yang secara spesifik ditargetkan, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau agama, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Layanan ini disampaikan melalui kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi, sosial, pembelajaran, dan

profesional siswa. Layanan bimbingan dan konseling berbasis kelas, sesuai dengan Permendikbud No. 111, Pasal 6, ayat 4 dan 5, diberikan di kelas secara terjadwal, dengan beban kerja dua (2) jam belajar per minggu untuk setiap kelompok belajar, yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pendekatan layanan-pembelajaran.

Layanan ini memanfaatkan tiga jenis layanan: (1) layanan informasi untuk materi yang terkait dengan teori ilmiah atau dalam bentuk informasi faktual, seperti: permasalahan remaja, perkembangan remaja, motivasi belajar, prestasi belajar, pernikahan dini, dan sebagainya; (2) layanan penguasaan konten untuk mengembangkan dan melatih penguasaan konten yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti: tata krama belajar yang baik, meningkatkan disiplin sekolah, cara berkunjung, cara masuk kantor, cara bersosialisasi yang baik, cara mencatat di kelas, dan sebagainya; dan (3) layanan penempatan, seperti: minat mahasiswa, jurusan, pemilihan keterampilan, pilihan ekstrakurikuler, pilihan pengembangan diri, pemilihan perguruan tinggi, dan jurusanannya. Layanan konseling kelas terkadang terjadi ketika konselor diminta untuk memberikan topik, misalnya, tentang dampak pernikahan dini, harga diri, keterampilan komunikasi, keluarga sehat, resolusi konflik, keterampilan persahabatan, dan pencegahan perundungan.

Dalam konseling kelas, kegiatan harus dikonseptualisasikan ke dalam tahapan yang sama (awal, kerja, akhir) dan bagian yang sama dari setiap sesi (pembukaan, kerja, pemrosesan, penutupan), dan seterusnya, dalam waktu yang jauh lebih singkat. Layanan konseling kelas bertujuan untuk memberikan bantuan kepada semua siswa atau klien melalui kegiatan persiapan terstruktur untuk pengalaman tersebut, sehingga mereka memperoleh kesadaran atau pemahaman tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama, termasuk pernikahan dini), mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau serangkaian perilaku yang tepat untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, mampu memenuhi kebutuhan dan menangani masalah mereka, dan mampu berkembang secara bertumbuh dan produktif. Layanan ini juga memiliki nilai efisiensi dalam kaitannya dengan jumlah siswa.

F. Intervensi Menekan Angka Pernikahan Dini

Beberapa manfaat kesehatan dari menunda pernikahan dini antara lain peningkatan kesehatan perempuan dan anak. Secara keseluruhan, hal ini memberikan bukti kuat tentang peran penting pendidikan, baik bagi perempuan secara individu maupun orang tua mereka, dalam menunda pernikahan dan meningkatkan fertilitas pada perempuan muda. Perempuan usia menikah lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan rumah tangga dibandingkan perempuan usia subur. Perempuan yang cukup dewasa untuk menikah mengalami perubahan pada tingkat individu, terutama didorong oleh usia pernikahan pertama. Seorang perempuan dewasa berinteraksi dengan faktor-faktor struktural untuk menentukan perubahan status dan peran perempuan dalam masyarakat. Pendidikan dan otonomi perempuan telah ditemukan sebagai penentu signifikan pernikahan dini. Oleh karena itu, intervensi kesehatan masyarakat yang menargetkan titik-titik rawan pernikahan dini yang teridentifikasi sangat penting untuk mengurangi insiden pernikahan dini dan konsekuensinya.

Lebih lanjut, meningkatkan pendidikan perempuan dan memberdayakan mereka untuk membuat pilihan sendiri sangat penting untuk mengubah kebiasaan masyarakat dan menghilangkan pernikahan dini. Strategi intervensi seperti paparan media massa telah menunjukkan manfaat dalam mengurangi kehamilan dini dan pernikahan dini, serta meningkatkan retensi sekolah. Pendidikan sebaya telah terbukti menjadi model yang efektif. Oleh karena itu, intervensi komunitas multi-komponen ini dapat menjadi model potensial untuk mengurangi pernikahan dini dan konsekuensinya, mengingat konteks sosial ekonomi dan budaya. Intervensi lain yang direkomendasikan dapat mempertimbangkan posisi sosial para pemimpin agama dan peran penting mereka dalam menyetujui pernikahan; mereka dapat dianggap sebagai mata rantai penting dalam upaya mengurangi pernikahan dini. Para peneliti melakukan 24 diskusi kelompok terfokus dengan remaja, 24 wawancara mendalam dengan para pemimpin agama, dan 12 wawancara dengan informan kunci dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kerangka kerja untuk menganalisis data kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa para pemimpin agama memainkan peran penting dalam merasionalisasi atau mencegah remaja terlibat dalam pernikahan dini. Strategi pemerintah dalam menangani pernikahan dini

adalah dengan melakukan sosialisasi di masyarakat, tetapi belum optimal.

Lebih lanjut, peraturan telah diterapkan, tetapi implementasinya masih belum tegas. Dan penerapan sanksi terhadap pelaku pernikahan dini relatif stabil. Strategi pemerintah untuk meminimalkan pernikahan dini masih suboptimal, sebagaimana dibuktikan oleh maraknya pernikahan dini yang terjadi. Selain kurangnya pemahaman tentang pendidikan masyarakat, upaya represif pemerintah meliputi penerimaan laporan, mediasi dengan orang tua, mediasi dengan anak, manajemen kasus, dan advokasi.

Namun, terdapat faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah, termasuk faktor orang tua, putus sekolah, pendapatan keluarga yang rendah, pelanggaran hukum adat, dan pergaulan bebas. Faktor-faktor yang mendukung upaya pemerintah daerah antara lain dukungan orang tua dan pendidikan anak saat ini, yang mengurangi kemungkinan terjadinya perkawinan anak.

G. Penutup

Pernikahan dini terjadi sebelum usia aktif anak, yaitu <20 tahun. Secara biologis, organ reproduksi anak masih berkembang, sehingga belum siap untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis, apalagi untuk hamil dan melahirkan. Pernikahan paksa dapat mengakibatkan trauma, luka robek yang luas, dan infeksi, yang dapat merusak organ reproduksi dan bahkan membahayakan nyawa janin. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi antara lain keguguran, anemia, perdarahan pascapersalinan, dan preeklamsia bagi ibu, serta berat badan lahir rendah (BBLR) dan kelahiran prematur bagi bayi.

Referensi

- Amalia, A., Dini, A., Fasion, A., Sunarsih, T., & Rahmawati, D. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 9(2), 126–133. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v9i2.1387>
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.33490/b.v4i1.619>
- Lase, F. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–136. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>
- Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2014). Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(2), 95–101. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/view/3976>
- Ningrum, R. W. K., & Anjarwati. (2021). Impact of Early Marriage on Adolescent Women. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 5(1), 37–45. journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandreproduction
- Tika Nur Azizah, Putri Nurfara Gayanti, Egata Ihsanda Sultan, Prastiwi Dwi Rahmawati, Cantika Alyssa Savitri, Marceliazizah Aning Wendari, Vicky Irawan, & Nur Rofiq. (2024). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 213–223. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>
- Tjolly, A. Y., Soetjiningsih, C. H., Studi, P., Psikologi, S., Psikologi, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Dampak Psikologis Remaja yang Hamil diluar Pernikahan. *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 224–237. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0ADampak>
- Widyadhara, A. P., & Putri, T. M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 13(4), 198–205. <https://doi.org/10.52022/jikm.v13i4.79>
- Yastirin Ayu Pintam, Sahara Rizky, & Sehmawati. (2021). Dampak Kesehatan Ibu Pada Kehamilan Remaja. *PBIjournal*, 4, 18–35.
- Zelharsandy, V. T. (2022). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurrahman*, 11(1), 31–39. <https://doi.org/10.55045/jkab.v11i1.136>

Glosarium

Advokasi	Upaya pendampingan dan mediasi untuk memengaruhi kebijakan, layanan, atau keputusan terkait pencegahan pernikahan dini.
Anemia	Kondisi kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah menurun yang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.
Asfiksia	Gangguan pertukaran oksigen pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan kerusakan organ.
BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)	Berat lahir bayi kurang dari 2.500 gram, berisiko infeksi, hipotermia, dan gangguan tumbuh kembang.
BK Klasikal (Bimbingan Konseling Klasikal)	Layanan bimbingan berbasis kelas, terjadwal, untuk pencegahan masalah seperti pernikahan dini.
Dispensasi perkawinan	Izin pengadilan agar individu di bawah usia minimum menikah karena alasan tertentu.
Dwarfisme	Gangguan pertumbuhan yang ditandai perawakan pendek; dalam konteks ini disebut sebagai risiko jangka panjang pada bayi berisiko.
Edema	Pembengkakan jaringan akibat penumpukan cairan, dapat menyertai preeklamsia.
Eklampsia	Kejang pada ibu hamil yang didahului preeklamsia; keadaan gawat darurat obstetri.
GenRe (Generasi Berencana)	Program promosi dan pencegahan pernikahan dini serta edukasi kesehatan reproduksi remaja.
GenRe Embracing	Kegiatan berbagi, konseling, dan pembinaan minat bakat untuk remaja dalam kerangka Program GenRe.
GenRe Media	Diseminasi informasi GenRe melalui media sosial tentang pernikahan dini dan kesehatan reproduksi.
GenRe Mengajar	Edukasi di sekolah mengenai risiko pernikahan dini dan kesehatan reproduksi remaja.
Hiperbilirubinemia	Kadar bilirubin tinggi pada bayi yang memicu ikterus dan membutuhkan pemantauan.
Hipotermia	Suhu tubuh bayi turun di bawah normal, sering terjadi pada BBLR atau prematur.
Ibu remaja	Ibu hamil berusia di bawah 20 tahun, berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi obstetri.
Infeksi neonatal	Infeksi pada bayi baru lahir, risikonya meningkat pada BBLR dan prematur.
Isolasi sosial	Kondisi keterbatasan interaksi sosial yang dapat terjadi pada pasangan muda dan berdampak psikososial.
Jarak kelahiran	Interval antar kelahiran; jarak terlalu pendek meningkatkan risiko obstetri dan neonatal.
Keguguran	Berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan; lebih sering pada kehamilan remaja.

Kelahiran prematur (Prematuritas)	Persalinan sebelum 37 minggu kehamilan, meningkatkan morbiditas dan mortalitas neonatal.
Kematangan biologis, psikologis, sosial	Kesiapan fisik, mental, dan sosial untuk menikah dan hamil; belum optimal pada remaja.
Kematian maternal	Kematian ibu selama hamil, persalinan, atau nifas akibat sebab terkait kehamilan.
Kematian perinatal	Kematian janin akhir kehamilan hingga satu minggu pertama kehidupan.
Ketimpangan gender	Ketidaksetaraan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, diperburuk oleh pernikahan dini.
Layanan informasi (BK)	Pemberian informasi faktual di kelas terkait topik seperti pernikahan dini dan kesehatan reproduksi.
Layanan penguasaan konten (BK)	Pelatihan keterampilan praktis yang dibutuhkan siswa, misalnya keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan.
Layanan penempatan (BK)	Bimbingan penentuan minat, jurusan, atau pilihan pengembangan diri yang sehat bagi siswa.
Life skills (keterampilan hidup)	Keterampilan kesehatan, gizi, keuangan, komunikasi, negosiasi, dan keputusan untuk kemandirian remaja.
Materi ajar konseling kelas	Modul tambahan tematik tentang dampak pernikahan dini, disesuaikan budaya dan usia siswa.
Model ASCA	Kerangka bimbingan konseling sekolah yang komprehensif, sistematis, dan berfokus pada pencegahan.
Paritas	Jumlah persalinan yang pernah dialami seorang perempuan.
Peer support	Jaringan dukungan sebaya bagi remaja dan keluarga rentan untuk berbagi pengalaman dan menguatkan penolakan pernikahan dini.
Pendidik sebaya	Remaja yang dilatih untuk menyampaikan informasi dan dukungan kepada teman sebaya.
Perabdominal (Seksio sesarea)	Persalinan melalui pembedahan dinding perut dan rahim.
Perdarahan pascapersalinan (PPH)	Kehilangan darah berlebih setelah melahirkan, penyebab utama kematian ibu di negara berkembang.
Perkawinan anak / Pernikahan dini	Pernikahan sebelum kedewasaan fisik dan mental, umumnya perempuan <20 tahun dan laki-laki <25 tahun.
Pernikahan paksa	Pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan bebas kedua pihak, sering berlandung pada alasan adat atau stigma.
Persalinan pervaginam	Persalinan melalui jalan lahir alami.
Preeklamsia	Hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai proteinuria dan/atau edema, berisiko bagi ibu dan janin.
Prematuritas	Lihat kelahiran prematur.
Primipara	Perempuan yang menjalani persalinan pertama kali.
Proteinuria	Ditemukannya protein dalam urin, salah satu penanda preeklamsia.
Psikoedukasi	Edukasi berbasis psikologi untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat agar menolak pernikahan dini.

Remaja tangguh	Profil remaja yang berperilaku sehat, menunda nikah, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Retensio plasenta	Tertundanya pelepasan plasenta setelah bayi lahir yang meningkatkan risiko perdarahan.
Stunting	Gagal tumbuh kronis akibat kekurangan gizi jangka panjang; pernikahan dan kehamilan dini meningkatkan risikonya.
Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad KRR)	Tiga isu utama pada remaja: seksualitas, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan NAPZA.
Usia ideal menikah (BKKBN)	Rekomendasi 20–35 tahun bagi perempuan dan 25–40 tahun bagi laki-laki untuk kesiapan biologis, psikologis, dan sosial.

Profil Penulis



Bdn. Elis Fatmawati, SST., M.Tr.Keb., CHt.HBirth

Lahir di Lamongan, 12 Juli 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik di STIKes Insan Unggul Surabaya pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 STIKes Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 mejadi Asisten Dosen, selanjutnya sampai saat ini penulis bekerja di STIKes Husada Jombang mengampu mata kuliah Asuhan Komplementer, Berfikir Kritis dalam Kebidanan, Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam

berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: elis.fatmawati1207@gmail.com

Motto: *sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat*



Bdn. Nur Ummul Khairat, S.Tr.Keb., M.Keb.

Lahir di Makassar, 16 November 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan di Akademi Kebidanan Pelamonia tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Universitas Megarezky dan lulus tahun pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan Kembali Pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin dan lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 menjadi bidan di pelayanan di Puskesmas Pattingalloang dan di Klinik Ibu dan Anak Restu kurang lebih 5 tahun. Saat ini penulis bekerja di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar mengampu mata kuliah Askeb Pranikah &

Prakonsepsi, Kehamilan dan juga mengampu mata kuliah Manajemen Krisis dimana itu menjadi penciri dari kampus kami. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar serta ikut berpartisipasi menjadi pengawas lokal untuk ujian UKOM.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: comnurummulkhaerat@gmail.com

Motto: "Apa yang kita usahakan sekarang akan sejalan dengan hasil yang baik"

Profil Penulis



Nur Fadri Nilakesuma, Bd.,M.Keb.

Lahir di Padang, 23 Oktober 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Bidan pada Program Studi Pendidikan Bidan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sebagai bidan pelaksana di RSIA di Kota Padang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mercubaktijaya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Teknik dan dasar Konseling, Komplementer Ibu dalam Asuhan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurfadriink@gmail.com

Motto: "Man Jadda Wa Jadda" (siapa yang bersungguh – sungguh akan berhasil).

Anita Dewi Anggraini, S.Keb.,Bd.,M.Kes

Lahir di Madiun, 26 Januari 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada Program Studi Pendidikan Bidan, Universitas Airlangga dan lulus tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 jurusan kesehatan masyarakat dengan peminatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Universitas Airlangga, dan lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali sejak tahun 2019 sebagai praktisi bidan dan asisten peneliti. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bhakti Husada Mulia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat.



Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anitadewi044@gmail.com

Motto: "Never give up and be the best of the best"

Profil Penulis



Evi Yanti, SKM., M. Kes

Lahir di Lhokseumawe, 05 Mei 1979. Sejak tahun 2008 Penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan saat ini penulis aktif mengajar di Universitas Bumi Persada Aceh (UNBP). Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal lainnya.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sampai dengan sekarang

masih aktif bekerja sebagai Dosen pada Universitas Bumi Persada

Penulis dapat dihubungi melalui email eviyanti52@gmail.com

Motto: Jangan pernah bosan membaca .membaca membuat kita banyak tau dan mengerti karena membaca merupakan jendela ilmu, Mari buka jendela untuk update ilmu.



Bayti Jannah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Lahir di Bima, 07 Maret 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akbid Harapan Bunda Bima Tahun 2015, S1 pada Program Studi Kebidanan di Universitas Kadiri Tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 sampai sekarang di Akbid Harapan Bunda Bima mengampu mata kuliah Asuhan Kehamilan, KDPK, Dokumentasi Kebidanan, Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan anak pra sekolah, dan teknologi informasi kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat dan penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: baytijannah707@gmail.com

Motto: "Stay true to yourself"

Sinopsis

Buku Referensi “Deteksi Dini dan Patologis dalam Siklus Pranikah dan Prakonsepsi” merupakan referensi komprehensif yang membahas upaya sistematis dalam mengenali dan mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi sejak sebelum kehamilan. Fokus utamanya adalah penguatan kesiapan calon pasangan melalui skrining kesehatan, intervensi gizi, serta edukasi psikologis yang berkesinambungan.

Bab pertama menguraikan asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, termasuk pentingnya konseling kesehatan reproduksi, edukasi berbasis keluarga, dan penerapan model komunikasi efektif oleh bidan. Bab kedua membahas deteksi dini penyakit kronis dan status kesehatan umum, seperti hipertensi, diabetes, gangguan tiroid, dan kelainan genetik yang dapat memengaruhi keberhasilan kehamilan. Bab ketiga menyoroti anemia dan masalah gizi prakonsepsi, serta strategi intervensi gizi seimbang dan suplementasi mikronutrien penting seperti zat besi dan asam folat. Bab keempat mendalami gangguan menstruasi dan kesuburan, termasuk amenore, PCOS, dismenore, dan hubungan faktor hormonal terhadap fertilitas. Bab kelima menekankan kesehatan mental pranikah dan prakonsepsi, dengan fokus pada deteksi dini depresi, kecemasan, stres pranikah, serta penerapan edukasi coping stress bagi calon pasangan. Bab keenam membahas dampak pernikahan dini terhadap kesehatan kehamilan, mencakup risiko biologis, psikologis, dan sosial bagi ibu dan bayi, serta strategi intervensi pencegahan berbasis komunitas.

Dengan pendekatan interdisipliner, buku ini tidak hanya menekankan aspek medis, tetapi juga dimensi psikologis, sosial, dan edukatif dalam praktik kebidanan. Setiap bab dilengkapi dengan referensi ilmiah terkini, glosarium istilah penting, dan penerapan klinis yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Buku ini layak menjadi rujukan utama bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam memahami dan mengimplementasikan deteksi dini pranikah serta prakonsepsi, guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas komplikasi sejak sebelum kehamilan.

Buku Referensi “Deteksi Dini dan Patologis dalam Siklus Pranikah dan Prakonsepsi” merupakan referensi komprehensif yang membahas upaya sistematis dalam mengenali dan mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi sejak sebelum kehamilan. Fokus utamanya adalah penguatan kesiapan calon pasangan melalui skrining kesehatan, intervensi gizi, serta edukasi psikologis yang berkesinambungan.

Bab pertama menguraikan asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, termasuk pentingnya konseling kesehatan reproduksi, edukasi berbasis keluarga, dan penerapan model komunikasi efektif oleh bidan. Bab kedua membahas deteksi dini penyakit kronis dan status kesehatan umum, seperti hipertensi, diabetes, gangguan tiroid, dan kelainan genetik yang dapat memengaruhi keberhasilan kehamilan. Bab ketiga menyoroti anemia dan masalah gizi prakonsepsi, serta strategi intervensi gizi seimbang dan suplementasi mikronutrien penting seperti zat besi dan asam folat. Bab keempat mendalami gangguan menstruasi dan kesuburan, termasuk amenore, PCOS, dismenore, dan hubungan faktor hormonal terhadap fertilitas. Bab kelima menekankan kesehatan mental pranikah dan prakonsepsi, dengan fokus pada deteksi dini depresi, kecemasan, stres pranikah, serta penerapan edukasi coping stress bagi calon pasangan. Bab keenam membahas dampak pernikahan dini terhadap kesehatan kehamilan, mencakup risiko biologis, psikologis, dan sosial bagi ibu dan bayi, serta strategi intervensi pencegahan berbasis komunitas.

Dengan pendekatan interdisipliner, buku ini tidak hanya menekankan aspek medis, tetapi juga dimensi psikologis, sosial, dan edukatif dalam praktik kebidanan. Setiap bab dilengkapi dengan referensi ilmiah terkini, glosarium istilah penting, dan penerapan klinis yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Buku ini layak menjadi rujukan utama bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam memahami dan mengimplementasikan deteksi dini pranikah serta prakonsepsi, guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas komplikasi sejak sebelum kehamilan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



Optimal
Untuk
Negeri



optimal



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



ISBN 978-634-7426-30-7



9

786347

426307